

REPÚBLICA DE CUBA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

CENTRO DE REFERENCIA LATINOAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL

**UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL DE
ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL EN EL CENTRO
DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN (CDO)**

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

AUTOR: MSC. MIRTHA LEYVA FUENTES

LA HABANA

2012

REPÚBLICA DE CUBA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

CENTRO DE REFERENCIA LATINOAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL

**UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL DE
ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL EN EL CENTRO
DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN (CDO)**

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

AUTOR: MSC. MIRTHA LEYVA FUENTES

TUTORES: DR. C. SVETLANA A. AKUDOVICH

DR. C. MARIA TERESA FERRER MADRAZO

PROFESORA TITULAR Y DE MÉRITO

LA HABANA

2012

AGRADECIMIENTO

Agradezco muy especialmente:

- Las acertadas críticas y las muchísimas y oportunas sugerencias de mi tutora Dr. C. Svetlana A. Akudovich.
- La sagacidad, la mirada experta, la pregunta oportuna que me obligó a pensar, las críticas, los regaños, las sugerencias, la aprobación y reconocimiento solo si tenían lugar, pero sobre todo: la ayuda, el apoyo y la confianza en mi (que no merezco) de mi querida tutora Dr. C. María Teresa Ferrer Madrazo.
- Que me eligiera, primero para el proyecto y luego para esta línea investigativa que abracé para siempre; así como, las oportunas críticas y sugerencias que me brindó durante sus acciones como oponente en el ejercicio de pre defensa, de mi querida Jefa de proyecto y oponente Dr. C. Sonia guerra Iglesias.
- La suerte de que me asignaran como oponente a la Dr. C. Basilia Collazo Delgado en el ejercicio de pre defensa, eso me permitió conocerla, desde el silencio de quien sabe bien escuchar, pero está dotada de perspicacia para indagar más allá del informe escrito y hacer que salgan a flote los valores ocultos, sin dejar de lado la crítica oportuna, firme y justa.
- A mi querido Dr. C. Santiago Borges, porque gracias a él comencé en el doctorado curricular, lo que adquiere insignificancia ante, el apoyo, la exigencia, la crítica y la confianza en mí que vinieron después.
- A todos los profesores de la UCPEJV, el ICCP, el IPLAC, el CELAEE u otras instituciones, sin los cuales no habría llegado hasta aquí.
- A mis familiares y amigos, que me alentaron o ayudaron.
- A todos mis compañeros de la escuela formadora Fulgencio Oroz Gómez, sobre todo a Yasser. A todos ¡GRACIAS!

DEDICATORIA

A los niños con retraso mental y sus familias

A mis hijas, porque son mi razón de ser

A mi papá porque es mi ídolo, más que eso: mi ejemplo.

A mi sobrina Thais Liset

A todos los que me incitaron, apoyaron o entorpecieron en este proceso, cada uno
suscitó en mí el deseo de seguir adelante.

A mi familia.

SÍNTESIS

La presente investigación surge de la necesidad de brindar respuesta al problema de las carencias que experimenta el proceso de diagnóstico psicopedagógico de escolares con indicadores de retraso mental, dirigido por los Centros de Diagnóstico y Orientación; a los que se les ha conferido su dirección.

Estas carencias se revelan en el resultado del proceso y hacen que la atención educativa que de este proceso se deriva, no se adecue suficientemente a las necesidades de este grupo de escolares y de sus familias.

En vista de ello, se propone un modelo de diagnóstico psicopedagógico, en cuyos fundamentos se integran elementos filosóficos, sociológicos, biológicos, psicológicos y pedagógicos, así como otros específicos de la actividad diagnóstica de carácter teórico y metodológico. Todo ello sustenta los componentes y sus relaciones, que desde una postura electiva coloca en su esencia la aplicación del enfoque histórico-cultural.

El tratamiento del problema y del objeto de estudio parte de un análisis dialéctico que permiten la parametrización del proceso de diagnóstico psicopedagógico de escolares con indicadores de retraso mental, para su estudio; mediante el cual se explica la necesidad de proponer el modelo.

Su sistematización en la práctica demuestra la factibilidad e indica que su aplicación coadyuva a la solución del problema investigado. Además se pone de manifiesto que este grupo de niños posee, sin dudas, peculiaridades y regularidades que es necesario identificar y que depende de ello la calidad de la atención educativa integral que requieren.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO 1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO A ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL EN LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN	11
1.1 Marco teórico metodológico el diagnóstico psicopedagógico en Cuba	11
1.2 Precisiones conceptuales, terminológicas y metodológicas del diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental	32
1.2.1 Evolución conceptual del retraso mental en el mundo	32
1.2.2 Evolución conceptual del retraso mental en Cuba	34
1.2.3 El proceso de diagnóstico del retraso mental. Antecedentes en el mundo y en Cuba.....	38
CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL DEL RETRASO MENTAL	45
2.1. Modelo actuante del diagnóstico psicopedagógico	45
2.2. Determinación de variable, dimensiones e indicadores para la evaluación del proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de posible retraso mental	54
2.3 Exploración empírica del modelo actuante	59
CAPITULO 3. MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO DE ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL EN EL CDO	75
3.1 Fundamentación y estructura del modelo para el diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental en el CDO	75
3.2 Análisis de los resultados obtenidos en sistematización de experiencias en la práctica del modelo de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental	106
CONCLUSIONES	119
RECOMENDACIONES	120
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

El retraso mental no sólo es un problema educacional médico y científico, sino cardinalmente social; pues en cada período del desarrollo cultural es la sociedad el factor que ejerce el papel determinante a la hora de clasificar *quienes pertenecen* al grupo, *qué* tratamiento es necesario prodigarles y bajo *qué* métodos conducirles. Es por ello que el enfoque general del proceso de diagnóstico del retraso mental debe ser considerado inherente a cada grupo social, región o país de que se trate y por esta razón no ha de convertirse en un esquema fijo para todos los tiempos.

En el ámbito internacional, ya desde la década de los 90, el diagnóstico del retraso mental comenzó a dar muestra de mayor consenso así como de más masividad, mediante el funcionamiento de la Asociación Americana sobre Retraso Mental, (AARM) hoy renombrada Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, conocida por sus siglas en inglés (AAIDD). Que desde su fundación ha tratado de cumplir con el propósito de formular y difundir, a lo largo de más de 80 años, manuales e información sobre el retraso mental y su diagnóstico. Se reconoce a los resultados de la AAIDD como *importante antecedente investigativo* a nivel internacional; si embargo se considera desacertado asumir literalmente sus propuestas, a fin de aplicarlas en Cuba, ya que no existe total coincidencia, en el orden filosófico, respecto al punto de vista que se maneja a nivel de país, ni con el de la autora; Asimismo se valora pertinente considerar algunos puntos contenidos en sus resultados que se ajustan a la presente investigación. Un elemento coincidente resulta concebir el desarrollo humano en tres niveles: biológico, psicológico y social,

interrelacionados y bajo la influencia de factores contextuales cuya finalidad en el proceso de diagnóstico es *determinar recursos, apoyos y respuestas educativas*. Esta posición Cuba la ha mantenido desde hace varias décadas y continúa abordando estos elementos desde la teoría en la práctica habitual del diagnóstico.

Cuba cuenta con una concepción teórica para el diagnóstico psicopedagógico con fuertes pilares dialéctico materialista e histórico culturales, desde los cuales se erigen la práctica de diagnóstico en el ámbito educacional, su devenir y las investigaciones que históricamente han coadyuvado a su enriquecimiento. Constituyen fuente apreciable de la investigación las experiencias de psicólogos y pedagogos cubanos, quienes durante la última década se han ocupado con tesón de investigar acerca del proceso de diagnóstico o del retraso mental. Figuran entre ellos los especialistas Álvarez, C. (1999); Rivero, M. (2002); Akudovich, S. (2004); Oliva, L. (2004); Guirado, V. (2004); Guerra, S. (2005); de la Peña, N. (2005); Bordon, M.L. (2007); Hechavarría, M. (2007); Travieso, E. (2008). Algunas investigaciones estuvieron dirigidas al diagnóstico de la zona de desarrollo próximo, unas mediante el uso de metodicas, otras con arreglo a su expresión en grupos específicos como el de escolares con retraso mental; otras abarcaron la superación de especialistas de los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO), una para pedagogos y psicopedagogos, otras para trabajadores sociales o psicometristas.

Las investigaciones que han profundizado en el retraso mental, abordaron los elementos siguientes: el aprendizaje de una u otra asignatura, la influencia de la modelación en el desarrollo intelectual, la atención educativa integral a infantes con

indicadores de posible retraso mental; otras afrontaron diferentes procesos que se dan con arreglo a la expresión en este grupo, tales como: la preparación laboral, la vida adulta independiente y la sexualidad. Un último grupo investigó la introducción en la realidad educativa de modelos, estrategias, indicadores y concepciones didácticas, indagaciones que no abordan en específico *el proceso de diagnóstico a escolares con indicadores de retraso mental*; pero que sin su concurso no habría sido posible esta investigación pues aportan elementos teóricos y metodológicos relacionados con el objeto que se investiga.

El diagnóstico como proceso en el ámbito educacional cubano ha evolucionado desde un enfoque predominantemente clínico y biológico hacia el enfoque psicopedagógico, ya no tan reciente. En él se propone como centro al sujeto y a los servicios y apoyos que requiere. Se incluye la intervención, o sea, el diseño de la respuesta educativa y la provisión de apoyos, todo lo cual avala un cambio cualitativamente superior en su evolución.

Pese a reconocer las debilidades, fortalezas y los innumerables pasos de avance respecto a los cambios en la labor que realizan los Centros de Diagnóstico y Orientación, la realidad educativa cubana y dentro de ella la práctica de diagnóstico, revela la necesidad de profundizar teóricamente e introducir los agentes generadores de cambio necesarios para elevar la calidad del diagnóstico psicopedagógico y lograr la aplicación adecuada de la concepción psicopedagógica que la sustenta. Para ello el trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación, que desde el 2000 enfrenta el reto de lograr su fortalecimiento, incluye una serie de investigaciones en curso con la

finalidad de dar continuidad a los logros y enfrentar los desafíos respecto a los elementos que así lo requieren.

Una arista aún no tratada es el proceso de diagnóstico psicopedagógico que se realiza a los escolares con indicadores de retraso mental. Desde la teoría se carece de algunos elementos que relacionen la multidimensionalidad de expresión del retraso mental con su abordaje diagnóstico, en la práctica, por tanto, aún no se afrontan todas las dimensiones que caracterizan esta entidad.

Tras analizar los antecedentes y tomar en cuenta los resultados de proyectos e investigaciones y la experiencia de la autora con escolares con retraso mental y como especialista de los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO) se pudo conformar la siguiente **SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**.

- Es insuficiente el nivel de diferenciación que se logra en el proceso de diagnóstico psicopedagógico respecto al grupo de escolares con indicadores de retraso mental, lo que explica la tendencia a homogeneizar las caracterizaciones y la respuesta educativa.
- Se acentúan los elementos de orden académico en detrimento de la preparación para la vida adulta independiente y de las habilidades prácticas y sociales imprescindibles para orientar la atención educativa integral de estos escolares.
- En el diagnóstico psicopedagógico se aprecia un desbalance entre el abordaje de las dificultades frente a las potencialidades que deben derivarse de la dinámica causal para poder explicar el diagnóstico.

- Fallas en la articulación entre los diferentes momentos y escenarios del diagnóstico.

En este orden, se impone una profundización que conlleve a resolver la *contradicción* que se revela entre *la concepción teórico metodológica para la atención educativa integral a los escolares con retraso mental*, frente a *la calidad del diagnóstico revelada en la atención educativa integral resultante*.

Así se identificó el siguiente **PROBLEMA CIENTÍFICO**: ¿Cómo favorecer el proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO?

Se determina como **OBJETO** de investigación el proceso de diagnóstico psicopedagógico y como **CAMPO DE ACCION** el diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO.

En correspondencia, se formula el siguiente **OBJETIVO**: Proponer un modelo para el proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO.

Su alcance presupone dar respuesta a las siguientes **PREGUNTAS CIENTÍFICAS**:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO?
2. ¿Cuál es el estado actual del proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO?

3. ¿Qué estructura y contenidos debe tener un modelo para el proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO?
4. ¿Cuál es la factibilidad del modelo para el proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO?

Para solucionar estas interrogantes fue necesario realizar las siguientes **TAREAS DE INVESTIGACIÓN:**

1. Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO.
2. Caracterización del estado actual del proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO.
3. Elaboración de un modelo para el proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO.
4. Valoración de la factibilidad del modelo propuesto.

Desde una concepción dialéctico – materialista asumida por la autora y que sustenta la presente investigación, los **métodos** seleccionados para desarrollarla, estuvieron determinados por el objetivo y las tareas de investigación previstas.

Al nivel **teórico** se emplearon:

Análisis documental: permitió realizar el análisis de documentos normativos, resoluciones ministeriales, planes de estudio y programas de la escuela especial para alumnos con retraso mental, de las líneas de desarrollo de la especialidad, entre

otros, que permitieron durante el abordaje teórico dilucidar los elementos que fundamentan el objeto de investigación.

Histórico-lógico: posibilitó la aproximación a la evolución histórica del diagnóstico en el ámbito internacional y de Cuba y, en particular, del proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO.

Análisis y síntesis: permitió revelar las regularidades y tendencias de diversos enfoques sobre diagnóstico en el ámbito educativo y sus relaciones, así como determinar las características del objeto de investigación.

Modelación. se utilizó en el diseño de la representación gráfica del modelo para el proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en el CDO, en tanto permitió reflejar en el nivel teórico sus fundamentos y relaciones entre la multidimensionalidad del retraso mental y del diagnóstico y en el nivel práctico, sus objetivos, fases de ejecución y etapas para la implementación.

Dentro de las **indagaciones empíricas** se destacan:

El estudio de documentos: permitió extraer los elementos necesarios para el análisis del modelo actuante a partir del estudio de documentos como los escritos de trabajo de los CDO, los informes, sistemas de apoyos, expedientes psicopedagógicos, de los planes de clases; para complementar el estado actual del objeto de investigación y el campo de acción.

Observación: permitió constatar en la práctica el estado del proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental.

Encuesta: proporcionó datos importantes con relación al estado de conocimiento que tienen los especialistas de los CDO, los docentes de escuelas primarias y especiales, con el fin de caracterizar los modos de actuación e identificar sus principales carencias cognoscitivas y prácticas.

Consulta a expertos: para obtener su criterio sobre la significación, pertinencia, relevancia y factibilidad del modelo para el proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental en el CDO.

Sistematización en la práctica: posibilitó la obtención de valoraciones empíricas de la factibilidad del modelo propuesto a partir de la interpretación de los resultados de la experiencia práctica llevada a cabo con este fin y prevista en las etapas para la implementación, así como para la elaboración de conclusiones parciales que contribuyeron al perfeccionamiento continuo del mismo. Incluyó capacitación a especialistas, implementación del modelo y talleres de opinión crítica y construcción colectiva.

Triangulación metodológica: se utilizó en la comparación de los resultados obtenidos a través de diferentes fuentes y métodos e instrumentos que caracterizaron el proceso de diagnóstico psicopedagógico, para valorar la factibilidad del modelo propuesto.

Y los **métodos matemáticos**, tales como el análisis porcentual que permitió cuantificar los resultados de las técnicas aplicadas, el Delphi para la consulta a expertos, y métodos de la estadística descriptiva como las medidas de tendencia central (Media aritmética)).

La **NOVEDAD** de esta tesis está dada en la profundización y especificidad de abordaje acerca del diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental. Se inserta en el Programa Ramal No.2. “Educación Especial” y a los proyectos asociados “Atención educativa integral a escolares con retraso mental” y “Diagnóstico, diversidad y potenciación del desarrollo” dirigidos por el CELAEE en los cuales la aspirante es investigadora.

La **CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA** está dada en la concepción y fundamentación de un modelo para el diagnóstico psicopedagógico integral de los escolares con retraso mental desde el CDO, en el que se destaca el enfoque socio-histórico-cultural como sustento de un criterio multidimensional del retraso mental que orienta la atención educativa, a partir de la relación entre los sujetos participantes, los contextos y el sistema de apoyos.

La **SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA** de esta tesis radica en que el modelo propuesto es de utilidad práctica para los especialistas de los Centros de Diagnóstico y Orientación al constituir muy probablemente, referente teórico-metodológico en la actividad de diagnóstico psicopedagógico para la atención educativa integral a escolares con indicadores de retraso mental. Se revela además en la concepción de los cursos de capacitación y manual dirigidos a estos especialistas, elaborados durante la investigación.

La tesis está estructurada de la siguiente manera: en el **primer capítulo** se aborda los fundamentos del proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental. Constituyen tópicos de análisis por la autora, en esta parte del

informe, los aspectos referentes al marco conceptual del diagnóstico psicopedagógico que presenta como una sistematización. Además se trabaja el devenir histórico del modo en que se ha realizado el diagnóstico del retraso mental. En el **segundo capítulo** se presenta la exploración empírica del estado actual del problema, se construye y describe el modelo actuante y se exponen las valoraciones de la autora a partir de las regularidades encontradas. El **tercer capítulo** persigue el objetivo de presentar el modelo propuesto para el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental en los CDO. Recoge los componentes del modelo y sus relaciones internas, así como la metodología para su implementación práctica y las valoraciones acerca del proceso de valoración de factibilidad. En las **conclusiones** se precisan las ideas a las que se arriba en esta investigación. Posteriormente se plantean las **recomendaciones** que se generan de estas esencias.

La investigación que se presenta se ha socializado en los espacios de intercambio con miembros no permanentes y/o usuarios de los proyectos nacionales, en diferentes momentos y regiones del país. Se ha publicado de manera parcial en la colección “*Perspectivas*” generalizada por el Ministerio de Educación (MINED) a todo el país, en los tabloides correspondientes a los cursos dedicados al diagnóstico y al retraso mental en la Maestría en Ciencias de la Educación y en el libro “El trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación. Concepciones básicas de actualidad”.

CAPITULO I CONSIDERACIONES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO A ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL EN LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN

1.1 Marco Teórico metodológico para el proceso de diagnóstico psicopedagógico en Cuba

La concepción que existe en Cuba para la educación de todas las personas se concreta en la pedagogía cubana actual e incluye el proceso de transformaciones que dentro de ella tiene lugar. Tiene sus basamentos en los preceptos de la ideología marxista leninista.

Con el triunfo revolucionario en 1959, la creación del sistema de educación y del subsistema de Educación Especial en 1962, el sistema de salud, diferentes instituciones, de manera conjunta, han participado en el decurso de los modos y prácticas de diagnóstico. Por ello la historia del diagnóstico para la educación de los escolares en el país ha estado marcada por el contexto socio-histórico y político en que se ha desarrollado la evolución del pensamiento científico, así como también por los momentos más significativos que ha atravesado la Revolución Cubana, que han constituido génesis y motivo para las diversas transformaciones realizadas; a partir de ser Cuba una sociedad que suscita el desarrollo individual de todos sus miembros, por los *principios de justicia social y equidad* que enarbola. En este sentido, apoya, planifica y propicia que se ejecuten programas que contribuyan al desarrollo de las ciencias en cualquiera de sus ramas.

La concepción cubana de diagnóstico psicopedagógico parte de los postulados que distinguen la Escuela Histórico-Cultural de L. S. Vigotsky y sus seguidores en el campo de la psicología, la cual tiene hoy día, un corolario que sobrepasa su origen geográfico y se ha extendido a múltiples naciones.

El diagnóstico psicopedagógico ha venido evolucionando a la par de la Pedagogía cubana y con indisoluble vínculo con la psicología como su fundamento necesario, en tanto su objeto es justamente el desarrollo integral de la personalidad de los infantes y/o jóvenes que conforman el universo educativo. A lo largo del desarrollo de ambas ciencias el diagnóstico ha tenido que superar aquellas tendencias tradicionales que han dirigido su interés, con mayor énfasis, a la esfera cognoscitiva del hombre y su relación con los aspectos clínicos biológicos.

Se considera necesario tomar como punto inicial las referencias teóricas sobre la personalidad y su formación. Para ello los fundamentos marxistas son ineludibles, sobre todo los aportes de L. S. Vigotsky. Sus postulados no sólo son aplicables a disímiles aristas de la psicología, sino que sirven de base a concepciones de otras ciencias como las pedagógicas.

La definición marxista de personalidad lo ilustra cuando plantea: *“Ser humano con sus cualidades socialmente condicionadas e individualmente expresadas...la personalidad no puede ser portadora de propiedades innatas, y en última instancia, está históricamente determinada por el régimen vigente de la sociedad...La personalidad es un conjunto concatenado de rasgos y particularidades internas del hombre a través de las cuales se refractan todos los influjos exteriores....”*¹

De ahí que entender la personalidad científicamente, revelar las leyes de su origen y desarrollo, solo se consigue al centrarse en el todo concreto, es decir, en la unidad de fenómenos disímiles de interacción de los hombres como una formación histórica y cultural creada por la propia *actividad* humana, de producción y transformación de su realidad.

La característica principal de la actividad es su carácter objetal, La investigación de los elementos constitutivos de este tipo de actividad, su estructura sistémica y la unidad estructural entre la actividad externa, práctica y la interna, psíquica fue desarrollado por Leontiev, A. N. (1967) y sus colaboradores. Posteriormente Galperin, P. Ya realizó un estudio más detallado de las etapas en la formación de la actividad interna a partir de la externa, el papel de cada uno de los momentos funcionales de la actividad (orientación, ejecución y control) y de las transformaciones que sufre la acción en este proceso, de gran vigencia contemporánea y aplicabilidad pedagógica.

Vigotsky² enunció leyes psicológicas de gran importancia por su vigencia imperecedera. Para concebir e implementar el diagnóstico psicopedagógico es ineludible el abordaje de las mismas, comenzando por la *ley genética del desarrollo cultural*, donde él plantea que *“toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos: primero, en el social, después, en el psicológico; primero, entre las personas, como categoría interpsíquica; después, dentro del niño, como categoría intrapsíquica”*

¹ Diccionario Filosófico. Rosental. M. y Lludin. P. Ed. Juan Marinello. 1981. p. 359, 360.

² Vigotsky L. S. (1995) Obras completas. T. V. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1995.

Y añadía: *“Hacia dentro del sistema psicológico del niño se traslada la estructura de las relaciones sociales”*; es decir, el niño establece sus relaciones durante su actividad de juego, en su interacción con los adultos que le rodean, en su actividad escolar, a través de las acciones que tienen para él inicialmente un carácter externo y mediante un proceso de interiorización va haciendo suyas tales acciones hasta que quedan incorporadas en su psiquis.

Estos procesos de interiorización están integrados con los de exteriorización en los que el hombre, conscientemente se plantea objetivos, selecciona los medios, organiza su actividad. Las estructuras internas de la acción se extienden en correspondencia con estos objetivos, convirtiéndose así nuevamente en *acciones externas*, pero transformadas por el carácter creador de la conciencia y por las experiencias y particularidades personales del individuo.

Algunos principios en la obra de Vigotsky trascienden el campo psicológico y establecen las bases para una pedagogía de carácter progresista y transformador.

El principio filosófico del historicismo en el desarrollo de la psiquis humana: no solo subyace en la propia denominación de la escuela fundada por él, sino que constituye su esencia; plantea que la psiquis se conforma a partir de las leyes del desarrollo histórico social. A lo largo de la historia de la humanidad el hombre va cambiando los modos de su conducta, se crean nuevas formas de interacción en correspondencia con la cultura de cada época y con los instrumentos empleados en la actividad.

Si la acción social externa se interioriza para conformar las estructuras de la psiquis, las transformaciones en la cultura y en los instrumentos tienen necesariamente que incidir en los cambios progresivos, en el desarrollo de la psiquis. Por lo tanto, la psiquis humana, además de un resultado de las influencias de leyes naturales del desarrollo, tiene que ser el producto, *principalmente*, de las leyes del devenir histórico-cultural de la humanidad. Un ejemplo para ilustrar estas ideas es la representación acerca del mundo en un niño europeo contemporáneo frente a la de un niño latinoamericano, cubano, incluso, a la representación del niño en la edad de piedra, la edad media y el siglo XX. Cada una de ellas diferente, histórico y culturalmente condicionadas aunque individualmente manifiesta.

Por consiguiente, la valoración del desarrollo individual requiere de una visión contextualizada, que tenga en cuenta la historia individual, el medio en el que se está formando el sujeto que se valora. Desde esta óptica el diagnóstico psicopedagógico tiene un basamento en los principios marxistas y vigotskianos. En la lucha por la consecución y el perfeccionamiento del tratamiento diferenciado en la educación, la observación de este principio también resulta de una importancia cardinal, al tener en cuenta la finalidad del diagnóstico psicopedagógico orientado a una mejor atención educativa que coadyuve a un acercamiento acertado a tales objetivos de la pedagogía.

Otro principio cuya aplicación pedagógica revolucionó las ciencias pedagógicas es la posición de Vigotsky acerca del *carácter integral del psiquismo humano*, que lo llevó a revelar el principio de las *relaciones entre lo afectivo y lo cognitivo*, dos

esferas que tradicionalmente se habían visto separadas en la psicología y pedagogía tradicionales. Vigotsky³ señala: *"La primera cuestión que surge cuando hablamos de la relación del pensamiento y el lenguaje con respecto a los restantes aspectos de la conciencia, es el de la vinculación entre la inteligencia y el afecto. Como se sabe, la separación del aspecto intelectual de nuestra conciencia y del aspecto afectivo, volitivo, es uno de los defectos fundamentales y radicales de toda la psicología tradicional..."* De lo anterior se infiere que en toda idea se encuentra contenida y reelaborada una relación afectiva del hombre hacia la realidad representada en esa idea. Para Vigotsky lo afectivo no se limita sólo a los sentimientos, sino que abarca otros aspectos igualmente importantes como son las motivaciones, propósitos, emociones, vivencias. Esta relación adquiere una importancia capital para los pedagogos, luego expresa una de las claves para el desarrollo y fortalecimiento de valores desde el propio proceso docente-educativo.

Innumerables conceptos de la obra vigotskiana adquieren doble valor por su carácter referencial y aplicabilidad pedagógicas; sin embargo, es inobjetable la importancia y prioridad que tiene el análisis del concepto aprendizaje. Para él aprendizaje no es una actividad únicamente individual, como han tratado de explicar los psicólogos tradicionales, sino que constituye una actividad de *carácter social* en la cual el individuo asimila los modos sociales de actividad y de interacción y más adelante, como adulto, los fundamentos del conocimiento científico en condiciones

³Vigotsky, L. S. (1982) Pensamiento y lenguaje. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

de interacción social. Entonces, ha de considerarse que su concepción pone en el centro de atención al sujeto activo, consciente, orientado hacia un objetivo.

Realza además, su interacción con otros sujetos (escolar-grupo, escolar-profesor) sus acciones con el objeto con la utilización de diversos medios en condiciones socio históricas determinadas. De esta manera, se produce un proceso de apropiación por parte del sujeto de la herencia cultural de la humanidad a partir de la interacción con otros sujetos. El resultado principal lo constituyen las transformaciones que se producen dentro del sujeto cognoscente (el escolar), mientras que las transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para alcanzar el objetivo de aprendizaje, controlar y evaluar el proceso. Aquí se revela otro aspecto de la concepción vigotskiana: *la relación entre aprendizaje y desarrollo*.

Nuevamente se alejan sus postulados de otras concepciones tradicionales. Las disertaciones más divulgadas confieren al desarrollo psíquico un carácter determinante en las posibilidades de aprendizaje del individuo. No obstante, las investigaciones de Vigotsky le condujeron a la conclusión de que la actividad docente, cuyas representaciones oriundas tienen un carácter colectivo, crean en los alumnos nuevos *sistemas psicológicos* que le permiten una ulterior asimilación de los conocimientos, lo que le hizo afirmar que "*... es buena aquella enseñanza que conduce al desarrollo*"; es decir, la que no sólo aporta algo nuevo a la información contenida en la memoria, sino que genera cambios en la conciencia que producen desarrollo. Vigotsky, además, revela la repercusión que esta relación tiene para el

diagnóstico de capacidades intelectuales y en la elaboración de una teoría de la enseñanza. Señala dos niveles evolutivos: uno, el de las capacidades reales y otro, el de sus posibilidades para aprender con ayuda de los demás.

Para él, lo que las personas puedan hacer con ayuda de otros resulta más significativo para su desarrollo que lo que pueden hacer por sí solos. De aquí surge el *concepto de Zona de Desarrollo Próximo*, tan medular en su concepción acerca del aprendizaje y su relación con el desarrollo. La diferencia entre estos dos niveles es lo que denomina Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) la cual. Vigotsky⁴ (1982) define como *"... la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz"*. Sobre la base de esta definición, se deduce que la enseñanza, la educación, no se ha de basar en el desarrollo ya alcanzado por el sujeto, sino que a partir de este se ha de proyectar lo que el sujeto debe lograr en el futuro como producto de ese propio proceso; es decir, tratar de hacer realidad las posibilidades que se expresan en la zona de desarrollo próximo de cada individuo. Reto parcialmente logrado en el proceso de diagnóstico psicopedagógico.

Luego de transitar por los postulados de la obra de Vigotsky, analizar cómo se revelan sus principios y conceptos en la pedagogía y dentro de ella en el proceso de diagnóstico psicopedagógico se puede concluir que existen relaciones indisolubles

⁴Vigotsky, L. S. (1982) Obras completas. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

entre los fundamentos psicológicos y pedagógicos que subyacen a los procesos educativo y pedagógico. Estas relaciones se revelan en una acertada organización del proceso docente-educativo, de modo que este promueva el desarrollo de la personalidad, pero también en el modo óptimo de realizar el diagnóstico psicopedagógico para que pueda valorarse tal desarrollo de la personalidad, en relación con otros nexos que de manera particular se pueden manifestar.

Para el diagnóstico que se planifique y realice con fines educacionales o pedagógicos, es decir para el diagnóstico psicopedagógico, se ha de tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

- La situación social de desarrollo, abordada por Vigotsky y que se revela en el modo en que las personas viven y se desarrollan y la repercusión de ello en su propio desarrollo, de modo que se tome necesariamente como un elemento de partida, de análisis y objeto de influencias educativas a trazar para el logro acertado de dirección y evaluación del proceso docente-educativo y el diagnóstico de los escolares.
- La adecuada organización de la actividad que realiza el sujeto en interacción social con otras personas como objeto de la acción del docente, en tanto esta resulta determinante en su aprendizaje y, por consiguiente, en su desarrollo, así como la valoración de los modos particulares de interacción de los escolares como un aspecto importante durante cualquier momento del proceso de diagnóstico psicopedagógico en pos de la evaluación de su desarrollo.

- La organización de la actividad cognoscitiva del escolar a partir de la inclusión planificada y consciente de elementos coadyuvantes del desarrollo emocional y afectivo que revelen el aspecto afectivo del aprendizaje, así como valoración de los modos particulares de expresión de indicadores afectivos durante el proceso docente educativo de los escolares como un aspecto importante durante cualquier momento del proceso de diagnóstico psicopedagógico en pos de la evaluación de su desarrollo.

En la actualidad puede añadirse un importante sustento teórico para el abordaje del diagnóstico psicopedagógico en la obra de diferentes pedagogos y psicólogos cubanos, que se irán citando a continuación, según se analicen los resultados de sus investigaciones científicas, presentados en tesis doctorales u otros estudios asociados a proyectos y centros, pues enriquecen la plataforma teórica sobre la que se erige la pedagogía cubana.

La concepción actual del diagnóstico en Cuba no sólo ha de contener, como se ha venido explicando hasta aquí, los elementos más generales que la fundamentan teóricamente a partir de leyes, principios y postulados psicológicos aplicables a la pedagogía ya presentados, además deben asumirse para que integren su marco conceptual un grupo de *principios específicos, conceptos, pares categoriales*, que serán descritos y analizados en este epígrafe con la finalidad de sistematizar esta concepción y alcanzar su aplicabilidad, en tanto con ella pueda lograrse transformar posteriormente, los modos y prácticas del diagnóstico psicopedagógico.

Al analizar la obra de numerosos autores y tener en cuenta los puntos coincidentes, las regularidades y la correspondencia con los supuestos filosóficos, psicológicos y pedagógicos subyacentes acordes con la postura materialista e histórico-cultural que se asume para esta investigación, se explican y presentan cada uno de los elementos que constituyen el marco conceptual para el diagnóstico psicopedagógico.

Conviene comenzar por el análisis de las definiciones surgidas en la conceptualización del proceso objeto de investigación: el proceso de diagnóstico psicopedagógico ¿De qué diagnóstico se trata? A continuación se presentan algunas definiciones.

Para Arias, G. (1999)⁵ **diagnóstico** es “un proceso mediante el cual se construye un conocimiento básico, inicial e introductorio sobre algo que necesita de una intervención para promover o cambiar el curso de su desarrollo”.

Por otra parte, Nieves, M.L.⁶ (1999), expresa que el **diagnóstico** es “un proceso integrado de evaluación-intervención insertado en el de enseñanza aprendizaje”.

Según González, M.⁷ (1999) el **diagnóstico** es “el punto de partida que permite el conocimiento de la realidad cambiante y compleja en un momento dado. Proceso dinámico, continuo, inacabado que como tal se amplía, ajusta y utiliza permanentemente”.

⁵ Arias Beatón G. Libro, (1999) “Educación, desarrollo, evaluación y diagnóstico desde el enfoque histórico cultural”

⁶ Nieves Rivero, M. L. (1999) “Aproximaciones a los conceptos de necesidades educativas especiales”._ En Desafío escolar._ no.7._ p. 9-15, México ene.-feb. 1999.

⁷ González Lamazares, M. (1998) “Metodología para el diagnóstico: una herramienta de apoyatura para la dirección del proceso pedagógico”._ En Con Luz Propia._ no. 2._ p.41– 43._ La Habana ene. –abr.1998.

Estas definiciones encierran en sí un cambio de enfoque, que emergió como consecuencia de la caducidad de otros precedentes, usados en una época todavía reciente, en la que el *diagnóstico* era realizado por un grupo de expertos que manejaban con rigor técnicas o instrumentos de medición, tomando como referencia las respuestas ajustadas a un modelo, generalmente clínico; además, tenía la finalidad de determinar las causas intrínsecas al sujeto, habitualmente de origen orgánico, que justificasen su incapacidad definitiva para aprender. La expresión de los resultados del diagnóstico regularmente en términos cuantitativos, condujo al establecimiento de categorías y etiquetas de deficiencias, a la selección y/o elaboración de programas de desarrollo individual o grupal, distintos a los utilizados en la escuela ordinaria y bajo la responsabilidad de profesionales especialistas. Cabe resaltar que la intención política y educativa era incluirlos en el subsistema de Educación Especial, específicamente al tipo de escuela especial que se decidiera en este proceso.

En la literatura científica acerca de esta temática se encuentran los siguientes términos que intentan describir el diagnóstico a escolares desde el ámbito educacional, ellos son: diagnóstico escolar, diagnóstico psicopedagógico, diagnóstico pedagógico, diagnóstico especializado y otros.

A continuación se mostrarán estos términos:

Para Silvestre, M.⁸ (1990) el *diagnóstico pedagógico* “es el estudio profundo del estado de un proceso o producto de carácter pedagógico, que posibilita la identificación de logros, dificultades, potencialidades y causas, en función de un objetivo determinado, en un momento dado, con el propósito de su transformación”.

⁸ Silvestre Oramas, M. (2003) “El diagnóstico del proceso de enseñanza aprendizaje”. ICCP. Material en soporte magnético.

Páez, V.⁹ (1998) también define *diagnóstico pedagógico* como “un proceso continuo, dinámico, sistémico y participativo, que implica efectuar un acercamiento a la realidad educativa con el propósito de conocerla, analizarla y evaluarla desde la realidad misma, pronosticar su posible cambio, así como proponer las acciones que conduzcan a su transformación, concretando estas en el diseño del microcurrículum y en la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje”.

González, A.¹⁰ (2002) plantea que “el *diagnóstico pedagógico* lejos de considerarlo con un carácter holístico o totalizador, se hace atomísticamente, como si el objeto o fenómeno motivo de investigación fuese estudiado por pedacitos y no como una unidad, como un todo que posee varias partes”.

Álvarez, C.¹¹ (1998) plantea al *diagnóstico escolar* como “un proceso sistemático de identificación, pronóstico y tratamiento de la situación escolar, como una continua retroalimentación y perfeccionamiento subsiguiente que tiene como objetivos: Determinar el nivel de progreso que alcanza el alumno de acuerdo con los objetivos instructivo-educativos; identificar los factores que dificultan, retardan o aceleran el aprendizaje; caracterizar cuáles de las necesidades de los niños son satisfechas durante el proceso y cuáles no. Y por último, determinar el programa de intervención de acuerdo a lo anterior”. Asimismo, respecto al *diagnóstico especializado* plantea: “es cuando el maestro o el personal docente en general necesita del apoyo de otros

⁹ Páez Suárez, V. (1998). “Contextualizar e individualizar el proceso de enseñanza aprendizaje, desde lo social y grupal en la escuela media: una propuesta teórica-metodológica”. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. Tesis de Maestría. La Habana,

¹⁰ González Soca, A. (2002) Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía. La Habana: Ed. Pueblo y Educación. p.75.

¹¹ Álvarez Cruz C. (1998) Citado por la propia autora en “Diagnóstico y diversidad II” tomado de “Diagnóstico Escolar” Módulo en Diplomado de Psicología Educativa. Conferencias Universidad del Meta, Villavicencio y Arauca, Colombia, 1998

especialistas para profundizar o interpretar la dinámica de alumnos o alumnas con determinados grados de complejidad... para finalmente someter todo este proceso a una *validación del mismo* en el campo del *seguimiento* enriquecedor que en definitiva es el que va a responder a las interrogantes y permite una retroalimentación enriquecedora de todo el proceso”.

Nieves, M.L.¹² (1999) define *diagnóstico psicopedagógico* como “una forma o etapa integrada al proceso de evaluación educativa; más específicamente, la etapa inicial o evaluación inicial, entendiendo el término “inicial” como la etapa que precede al diseño de la acción educativa y que puede ser al inicio de la escolaridad, de un nivel, de un ciclo, de un curso, de un nuevo programa o de un proceso de intervención específico. En su concepción más amplia, evaluar es formular juicios de valor acerca de un ser, objeto o fenómeno bien conocido porque interesa orientar acciones futuras, concepto que continúa siendo respetado cuando nos referimos a la evaluación educativa, es decir, a la práctica evaluadora en el contexto educativo. A tono con esta concepción, la evaluación educativa no responde a la simple intención de conocer lo que el alumno es, sino que ella misma constituye un factor educativo que alcanza su sentido pedagógico sólo cuando sirve como base a una decisión para el cambio, perfeccionamiento o mejora”.

No se encontraron contradicciones entre estas definiciones, sino que acorde con el tipo de diagnóstico que enmarcan, se refieren sólo a una parte de lo que se reconoce

¹²Nieves Rivero, M. (1999) “El diagnostico como forma de evaluación educativa” En soporte digital.

en el ámbito educativo como un proceso único. Ello implica asumir una definición en la que quede implícito este carácter. Las dos definiciones que cumplen con ese requisito son las siguientes:

La del Ministerio de Educación MINED¹³ (1994), que define al *diagnóstico psicopedagógico* como “el proceso de toma de decisiones, concebidas sobre la base del análisis y valoración de un cúmulo de información conscientemente recopilada y cuyo objetivo es diseñar un programa de intervención que satisfaga las necesidades específicas sociales y académicas del menor. El conjunto inicial de decisiones posee un carácter tentativo y se va modificando en el proceso de intervención en la medida en que se revelan nuevos hallazgos a través del seguimiento y la valoración de los resultados del programa inicialmente concebido y paulatinamente enriquecido, rectificando y perfeccionando en el propio curso de su ejecución”.

Y la de Álvarez, C.¹⁴ (1998) quien plantea que “el *diagnóstico* es un proceso que lleva a la identificación de las necesidades específicas de cada individuo, tomando en cuenta su entorno, que precisa las áreas débiles y fuertes (necesidades y potencialidades), siendo un proceso continuo de evaluación-intervención con una retroalimentación continua de esta evolución y con un enfoque psicopedagógico”.

En el proceso de diagnóstico psicopedagógico ha de revelarse el cumplimiento de los siguientes **principios del diagnóstico psicopedagógico**¹⁵

¹³ MINED. “Trabajo metodológico de los centros de diagnóstico y orientación”. curso escolar (94-95).

¹⁴ Álvarez, C. (1998). Diagnóstico y Zona de Desarrollo Próximo. Alternativa en la validación de una metodología del cuarto excluido. Tesis presentada en opción al título científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ICCP. Ciudad de La Habana.

¹⁵ Álvarez Cruz Carmen. (1998) Diagnóstico y Diversidad II. Artículo en soporte digital.:

Principio de carácter preventivo, retroalimentador y transformador: el diagnóstico en su calidad de proceso continuo debe tomar en cuenta la atención educativa integral oportuna, el evitar que surja el problema o que se agrave; debe valorar la eficiencia de opciones educativas que se le han brindado al niño desde la edad temprana y la acción en su entorno, tanto familiar como escolar, en la participación activa de estos factores en la toma de decisiones.

Principio del enfoque dinámico, continuo y sistemático del proceso: no existe una diferencia, o una discontinuidad, entre este y la atención educativa integral resultante, que necesariamente se irá adecuando y ajustando constantemente, acorde con la evolución del escolar, y la efectividad de la labor del maestro. La continuidad del diagnóstico puede demandar cambios en la atención educativa integral, bien porque el propio desarrollo exija una etapa superior, o bien porque es necesario introducir cambios ante una precisión del diagnóstico. Para la aplicación de este principio, desde el inicio del proceso de diagnóstico psicopedagógico, desempeñan un rol muy importante los educadores, los miembros de la familia del sujeto y otros coetáneos al emitir y aportar criterios valorativos.

El proceso de diagnóstico no concluye en ningún sentido con la discusión del caso o la redacción del informe final. El diagnóstico continúa su decurso y ciclo en la escuela especial a través de las comisiones de apoyo al diagnóstico (CAD); y en las de Enseñanza General mediante el proceso de seguimiento, renovándose, actualizándose y rediseñándose, cada vez que sea necesario.

Principio del enfoque multi e interdisciplinario: exige la participación de todos los factores que inciden en la formación del niño y a su vez, la propia composición de los equipos de los Centros de Diagnóstico y Orientación permite que se busquen los mejores argumentos, las explicaciones de la dinámica causal que posibilite explicar, proyectar el diagnóstico y la atención educativa de los niños, adolescentes y jóvenes objetos del proceso.

Principio del enfoque Individual y multilateral. Cada sujeto es objeto de estudio individual, tomando en cuenta sus características y diferencias individuales, teniendo en cuenta sus logros y limitaciones, pero también logros y limitaciones del contexto familiar, escolar, comunitario, donde el mismo se desenvuelve. Es imposible utilizar una estrategia de evaluación común para todos los casos.

Principio del enfoque científico y objetivo que pretende precisar que el proceso de evaluación y diagnóstico, es una búsqueda sucesiva de información necesaria para arribar a conclusiones lo más acertadas posibles sobre el sujeto objeto de estudio.

Se ha incorporado de los principios que formuló Akudovich, S. (2004) en su tesis, el *principio de estudio de las potencialidades del desarrollo de los alumnos en el proceso de la actividad de diagnóstico:* se refiere a la consideración del proceso de diagnóstico de la zona de desarrollo próximo como una actividad que supone la integración de un sistema de determinadas acciones que deben realizar los maestros en diferentes etapas de este proceso, cada una de las cuales está compuesta por las operaciones que permiten llevarlas a cabo. Esta actividad de diagnóstico considera como método principal para el estudio de las potencialidades

de los escolares, en general, y con retraso mental, en particular, el experimento instructivo de diagnóstico que constituye una de las etapas de este proceso.

Los **objetivos generales** del diagnóstico que expresan las metas principales que se pretende lograr están encaminados a:

- 1) Identificar las potencialidades de desarrollo.
- 2) Determinar el nivel de progreso que alcanza el niño, el adolescente o el joven de acuerdo con los objetivos instructivos-educativos.
- 3) Identificar los factores que dificultan, retardan o aceleran el aprendizaje. Y
- 4) Caracterizar cuáles de las necesidades de los niños, los adolescentes o los jóvenes son satisfechas durante el proceso y cuáles no.

En la actual concepción también se reconoce que el proceso de diagnóstico psicopedagógico posee una serie de **funciones** que están en consonancia con los principios que lo rigen y se enmarcan como: función exploratoria y orientadora, función reguladora y controladora, función preventiva, interventiva y potencializadora.

En la concepción teórica se han precisado **categorías**, algunas presentadas en forma de **pares**, que en el caso del diagnóstico psicopedagógico adquieren un valor incalculable, en tanto su abordaje permite la comprensión del enfoque materialista dialéctico e histórico que exige la concepción cubana y que se sistematiza en la investigación.

El par **diagnóstico psicopedagógico–atención educativa integral** (antes diagnóstico-estrategia) revela el carácter interactivo entre ambos y una subordinación recíproca. La necesidad de diagnóstico está representada en la búsqueda de vías y

estrategias de atención educativa. Por otra parte, todo lo que acontece durante, y como resultado del proceso de atención educativa, retroalimenta, dinamiza y verifica.

Se reconoce como *atención educativa integral* “el proceso donde se proyectan acciones coordinadas entre las diferentes agencias educativas, en general, y la escuela, en particular, que actúan en varias áreas de desarrollo de la personalidad y se estructuran de manera estratégica para aprovechar al máximo las potencialidades educativas de los escolares con necesidades educativas especiales con el fin de propiciar su preparación para la vida cotidiana y adulta independiente, de forma tal que les permita asumir con el mayor éxito posible las exigencias sociales y personales que se le presenten. La relación entre ellas es vital, representa la finalidad del proceso en sí, en última instancia, su esencia. Guerra, S.¹⁶ (2010).

El par **potencialidades-necesidades** también revela el carácter interactivo de ambos. Cuando se habla de potencialidades se refiere a las fortalezas del desarrollo, teniendo en cuenta que estas son las funciones psíquicas que no han madurado todavía y que están en el proceso de desarrollo bajo la influencia del medio social que rodea al escolar. Por lo que las capacidades que existen o aquellas conservadas en los escolares pueden constituir la base para el desarrollo de nuevas potencialidades. Al referirse a las *necesidades* se tiene en cuenta que, en sentido amplio, revelan su doble condición al patentizar la tensión constante entre carencia y potencia. Las necesidades no solo revelan la ausencia, lo que no tiene sino lo que requiere, un motor que implica, motiva y moviliza a las personas. Por

¹⁶ Guerra S, 2010 Retraso mental. Reflexiones necesarias para brindar una atención educativa integral a los escolares con retraso mental. Artículo Digital. Proyecto: Atención Educativa Integral a escolares con retraso mental.

esto en el proceso de diagnóstico y evaluación hay que realizar el estudio de las potencialidades y las necesidades de los niños, adolescentes y jóvenes que necesitan la ayuda especializada.

Por su parte, Arias, G.¹⁷ (1999) interpreta **evaluación-diagnóstico** cuando refiere como “*evaluación* al estudio valorativo de determinadas condiciones, que permita elaborar un juicio o conclusión acerca de la situación o estado de un problema y las posibles causas que lo determinan, requiere de la búsqueda de información y del empleo de diversos y adecuados instrumentos para su éxito”, y como “*diagnóstico* al proceso que se encamina a la búsqueda de un conocimiento acerca de cómo marchan los acontecimientos y en qué sentido hay que dar inicio o seguir desarrollando la actividad sujeto del mismo, para poder, mediante un amplio y profundo análisis, llegar a una posible explicación de las características, logros, dificultades y causas de los problemas, con un último propósito de proyectar posibles soluciones para eliminar, atenuar o compensar las dificultades; así como usar de forma conveniente potencialidades o fortalezas también encontradas”.

Categorías del diagnóstico psicopedagógico

Teniendo en cuenta que este proceso se rige por el principio de carácter preventivo y cumple la función de **prevención** es necesario realizar la definición de esta **categoría** y esclarecer sus diferentes aristas.

¹⁷ Arias Beatón. G. (1999) “Educación, desarrollo, evaluación y diagnóstico desde el enfoque histórico cultural”

Al tomar como punto de partida la definición de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) pedagogoscubanos del Ministerio de Educación¹⁸ señalan que la **prevención educativa** es “el proceso dialéctico de orientación, ejecución y control sistemático, anticipatorios y continuos, que tiene como uno de sus principales aliados, al diagnóstico psicopedagógico de los niños, adolescentes y jóvenes; que es un resultado genuino, propio de la labor docente educativa, en el que se integran lo curricular, lo familiar y lo socio-comunitario. Todo ello, dirigido conscientemente a la formación y fortalecimiento de cualidades, motivos, intereses, sentimientos, valores, capacidades intelectuales, de actitudes; en resumen, los elementos que integran el desarrollo de la personalidad de los educandos, la que se forma según la teoría histórico-cultural en la interacción de éstos con el medio social”.

Por el lugar que ocupa en el proceso de diagnóstico psicopedagógico la elaboración de la caracterización del alumno y sus entornos, otra categoría es la **caracterización psicopedagógica** definida como “un proceso que lleva a la descripción y explicación de los aspectos distintivos de las particularidades psicológicas, pedagógicas y socio-familiares de los alumnos, especificando sus cualidades positivas y negativas relevantes para el desarrollo actual”.

Además de lo expresado anteriormente la concepción cubana de diagnóstico se reconoce y enmarca el proceso en tres direcciones para la atención educativa, ellas son: el diagnóstico en la edad temprana y preescolar, el diagnóstico escolar y el diagnóstico especializado. Cada una de ellas tiene objetivos específicos, no se contraponen sino que coexisten en estrecha relación dialéctica.

¹⁸ MINED (2004) V Seminario Nacional para educadores.

Para esta investigación, las tres direcciones no son excluyentes de la necesaria asunción del diagnóstico psicopedagógico como un proceso único e integral; sin embargo, se corre el riesgo en su aplicación de una fragmentación del proceso y de que se rompa su dialéctica interna, lo que dificultaría en consecuencia, el cumplimiento de uno de los principios que lo sustenta y le confieren el carácter: *dinámico, continuo y sistemático*.

1.2 Regularidades conceptuales, terminológicas y metodológicas del retraso mental, con énfasis en su aplicación para el proceso diagnóstico psicopedagógico

1.2.1 Evolución conceptual del retraso mental en el mundo

El término *retraso mental* es sin duda alguna uno de los más polisémicos de todos los que existen en la educación especial, así lo demuestran las decenas de denominaciones que a lo largo de la historia han recibido; realmente es difícil abarcar en un solo término la variada gama de comportamientos y situaciones psicosociales que ocurren en las personas con retraso mental.

Este término ha evolucionado influenciado, lógicamente, por las diferentes escuelas y corrientes psicológicas, sociales y de la Educación Especial en particular. En este sentido se muestra lo que al respecto de la conceptualización de esta entidad diagnóstica se ha venido tratando en el mundo; denominada indistintamente como deficiencia, retardo, o retraso mental y más reciente *discapacidad intelectual*.

En 1900, con Ireland en el campo de la medicina, se reconoció como Deficiencia Mental (DM), “un *déficit físico y orgánico*”, retomando el concepto de idiota de Seguin con los de Binet y Simon (1900), y Wechsler (1955), quienes atribuyen a la inteligencia el principal criterio de diagnóstico, se mantuvo el mismo criterio hasta los estudios de Grossman (1983), quien incorpora lo relacionado con las dificultades en el comportamiento adaptativo, luego presentada por la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) cuando plantea que “*el retraso mental es una discapacidad caracterizada por unas limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa que se manifiestan en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años*” Luckasson, R. y Cols, (2002). Constituye un referente internacional necesario al abordar esta temática; sin embargo se requiere realizar precisiones para el uso de esta definición.

Se le reconoce las reflexiones que suscita en torno a la interpretación de la relación de la esfera cognitiva con el comportamiento ante el medio ambiente; es decir, la relación de los elementos intelectuales con los funcionales o prácticos.

Recién se ha publicado la oncenava edición del manual de la Asociación americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD por sus siglas en inglés), donde la renombran como *Discapacidad Intelectual* y mantienen la definición; al asumir los elementos constitutivos de la definición de discapacidad dada por la Organización mundial de la Salud (OMS) en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, conocida como CIF (2001)

Si resulta importante no desconocer cómo ha sido tratado el retraso mental a nivel mundial, lo es más aún el estudio de la evolución de su conceptualización en Cuba, al considerar las ciencias humanísticas, pero principalmente desde la pedagogía.

1.2.2. Evolución conceptual del retraso mental en Cuba

En Cuba, luego del triunfo revolucionario el retraso mental se trató a partir de los estudios, aportes y postulados de la psicología y de la defectología rusas que ya defendían y asumían la teoría vigotskiana. De ahí que en los inicios de la educación especial se asumiera la definición de retraso mental dada por Rubinstein, S. desde que se comenzaron los intentos de interpretación y aplicación de la definición contextualizándola a la cultura e historia de la psicología y pedagogía cubanas, las cuales están matizadas, desde sus inicios, por la autenticidad de la identidad nacional en el análisis y toma de partido de las teorías nacidas en diferentes confines. Algunos pedagogos y psicólogos cubanos redefinieron el retraso mental y realizaron trabajos investigativos serios en ese sentido, los cuales, sin lugar a dudas, tienen el valor de constituir un precedente auténtico y nacional.

La definición más reciente surgida a partir de las investigaciones que conforman el proyecto *“Modelo educativo para la atención integral a educandos con retraso mental”*, dirigido por la Dr. C. Sonia Guerra Iglesias, al que pertenece la autora, plantea que “el retraso mental es una condición especial del desarrollo donde se presenta una insuficiencia general en la formación y evolución de las funciones psíquicas superiores, que compromete de manera significativa la actividad cognoscitiva, siendo provocado por una afectación importante del sistema nervioso

central en los períodos pre, peri y postnatal, por factores genéticos, biológicos adquiridos e infraestimulación socio-ambiental intensa en las primeras etapas evolutivas, que se caracteriza por la variabilidad y diferencias en el funcionamiento, susceptible de ser compensada por acciones educativas oportunas. (Colectivo de autores, 2002,2005, 2006).

Se asume que la variabilidad y funcionamiento dependen de la intensidad y extensión de la afectación del sistema nervioso central, la calidad de la situación social del desarrollo y la actuación oportuna de las estrategias de estimulación y de las acciones educativas.

La autora entiende que en la definición, aunque se coloca en primer lugar la limitación en la esfera cognitiva y se reconoce la variabilidad en el funcionamiento del sujeto, la cual se identifica en el ámbito internacional con las afectaciones en la conducta adaptativa, pero en la definición esta área o esfera no se revela de forma explícita; sin embargo, a los elementos que la conforman se le confieren una relevante importancia por constituirse en aspectos diferenciales.

A partir de ello, se considera necesario tenerlos en cuenta durante el diagnóstico, ya que existen otras entidades que se caracterizan por afectaciones en la esfera cognitiva, pero no en ésta. Esto requiere procedimientos específicos de evaluación y más tiempo, al intentar diagnosticar escolares con las formas más leves de expresión del retraso mental y, por tanto, con mayor complejidad diferencial.

En correspondencia con esta visión y las características del trabajo que realizan los CDO, es que la presente investigación hace referencia a escolares con indicadores de retraso mental, ya que en los menores es donde aparecen signos de alerta de un posible retraso mental, cuya hipótesis diagnóstica debe ser constatada o refutada por un proceso científico.

En su tesis doctoral Rivero, M. (2005)²⁰ defiende la necesidad de que precozmente sean tomados en cuenta indicadores de retraso mental y que estos sean “considerados en el diagnóstico psicopedagógico del retraso mental desde las edades más tempranas... y enriquecidos paulatinamente en momentos posteriores de desarrollo...”

Por otra parte, Travieso, E. (2008)¹⁹ en su tesis doctoral explicita qué elementos considerar como indicadores de posible retraso mental, cuyas aportaciones enriquecen los criterios diagnósticos que se tienen en cuenta para ello.

Esta autora determina los indicadores de posible retraso mental en la edad temprana y preescolar. Los agrupa por los años de vida de cada uno de los ciclos de esta educación y los enmarca dentro de una de las siguientes áreas de desarrollo: sensorio-motriz, motriz, cognoscitiva, comunicación-lenguaje y afectivo-volitivo-emocional.

Al retomar lo concerniente a la variabilidad en el funcionamiento del sujeto, se considera necesario tomar posición acerca de los elementos constitutivos relacionados con esta área. Es por ello que se asume la definición de Leyva, M. (2004) define los **Modos de actuación social**, como “el modo de aplicación por un individuo de los aprendizajes conceptuales, sociales o prácticos en su actividad social, que determina la manera en que se comporta y es, en menor o mayor medida, capaz de enfrentar situaciones vitales y cotidianas de forma independiente, acorde con las normas sociales para un entorno y grupo uniformes, que le permita participar en las actividades con menos limitaciones y restricciones en la participación social”.

¹⁹ Travieso L. E, 2008. El desempeño profesional y humano de los promotores del programa EDUCA A TU HIJO...” Tesis doctoral. La Habana.”

²⁰ Rivero M, 2005. Caracterización del desarrollo ontogenético de los niños con diagnóstico de retraso mental.

Al dilucidar los elementos que conforman esta definición de modos de actuación social, se presenta un análisis de cada uno de ellos, derivado del análisis teórico de la discapacidad que se presenta en la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, conocida como CIF-2001 y que se presenta a continuación.

Cuando se refiere a *los aprendizajes conceptuales, sociales y prácticos, aunque están* asociados a las habilidades que se describen para entender la conducta adaptativa a nivel mundial. Para esta tesis se retoma los elementos abordados por Oliva, L. (2004) en su tesis de maestría, quien propone y valida un instrumento a fin de medir las habilidades adaptativas (EDCHA) y desde la pedagogía cubana, los criterios trabajados por De la Peña, N.(2005) quien en su tesis doctoral, presenta los aprendizajes conceptuales, prácticos y sociales, desde las características del contexto cubano, sustentado en los postulados vigotskianos acerca de desarrollo de la personalidad, comportamiento, aprendizaje, capacidad, habilidad y al tratamiento que la pedagogía cubana da a las habilidades. Definiciones que dieron lugar al instrumento que propone y que fueron retomadas para esta investigación.

Situaciones vitales y cotidianas: Se considerarán aquellas necesarias para subsistir o para el desempeño cotidiano y que pueda solucionar la persona sin ayuda directa de terceros en todos los ámbitos y de carácter personal, familiar, escolar o laboral y comunitarias o sociales, es decir, las situaciones serán aquellas que en cada uno de los entornos comúnmente las personas realizan de forma independiente y les son necesarias o vitales (hogar, escuela/centro laboral, lugares públicos).

Las normas sociales acordes para un entorno y grupo uniformes son aquellas que toman en cuenta aspectos homogeneizadores tales como: edad, sexo, idiosincrasia, cultura, religión, escolaridad, u otros que estén en correspondencia con su situación

social de desarrollo y los ambientes en que le ha tocado vivir, así como la historia educativa y de vida en cada caso.

Asimismo, las actividades (con limitaciones o no) y la *participación social* (con o sin restricciones) serán vistas tal y como lo expone la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF, 2001).

Actividad: la realización de una actividad, tarea o acción por una persona.

Limitaciones en la actividad: son dificultades que una persona puede tener en el desempeño/realización de las actividades.

Participación: es el acto de involucrarse en una situación social vital.

Restricciones en la participación social: son problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en tales situaciones.

1.2.3. El proceso de diagnóstico del retraso mental. Antecedentes en el mundo y en Cuba

El diagnóstico de los sujetos con retraso mental en el mundo ha evolucionado manifestándose en ello las características que lo incluyen dentro de una u otra tendencia o corriente de tipo filosófica, pedagógica, sociológica y/o psicológica, que esté predominando en el período histórico de que se trate.

Que este proceso se realice para determinar recursos, apoyos, respuestas educativas curriculares o extracurriculares y no para determinar *categorías diagnósticas*, es un aspecto reincidente en el discurso científico internacional actual reflejado en las últimas publicaciones, al margen del país en cuestión y la

coincidencia o no de aspectos subyacentes. Esto ocasiona un fin casi unánime y unas prácticas e investigaciones más o menos coincidentes en la medida en que se acerquen o alejen en aquellos aspectos relacionados con el *cómo* y el *por qué*; es decir, los aspectos filosóficos, sociológicos psicológicos y pedagógicos.

El debate en torno al tema del diagnóstico de las personas con retraso mental tiene una actualidad extraordinaria en Cuba y en otros países del mundo. Un análisis del contenido de diferentes modelos de atención a estas personas, así como de la conceptualización y política educativa a las personas con retraso mental en países como México, Venezuela, Portugal, España, Inglaterra, Rusia, Alemania, Finlandia y Estados Unidos, evidencia que existen muchas aristas sobre las que aún es necesario seguir profundizando desde la perspectiva de la investigación científica, en función de completar y enriquecer el estudio de las personas con retraso mental.

Al igual que en el aspecto relacionado con la conceptualización, en lo concerniente al diagnóstico, la AAIDD ha mostrado un rol pionero a nivel internacional. Tanto en su novena edición, reconocida como responsable de un cambio de paradigma, como la décima, en que la perfecciona y en la reciente oncenava edición, hay que decir que representa el resultado de años de estudio de numerosos especialistas de disímiles países, pero que requiere del diseño de estrategias para su aplicación e implementación en cada país o región.

Para ser consecuentes con el enfoque vigotskiano y la importancia que tiene lo histórico cultural al querer perfeccionar el diagnóstico psicopedagógico en Cuba, se toman aquellos postulados ineludibles en el orden teórico y se contextualizan a los

elementos distintivos de la psicología y pedagogía cubanas desde una postura electiva de la ciencia, no solo en esta investigación que se presenta, sino en otras que le anteceden o le sucederán.

Para esta investigación se considera importante el análisis de las tendencias internacionales, coherentes con los cambios que en la concepción del diagnóstico psicopedagógico vienen produciéndose desde hace algunos años en Cuba; aunque perfectible, es innegable su valor histórico y contextual, lo que se revela en la posición cubana del enfoque psicopedagógico, concretado en “la necesidad de un diagnóstico *precoz* y con fines preventivos como un *proceso único, de carácter individualizado, personalizado, pero centrado en los servicios; como medio para llegar al fin* y no como *un fin en sí mismo*, como proceso de construcción *interactiva*, donde la escuela, la familia y la comunidad constituyen elementos activos y participantes y finalmente, para *intervenir, proveer apoyos y diseñar e implementar la atención educativa* y no para clasificar o etiquetar”. Akudovich, S. (2004)

Para abordar el resto de las dimensiones que caracterizan al retraso mental se requiere de una práctica que tenga en cuenta, no solo los elementos que describen el funcionamiento intelectual y su manifestación en el orden académico curricular, sino también lo funcional que se enmarca dentro de los *modos de actuación social*. Los aprendizajes sociales y prácticos en este grupo de escolares suceden de un modo peculiar, los caracteriza y los distingue, por ello deben ser abordados durante el diagnóstico, pues podrían ser relevantes al diferenciar este grupo con otros, como los problemas específicos de aprendizaje; sin embargo, no se cuenta en los Centros de

Diagnóstico y Orientación con herramientas para evaluar y medir las habilidades que requieren estos aprendizajes, lo que limita su uso para el diagnóstico diferencial. Otro requerimiento lo constituye el aprovechamiento de las familias y docentes como participantes, realmente activos, del proceso.

Estas cuestiones constituyen un acicate para esta investigación que tiene ante sí un desafío profesional, lo cual implica superar lo peyorativo y segregacionista de denominaciones y modelos anteriores de atención a las personas con retraso mental, usados en el mundo, clarificar los límites entre denominación, definición y clasificación, aprovechar las oportunidades de incorporar a la concepción actual la condición multidimensional del retraso mental, con énfasis en el abordaje de los modos de actuación social que describen los aprendizajes prácticos, sociales y sus implicaciones en el logro de una vida adulta e independiente.

Un elemento teórico importante a considerar y tomar postura es el modo de enfocar y entender qué es discapacidad. ¿Acaso es lo mismo que entidad diagnóstica, o el cúmulo de aquello que no puede realizar el sujeto, o se trata de la consecuencia inmediata del déficit?

Internacionalmente está produciéndose una revolución en la atención de las necesidades educativas especiales, como consecuencia la quincuagésimo cuarta Asamblea Mundial de la Salud, en el 2001, se aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Aunque se trata de un instrumento de carácter eminentemente estadístico para los niveles macro sociales, la CIF se acompaña de una plataforma teórica basada en un modelo bio-psico-social que entre, otros aspectos, presenta una nueva definición de discapacidad.

En Cuba, ya asumido por los ministerios de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social (MINSAP y MTSS), se empleó durante el estudio clínico genético realizado en el 2004.

En el ámbito educacional no se ha generalizado aún este importante salto conceptual; sin embargo por la repercusión e impacto que en el diagnóstico psicopedagógico ha de tener, se presenta de manera sintética el modo en que la CIF propuso la definición sobre discapacidad, unido a la interpretación que hace la autora al asumirla en esta investigación para su aplicabilidad en el diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental.

Para la CIF la discapacidad es “...*limitaciones en la actividad y restricciones en la participación* que puede tener una persona como consecuencia de la *interacción* entre los aspectos inherentes a *su condición de salud, la actividad y la participación*, relacionados con *los factores contextuales*”.

La autora considera que la discapacidad vista así adquiere un carácter general, que engloba no solo lo concerniente al déficit, sino la interacción de este con el resto de los niveles en que se manifiesta el desarrollo humano y la influencia que sobre ellos ejercen los factores contextuales.

La aplicabilidad de esta definición al diagnóstico psicopedagógico radica en la posibilidad que brinda, no solo a la hora de elaborar las hipótesis diagnósticas

iniciales, sino también para cada uno de los momentos o fases, en las que se deben tomar en cuenta las manifestaciones del desarrollo de los escolares con indicadores de retraso mental (o cualquier otro escolar sujeto de diagnóstico). Los elementos psicológicos que se revela en la actividad pueden tener carácter negativo como “limitaciones en la actividad” que no son directamente proporcionales a la deficiencia biológica (estructural o funcional). Lo social visto como “la participación social” puede darse negativamente también y ello se revela en “las restricciones en la participación”, que también tiene una relación dinámica, variable y nunca directa ni de efecto inmediato de la deficiencia obligatoriamente.

Estos elementos de la definición demuestran el carácter *inestable* de los niveles en que se expresa la discapacidad, la cual *puede generarse, aumentarse o reducirse*, de acuerdo con las influencias de los factores contextuales y a las interacciones los niveles en que se manifiesta el desarrollo humano.

Estas consideraciones permiten encontrar los elementos necesarios para construir la dinámica explicativa del diagnóstico, identificar las potencialidades y, sobre todo, limita las equivocaciones al realizar pronósticos, sólo basados en los elementos negativos. Finalmente; permite decidir la planificación o implementación de los apoyos y la respuesta educativa, es decir la atención educativa, que resulta del proceso de diagnóstico psicopedagógico.

Conclusiones del capítulo

- En el proceso histórico del diagnóstico en el contexto educativo se han utilizado diferentes términos para su nominación, la sistematización realizada junto a las transformaciones a que está sometida la práctica de diagnóstico actual dentro del sistema educativo conlleva a la reflexión de que los elementos constitutivos importantes que coinciden con el carácter único, sistemático y con finalidad interventiva, a partir de la toma de decisiones, en correspondencia con las necesidades de los escolares diagnosticados, poseen elementos teóricos importantes a considerar y propician la operacionalización de este constructo como *diagnóstico psicopedagógico integral*, para su exploración.
- El grupo de escolares con indicadores de retraso mental presenta necesidades demandantes de decisiones que garanticen mayor rigurosidad y aciertos al confirmar ese diagnóstico o no y, sobre todo, para el diseño de la atención educativa integral que recibirá a tenor del resultado de este proceso, lo que conlleva a la necesidad de un análisis del proceso de diagnóstico psicopedagógico en sí, con vistas a su mejoramiento.

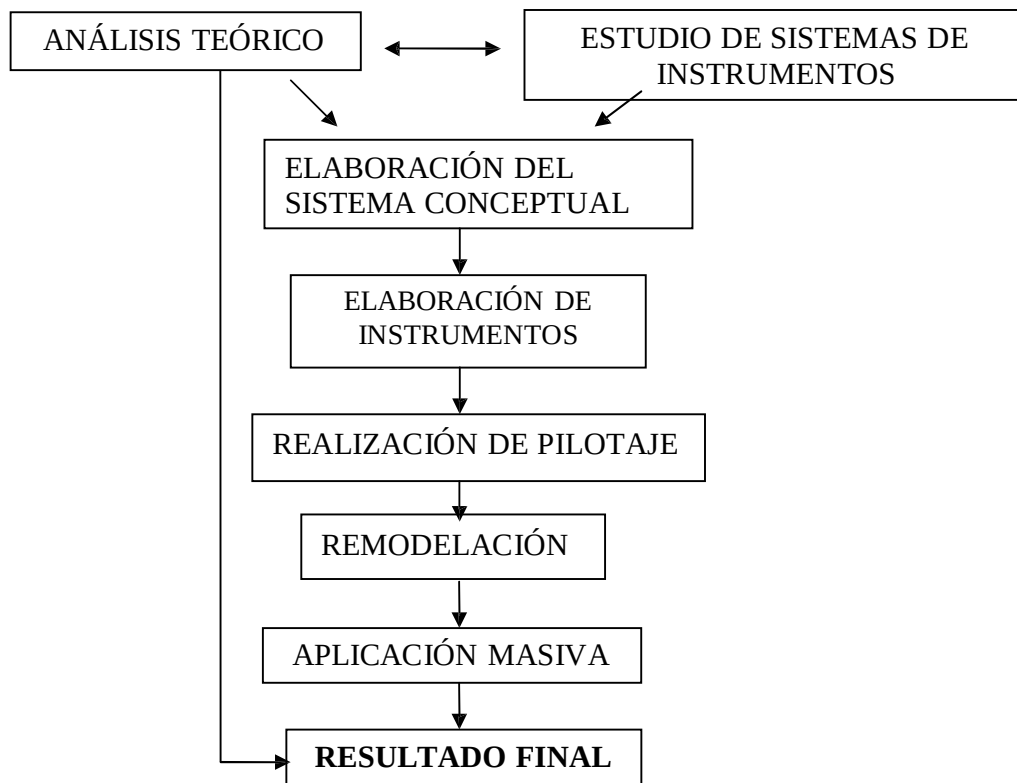
CAPÍTULO II CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO DEL RETRASO MENTAL

2.1 Modelo actuante del diagnóstico psicopedagógico integral

El trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO) actualmente exhibe cambios cualitativamente superiores que se revelan en la práctica de diagnóstico psicopedagógico cubana.

En las investigaciones precedentes y la literatura científica actual referida al diagnóstico consultadas no se encontró esquematizado, presentado o descrito intencionalmente el modelo actuante del “diagnóstico” que realizan los CDO en el país, ni las particularidades que caracterizan este proceso cuando está dirigido a escolares con indicadores de retraso mental; sin embargo, existen documentos oficiales que norman la labor de los CDO, elaborados o aprobados por el Ministerio de Educación (MINED) y otros teóricos, resultado de investigaciones vinculadas al proyecto “Diagnóstico, diversidad y potenciación del desarrollo” que aportaron la mayoría de los elementos teóricos y metodológicos necesarios para construir el modelo actuante del diagnóstico psicopedagógico integral. Para lograrlo, se asumió uno de los modelos de diagnóstico que presenta Valle, A.²¹ (2007) donde el autor realiza un análisis acerca de cómo explorar el proceso de diagnóstico en el ámbito educacional y lo esquematiza de la siguiente manera.

²¹ Valle Lima. Alberto D. (2007) “Metamodelos de la investigación pedagógica” Formato digital



En la presente investigación se tuvo en cuenta la propuesta de Valle, L., porque permitió reunir los elementos teóricos necesarios para caracterizar el proceso de diagnóstico, a la vez que permitió organizar los métodos y procedimientos empíricos que aportaron los datos para caracterizar el estado actual y analizar las fortalezas y debilidades, necesarios para operacionalizar la variable.

Descripción del modelo actuante del diagnóstico psicopedagógico

I- ANÁLISIS TEÓRICO:

Al realizar un análisis teórico se pudo conformar el sistema conceptual. La concepción cubana del proceso de diagnóstico psicopedagógico se concreta en las leyes, principios, categorías, objetivos; todos abordados en la sistematización teórica.

Se puede afirmar que la actividad de diagnóstico psicopedagógico está orientada a la escuela, al aprendizaje y basada en la dialéctica materialista, concibe al ser humano como centro, desde una postura optimista que prevé siempre conseguir los cambios necesarios para el mejoramiento individual y de la realidad educativa, a partir de los fundamentos histórico-culturales que conciben al ser humano y su desarrollo expresado en los niveles biológico, psicológico y social, interrelacionados y bajo la influencia de los factores contextuales.

El proceso de diagnóstico psicopedagógico actual muestra avances en cuanto al diseño de la respuesta educativa, que ya no insiste en que los escolares se adapten, sino en adecuar las condiciones educativas, a las necesidades diagnosticadas en los alumnos concebidas en interrelación con las potencialidades y los contextos educativos.

II- ESTUDIO DE SISTEMAS DE INSTRUMENTOS:

Para poder caracterizar el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral, que dirigen los Centros de Diagnóstico y Orientación, se requiere de la selección y empleo de instrumentos que indaguen cualitativamente esta difícil y compleja labor. El sistema de instrumentos por sí solo no cumple su función, demanda una acertada selección y empleo, relacionado con los elementos teóricos. En tanto, se trata de un proceso donde tienen igual envergadura tanto el sujeto como el objeto, conviene aplicar instrumentos dirigidos a cada uno de ellos; es decir, a los escolares objeto del diagnóstico y, por el otro lado, a los especialistas que lo dirigen u otros participantes en el proceso. Instrumentos que para esta investigación, se utilizaron con vistas a caracterizar el objeto y construir el modelo actuante.

Es importante, al explorar el objeto de esta investigación, poner la mirada no sólo en los aspectos relacionados con el modo en que se realiza, sino también en elementos relacionados con la respuesta a *por qué*, *para qué*, y en otros aspectos de tipo subjetivo como, por ejemplo, las actitudes que subyacen en ambas partes.

Para lograrlo, se seleccionaron instrumentos tales como: guías de observación, estudio de documentos, encuestas, entrevistas, cuestionarios, otros. Todos en correspondencia con las particularidades del proceso de diagnóstico psicopedagógico a caracterizar con vistas a su análisis detallado.

III- ELABORACIÓN DEL SISTEMA CONCEPTUAL:

El sistema conceptual del modelo actuante se corresponde con los elementos epistemológicos que sustentan la pedagogía cubana, incluye la concepción teórica cubana, enriquecida desde la teoría con investigaciones científicas realizadas para el y proyectos de investigación de diferentes niveles. Además, contiene en sí años de experiencia en cuanto a la práctica de diagnóstico que en el ámbito educativo se ha venido acumulando, con la participación de pedagogos, psicólogos y otros especialistas. Asume un enfoque psicopedagógico que se basa en los postulados vigotskianos como pilares sobre los cuales se erige, presentados en la sistematización teórica de esta Tesis.

La actividad de diagnóstico psicopedagógico integral, desde el punto de vista metodológico, se organiza de un modo riguroso, planificado y sistemático, lo que la convierte en una actividad científico-profesional.

En ella se reconocen tres direcciones del diagnóstico: el diagnóstico desde la edad temprana y preescolar, el diagnóstico escolar y el diagnóstico especializado. A cada una se le asignan objetivos, tareas y herramientas o instrumentos.

La orientación y seguimiento, tal y como viene implementándose resulta hoy el método, la vía, donde se realiza el proceso de diagnóstico, es por eso que los Centros de Diagnóstico y Orientación, como institución, tienen el papel rector en este aspecto, y dirige y/o ejecuta esta función en todos los contextos educativos. La aplicación de este método posibilita la observación del *proceso* de detección, caracterización, evaluación e intervención en las *tres direcciones del diagnóstico* para la atención educativa.

Para la dirección, *diagnóstico desde la edad temprana y preescolar*, los Centros de Diagnóstico y Orientación se apoyan en la evaluación sistemática de esta educación; para la dirección *diagnóstico escolar*, en la labor de evaluación pedagógica y la caracterización psicopedagógica que le permite al maestro contar con una información valiosa acerca de aspectos generales importantes de cada escolar y del nivel de aprendizaje y desarrollo, o sea de educación real alcanzados; para la dirección *diagnóstico especializado*. La evaluación se realiza por un equipo multidisciplinario, que estudia el desarrollo del niño con el fin de lograr una intervención más integral, desarrolladora y socializadora, lo que es responsabilidad de los especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación, quienes son encargados de realizar el diagnóstico psicopedagógico especializado de manera inter y multidisciplinaria.

La labor asumida por ellos ha respondido a las exigencias sociales y educativas, ha tenido aciertos y desaciertos, por lo que se enfrenta a un momento de profundización, fortalecimiento del trabajo y a los retos que ello implica.

En los Centros de Diagnóstico y Orientación se cuenta con un sistema instrumental, que va desde los más simples como la recogida de información, hasta otros más complejos. Se puede resumir que en el modelo actuante el sistema de instrumentos incluye:

- a) Instrumentos de recogida de información (Asociados a métodos indagatorios como la observación, la encuesta, la entrevista u otros con igual función).
- b) El estudio de documentos (Anotaciones y planes de clase, producto de la actividad del escolar, expedientes escolares y otros).
- c) Pruebas estandarizadas y metódicas por especialidades (Desde hace unos años se ha incluido, como un salto metodológico superior, la evaluación de la zona de desarrollo próximo durante la aplicación de los instrumentos, lo que permite determinar el perfil de desarrollo real y también encontrar el perfil de desarrollo próximo. En otras palabras, es la materialización de la búsqueda y hallazgo de las potencialidades de desarrollo).

La intervención mediante adecuaciones curriculares y de acceso temporales suele utilizarse con finalidad diagnóstica, cuando surgen como parte del proceso para valorar potencialidades o respuesta ante la provisión de apoyos.

El sistema instrumental dentro del modelo actuante es el elemento menos desarrollado que requiere ser enriquecido mediante la validación en el contexto cubano de otros instrumentos, o de la elaboración de otros.

Para el diagnóstico psicopedagógico de los escolares con indicadores de retraso mental existe una insuficiente disponibilidad de herramientas o instrumentos que midan y caractericen los modos de actuación social, categoría en la que coexisten los aprendizajes conceptuales, prácticos y sociales. El enriquecimiento del sistema instrumental, en este sentido, daría un vuelco al elemento diferencial del diagnóstico. Se impone resaltar la elaboración de dos instrumentos para medir los aprendizajes sociales en el retraso mental, tales como: la escala **EDCHA** “Evaluación del desarrollo y comportamiento de las habilidades adaptativas” Oliva, L. (2004) y el “Registro de evaluación de indicadores de la preparación para la vida cotidiana escolares con retraso mental” De la Peña, N. (2005); sin embargo, en el modelo actuante no están incorporados, ni generalizados como elemento metodológico definido y al alcance de los especialistas.

Al circunscribir la investigación al diagnóstico psicopedagógico del retraso mental se impone un alto en lo concerniente a los criterios diagnósticos del modelo actuante relacionados con esta entidad.

Los criterios diagnósticos vigentes no abarcan todas las dimensiones de esta entidad o categoría. El abordaje diagnóstico a escolares con indicadores de retraso mental ha transitado también por la aplicación de diferentes modelos y paradigmas, sufrido los efectos de la terminología variable para su nominación y, finalmente, está influido por secuelas de la inadecuada representación social del retraso mental que se tiene a nivel de la comunidad y de las familias.

Criterios diagnósticos:

Hasta hoy los **criterios** que se tienen en cuenta para el diagnóstico de retraso mental en el trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación son:

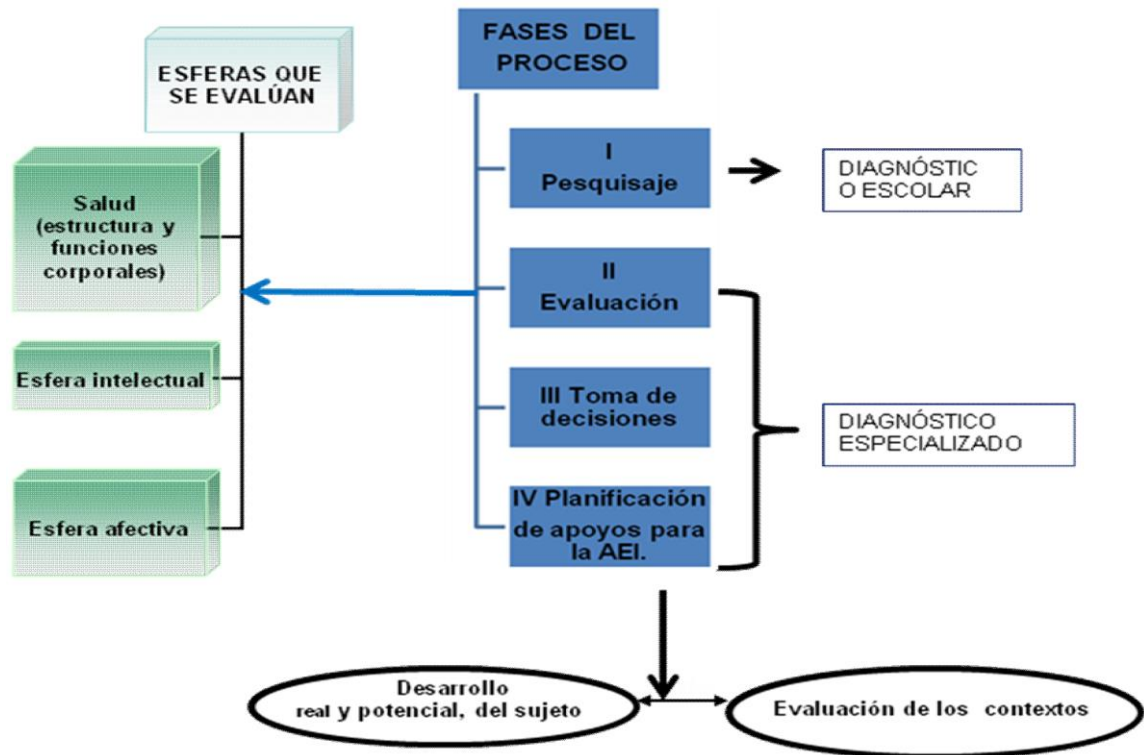
- 1) Insuficiencia general en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores.
- 2) Significativo compromiso en la actividad cognoscitiva, causada por afectación importante en el sistema nervioso central por factores genéticos, biológicos o de infraestimulación socio-ambiental.
- 3) Compromiso funcional en dependencia de la afectación en el sistema nervioso central, la situación social del desarrollo y la oportuna estimulación.

IV- ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS

Para constatar el estado actual del diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de retraso mental y valorar el modelo actuante se elaboraron o seleccionaron instrumentos que abordaran los elementos necesarios para caracterizarlo, con énfasis en los siguientes elementos: relativos al escolar y relativos al examinador (docente o especialistas)

El modelo actuante para el diagnóstico de escolares con indicadores de retraso mental se representa en el siguiente esquema.

Modelo Actuante



2.2 Determinación de variable, dimensiones e indicadores para la evaluación del Proceso de diagnóstico psicopedagógico a escolares con indicadores de posible retraso mental

El análisis y sistematización teórica realizados permitió a la autora definir operacionalmente el constructo: *Proceso de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental*, con el propósito de determinar la variable como:

“Un proceso de búsqueda para el conocimiento del escolar con indicadores de retraso mental en sus niveles de desarrollo: *biológico, psicológico y social* interrelacionados y bajo la influencia de factores contextuales. Con vistas a ofrecer la atención educativa integral, a tenor de procedimientos evaluativos científicos, aplicados preferiblemente en el medio natural, bajo la dirección de especialistas de los Centros de Diagnóstico y Orientación preparados para ello, con dominio *cognoscitivo* y metodológico, expresado en capacidades *ejecutivas*, y *cualidades actitudinales* positivas que favorezcan un modo de actuación científico, humanista, desprovisto de prejuicios y que conduzcan a una acertada atención educativa integral que se les provea a estos escolares durante el proceso y evolutivamente. (Leyva, M, 2009).

A partir de ella se determinó como variable, dimensiones y subdimensiones de investigación las siguientes:

VARIABLE

- 1) El proceso de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental.

Para su estudio se determinaron las siguientes dimensiones:

- I. Evaluación de los escolares con indicadores de retraso mental (objetos del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral).
- II. Los especialistas de los centros de diagnóstico y orientación (sujetos que dirigen el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral).

La Dimensión I incluye lo referido a las indagaciones que se hacen para evaluar el desarrollo del escolar objeto de diagnóstico. Se divide para su estudio en las siguientes subdimensiones: biológica, psicológica y social

La Dimensión II incluye las indagaciones a realizar para caracterizar a los especialistas que acometen la dirección del diagnóstico psicopedagógico integral.

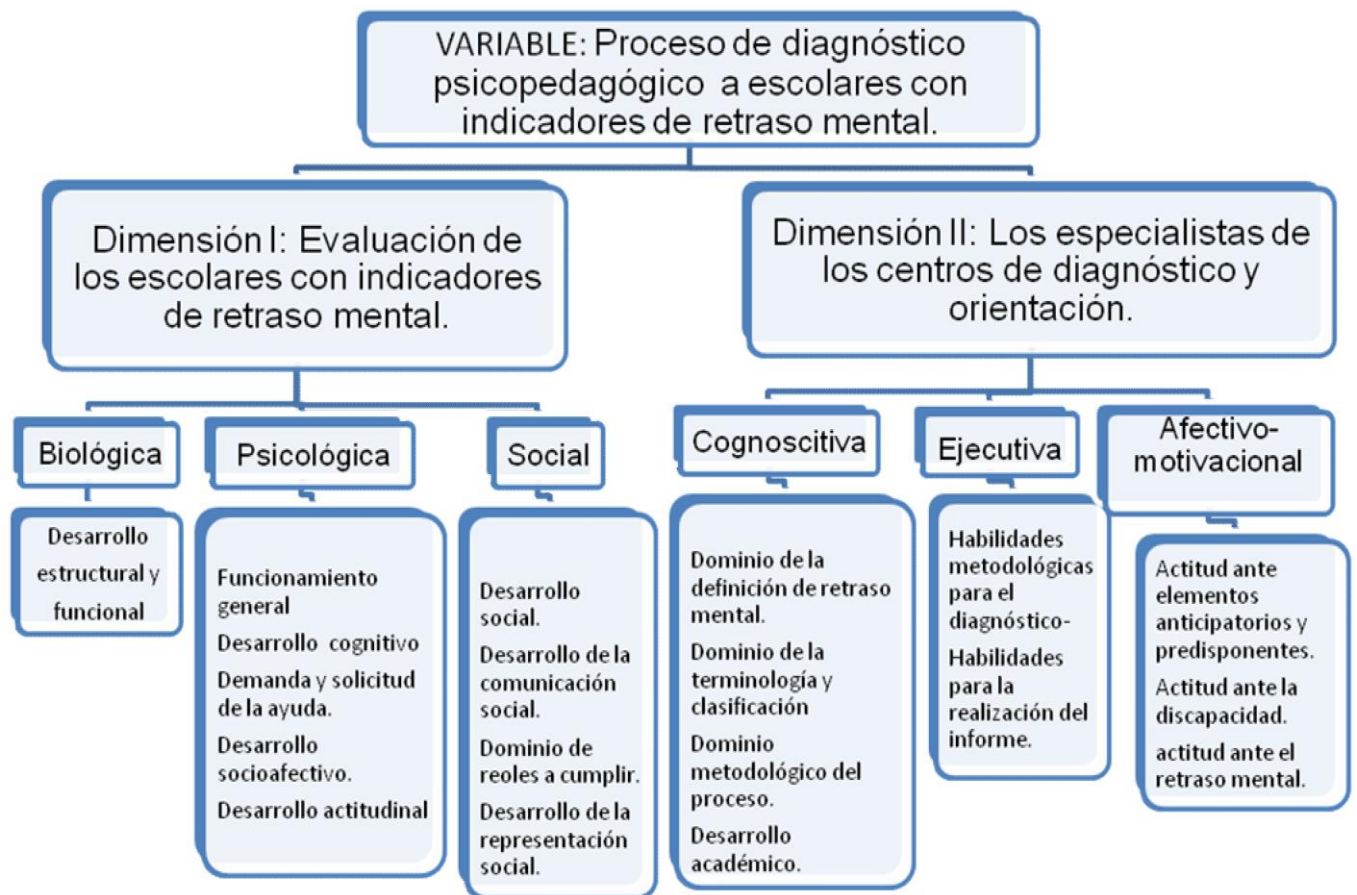
Las 3 subdimensiones son: cognoscitiva, ejecutiva y afectivo-motivacional

Operacionalización de la variable:

De acuerdo con los intereses investigativos se precisaron los indicadores a tener en cuenta en cada subdimensión, a los cuales se les hizo corresponder los planos de análisis necesarios para su exploración empírica y valoración del estado actual.

El diseño o selección de los instrumentos se realizó teniendo en cuenta los indicadores a medir. Se utilizaron para cerrar la mayoría de los indicadores, las categorías: bajo, medio y alto.

En el siguiente esquema se representa la operacionalización de la variable:



Síntesis de la PARAMETRIZACIÓN

Los instrumentos escogidos para evaluar las dimensiones dan la posibilidad de recoger información acerca de todos los indicadores con los que se pretende evaluar y medir a las tres subdimensiones y sus correspondientes indicadores.

A continuación se muestran en una tabla los indicadores tenidos en cuenta para cada dimensión y subdimensión. Respecto a los planos de análisis de los indicadores, solo se refiere la cantidad; en el anexo 13 se presenta detalladamente la parametrización, que por abarcar dos dimensiones tan complejas su presentación total es muy extensa.

DIMENSIÓN I: Evaluación de los **escolares** con indicadores de retraso mental

Indicadores	Planos de análisis
<i>Para la subdimensión biológica</i>	
1. Desarrollo estructural y funcional del organismo	2
<i>Para la subdimensión psicológica</i>	
1. Funcionamiento general	4
2. Desarrollo cognoscitivo	5
3. Demanda y asimilación de la ayuda	5
4. Desarrollo socio-afectivo	7
5. Desarrollo Actitudinal	9
<i>Para la subdimensión social</i>	
1. Desarrollo social	4
2. Desarrollo de la comunicación social	4
3. Dominio de roles sociales a cumplir	4
4. Desarrollo de la representación social	3

DIMENSIÓN II: Los especialistas de los CDO	
Indicadores	Planos de análisis
<i>Para la subdimensión Cognoscitiva</i>	
1. Dominio de la definición de retraso mental.	3
2. Dominio de la clasificación y terminología	2
3. Dominio metodológico del proceso de diagnóstico	3
4. Desarrollo académico	3
<i>Para la subdimensión Ejecutiva (Subdimensiones)</i>	
1. Habilidades metodológicas para el diagnóstico	8
2. Habilidades en la confección del informe	11
<i>Para la subdimensión afectivo-motivacional</i>	
1. Actitud ante la influencia de elementos predisponentes y anticipatorios	2
2. Actitud ante la discapacidad	5
3. Actitud ante el retraso mental	6

Para cada subdimensión, indicador y plano de análisis se hará corresponder uno de los siguientes parámetros: bajo, medio o alto. El criterio que se tendrá en cuenta es el valor porcentual respecto a los planos de análisis de cada indicador, considerando la correspondencia de la siguiente manera.

Para los indicadores

Si de sus planos de análisis:

- el 25% es alto o medio y el 75% es bajo. Corresponderá BAJO al plano.
- el 50% es bajo y el resto medio o alto Corresponderá MEDIO al plano.
- el 25% es medio y el 75% es alto. Corresponderá ALTO al plano.

Para las subdimensiones

Si de todos sus indicadores:

- el 25% es alto o medio y el 75% es bajo. Corresponderá BAJO a la subdimensión.
- el 50% es bajo y el resto medio o alto Corresponderá MEDIO a la subdimensión.
- el 25% es medio y el 75% es alto. Corresponderá ALTO a la subdimensión.

Para el análisis estadístico se asignó un valor a cada parámetro que permitió utilizar medidas de tendencia central necesarias para valorar si hay o no cambios en los indicadores y su trascendencia (Media).

Nota: Los planos de análisis valorados cualitativamente serán evaluados de la siguiente manera:

Si es evaluado como:	Se asignará el parámetro:
Inapropiado / negativo / bachiller	bajo
Indiferente / neutral / licenciado	medio
apropiado / positivo / máster o doctor	alto

2.3 Exploración empírica del modelo actuante (CURSO 2006/2007)

Grupos de estudio:

Grupo 1: 20 escolares con diagnóstico reciente de retraso mental (2005/2006)

Grupo 2: 20 escolares con indicadores de retraso mental (en proceso de diagnóstico actual 2006/2007)

Grupo 3: Docentes y especialistas

A- Especialistas: 20 de los Centros de Diagnóstico y Orientación de la provincia La Habana (actual Artemisa) y 20 de los Centros de Diagnóstico y Orientación de la provincia Ciudad de la Habana (5 del equipo técnico asesor provincial y 15 directores de los CDO de Ciudad de la Habana).

B- Docentes: 35 docentes (20 maestros de escuelas primaria y 15 maestros de la escuela especial para escolares con retraso mental del municipio Artemisa).

La valoración de la **DIMENSIÓN I: *Evaluación de los escolares con indicadores de retraso mental***, se realizó a través del análisis de documentos: caracterizaciones psicopedagógicas, estrategias educativas, adaptaciones curriculares, informe psicopedagógico del CDO y actas de comisiones de apoyo al diagnóstico (CAD) en el grupo 1 de la muestra se requirió de un análisis retrospectivo. Para el grupo 2 se realizaron observaciones (anexo 4) a sesiones de evaluación, visitas a su entorno natural por los especialistas y también se realizó el análisis de los documentos mencionados.

RESULTADOS POR INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA DIMENSIÓN I

Vale aclarar que aunque esta dimensión es relativa al escolar, los indicadores se han diseñado para valorar cómo se evalúa al escolar, no está destinado al escolar en sí, sino a quienes dirigen, implementan el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral (los docentes y especialistas) y el modo en que conciben, planifican y ejecutan la evaluación de ese grupo de escolares.

*Asimismo los resultados se basaron en el **análisis de los documentos:** caracterizaciones psicopedagógicas, expedientes acumulativos, registros de evolución y/o evaluación sobre los escolares y expedientes del CDO, en ambos grupos.*

Subdimensión biológica:

- *Desarrollo estructural y funcional del organismo*

En aquellos documentos en que se hacía alusión al sistema nervioso se refería la posibilidad de una lesión estática. Sólo en 7 de los 40 expedientes estaba una confirmación médica de la existencia de la misma, para un 17.5 %. Sin embargo, en 30 se confirma esa posibilidad por existir factores de riesgos relacionados con el embarazo, el parto o eventos relevantes ocurridos durante los dos primeros años de vida, para un 75%. Sólo en 5 con el Síndrome de Down se obtuvo un nivel bajo en el desarrollo de otras estructuras corporales, para un 12.5%.

Subdimensión psicológica:

- *Funcionamiento general*

El estado de la actividad cognoscitiva fluctuó entre bajo e inferior, para un 97%; solo 1 caso, al que le atribuyen una excesiva estimulación familiar, se evaluó como promedio.

En cuanto al estado emocional 36 casos para un 90% fluctuaron entre ambiguo e inconstante, el resto fue inadecuado. Respecto al estado volitivo ningún caso se consideró dispuesto ni perseverante. Asimismo el estado vivencial en el 100% resultó inconstante.

- *Desarrollo cognoscitivo*

Resultó ser en la que todos los planos fluctuaron entre bajo e inferior. De igual manera en el momento de estudio durante el primer o segundo grado, respecto a la competencia curricular, el 100% tenía sin lograr los objetivos del currículo escolar, es decir sin objetivos vencidos. No se encontró relevancia en el estado de los estilos de aprendizaje, en los 8 casos en que este aparecía descrito, para un 20%.

- *Demanda y asimilación de la ayuda*

No fue posible evaluar. Solo el plano respecto al nivel de ayuda que requiere se pudo evaluar como alto. Ya que en el 60% de los casos se expresaba que el menor requería entre el tercer y cuarto nivel de ayuda. En ningún caso se explicitaba lo relativo a la transferencia de la ayuda.

- *Desarrollo socio-afectivo*

Al igual que en el anterior indicador tampoco se pudo evaluar, puesto que no se encontró información relativa a los planos, excepto los relacionados con los niveles de relaciones entre coetáneos y con los adultos allegados.

- *Desarrollo actitudinal*

No se pudo encontrar ninguna información excepto en los indicadores de actitud ante el estudio y ante la escuela. Se describe en algunos casos como se comporta en esos contextos el niño, pero no se indaga en qué juicios, opiniones se ha formado

de ellos, si los acepta, rechaza, o si les resultan indiferentes.

Subdimensión social:

- *Desarrollo social*

Ninguna indagación realizada o recogida se refería a ello, es decir a cómo se manifestaban y evolucionaban sus aprendizajes sociales o prácticos.

- *Desarrollo de la comunicación social*

Se aborda solo académicamente y para describir el desarrollo del aspecto fisiológico del lenguaje; de modo que tampoco pudo valorarse si existían aprendizajes comunicativos para exponer temas, hablar en público etc.

- *Dominio de roles sociales a cumplir y desarrollo de la representación social*

Fueron totalmente imposibles de evaluar, ninguna indagación realizada o recogida se refería al contenido de estos indicadores.

Resultados de las **observaciones** a sesiones con vistas a la **dimensión I**: (anexo 10)

Subdimensión biológica:

- *Funcionamiento general*

Los especialistas observados al finalizar la sesión en su mayoría, no generalizan los datos obtenidos, excepto en aquellas sesiones de pruebas estandarizadas con el psicólogo en los locales del CDO donde se analiza el comportamiento durante la prueba, momento durante el cual surgieron referencias más globales como el estado de la actividad cognoscitiva y el estado emocional volitivo, este último de manera superficial enmarcado en adecuado o desajustado. No se hicieron referencias al estado vivencial, en el 100% resultó inconstante.

Subdimensión psicológica:

- *Desarrollo cognoscitivo*

Durante las observaciones se comprueba que este es el indicador mejor abordado, porque los especialistas poseen y emplean los recursos y capacidades para el adecuado abordaje y reconocen tener que emplearse con mayor tesón, por su carácter determinante en el diagnóstico de escolares con indicadores de retraso mental.

- *Demanda y asimilación de la ayuda*

En ningún caso se pudo observar la exploración en este plano, ni el uso de los niveles de ayuda, ni tareas para explorar la transferencia de la ayuda por lo que no se registraba en los documentos.

- *Desarrollo socio-afectivo:*

Es abordado de manera indirecta durante la entrevista a la familia.

- *Respecto a desarrollo actitudinal*

No se pudo observar ninguna acción o tarea para indagar o describir actitudes ni habilidades sociales.

Subdimensión social

- *Desarrollo social*

No se pudo observar ninguna acción o tarea para indagar o describir actitudes ni habilidades sociales.

- *Desarrollo de la comunicación social*

Se observaron tareas evaluativas pero desde la arista del lenguaje como función psicológica o académica. De modo que tampoco se recogieron datos que pudieran valorarlo en su totalidad.

- *Dominio de roles sociales a cumplir y desarrollo de la representación social*

Fueron totalmente imposibles de evaluar, ninguna indagación, realizada o recogida, se refería al contenido de estos indicadores.

RESULTADOS POR INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA DIMENSIÓN II

La subdimensión *cognoscitiva* lo que sabe, fue medida mediante la utilización de la encuesta y la entrevista. (anexos 1,y 2))

La subdimensión *ejecutiva* lo que sabe hacer se exploró mediante la observación durante la implementación de actividades del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral (anexo 3) y mediante el análisis del producto de la actividad profesional, específicamente la redacción del informe por especialidades y del informe diagnóstico final, los informes de visita a los centros escolares y de reevaluación.

La subdimensión *afectivo-motivacional* sus actitudes fue medida con instrumentos estandarizados elaborados específicamente con ese fin. Para el estudio realizado se seleccionaron como instrumentos (anexos 5 y 6)

El “Cuestionario sobre retraso mental” Verdugo²² (1994) consiste en 40 ítems con diferencial semántico y la “Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad-retraso mental” (Escala a) Verdugo²³ consiste en 23 ítems de diferencial semántico.

²². Verdugo M. A, . Arias B y Jenaro C. Adaptación de de la original –Mental Retardation Questionnaire, de Gan, Tymchuck, Nishihara, 1997- y presentada en el libro Actitudes hacia personas con minusvalías. INSERSO. Madrid.1994.

Resultados de las **encuestas grupales** (Anexos 7, 8 y 9)

Se aplicó una encuesta a diferentes grupos atendiendo a determinados objetivos. Al grupo de *docentes de las escuelas primarias* se les aplicó con el objetivo de recoger información acerca de sus valoraciones y vivencias del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral que dirige el CDO, con énfasis en sus opiniones, acerca de cuáles escolares consideran que requieren de una escuela especial, así como de aquellos escolares que estuvieron en las escuelas especiales y transitaron, es decir se han reinsertado en sus escuelas de procedencia.

Se aplicó también al grupo de *docentes de las escuelas especiales*, con el objetivo de recoger información acerca de sus valoraciones y vivencias del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral que dirige el CDO, con énfasis en sus opiniones, sobre los escolares de nuevo ingreso, así como de aquellos que tienen en la matrícula actual desde hace varios cursos y a quienes se les ha reevaluado por resolución ministerial en las comisiones de apoyo al diagnóstico (CAD).

Se aplicaron además al grupo de *especialistas de los CDO*, con vistas a la caracterización del proceso que dirigen y para describir y valorar las actuales prácticas de diagnóstico psicopedagógico integral que llevan a cabo en los equipos multidisciplinares.

Regularidades de la encuesta aplicada a los docentes

No se encontraron diferencias significativas entre los de la escuela regular y los de la escuela especial.

²³ Verdugo M. A., Arias B. y Jenaro C. "APD-RM -Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad, escala a" de adaptación presentada en el libro Actitudes hacia personas con minusvalías. INSERSO. Madrid.1994.

Fortalezas:

- Ambos grupos reconocen la necesidad de atención, diagnóstico y seguimiento a los escolares con indicadores de retraso mental.
- Ambos grupos poseen potencialidades; es decir, conocimientos empíricos y habilidades profesionales que bien encausadas podrían aprovecharse en pos del diagnóstico.

Debilidades:

- En ambos grupos se aprecia poco dominio sobre las características de los escolares con retraso mental, exceptuando las dificultades cognitivas.
- Ambos grupos, en mayor grado el de los docentes de primaria, se sienten ajenos al proceso de diagnóstico y no, como parte de él.
- En ninguno de los grupos se revelan suficientes habilidades para discernir entre un escolar con retraso mental leve y otro con significativas dificultades específicas de aprendizajes, plantean que en su rendimiento son iguales.

Regularidades de la encuesta aplicada a los especialistas del CDO

- Los especialistas han avanzado en el conocimiento de la definición de retraso mental, excepto lo relacionado con los modos de actuación social.
- Poco dominio de la aplicabilidad de la definición de retraso mental proceso de diagnóstico.

- Dificultades para establecer relaciones entre los propósitos de aplicación y el proceso de diagnóstico que acometen.
- Reconocen con dificultad las características de los modos de actuación social, que permitan considerarlas dentro de los criterios de diagnóstico del retraso mental.
- Le atribuyen a la clasificación un único propósito diagnóstico.

Resultados de las **observaciones a especialistas** de los CDO (Ver Anexo 10)

Se realizaron 40 observaciones al grupo de estudio 3-A. De ellas, 25 a sesiones del proceso en el medio natural durante la orientación y seguimiento en las escuelas primarias u hogares y 15 a sesiones evaluativas en las sedes de los equipos multidisciplinarios.

Los elementos relevantes se exponen a continuación:

Regularidades encontradas luego del total de sesiones de observación

Debe aclararse que las diferencias encontradas entre un tipo de sesiones u otras no fueron significativas a la hora de encontrar regularidades relativas a los especialistas. Solo se percibieron cambios en cuanto a las condiciones como variable ajena no controladas en el proceso.

Fortalezas:

- Los especialistas revelan cualidades positivas que les permiten utilizar recursos o habilidades profesionales para manejar situaciones, lograr la comunicación, entre otros aspectos.

- Revelan adecuada preparación en la especialidad que les permite aplicar correctamente los instrumentos cumpliendo con la metodología para ello.
- Los especialistas realizan un trabajo de relativa calidad, aunque existen aspectos que hay que modificar con vistas al perfeccionamiento.

Debilidades o limitaciones:

- No siempre se planifica y concreta la estrategia diagnóstica a seguir durante el proceso, sobre todo, para las actividades diagnósticas que se realizan fuera de las sedes de los equipos, en los centros escolares, comunitarios u hogares de familia.
- El soporte material del sistema instrumental es insuficiente.
- No son creativos en la aplicación de pruebas para enriquecer el análisis cualitativo general, luego de aplicar la prueba no realizan ensayos que sin alterar el resultado ya registrado, les muestre lo potencial, es decir, si puede acertar con ayuda lo que no logró durante la prueba. No exploran la zona de desarrollo próximo.
- Para el proceso de diagnóstico no se reveló verdadero trabajo de equipo, no se aprovechan suficientemente a los docentes y familiares, los cuales son implicados solo como proveedores de información.
- Existe una percepción errada del personal de las escuelas respecto al contenido que le atribuyen al proceso que dirigen los CDO.

- Existen actitudes de rechazo encubierto o indiferencia ante la discapacidad.

Resultados en la aplicación de los **instrumentos para medir actitudes** en la

Dimensión II:

Verdugo, M. A. y Arias B.²⁴ plantean que *“las actitudes son un conjunto de predisposiciones que implica respuesta ante una clase específica de objeto o persona y que adoptan diferentes formas”*. Estos autores elaboraron y validaron instrumentos con vistas a medir y valorar las actitudes, de los cuales se seleccionaron dos para medir la subdimensión *Afectivo motivacional* donde se exploran las actitudes. Vale realizar algunas precisiones sobre ellos a continuación. (anexos 11 y 12)

El “cuestionario sobre retraso mental”, consiste en 40 ítems de los cuales las personas deben asignar un número del 1 al 5 correspondientes a las siguientes categorías: (1) totalmente de acuerdo, (2) bastante de acuerdo, (3) no estoy seguro, (4) bastante en desacuerdo y (5) totalmente en desacuerdo.

La “escala de actitudes hacia las personas con retraso mental” Escala A consiste en 23 ítems de los cuales las personas deben seleccionar una de las opciones siguientes (muy de acuerdo, bastante de acuerdo, parcialmente de acuerdo, muy en desacuerdo, bastante en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo)

Estos instrumentos fueron utilizados porque son estadísticamente probados, válidos, fiables y multidimensionales teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria en cuanto a

²⁴ Verdugo, M. A.. *“Actitudes hacia las personas con minusvalía”*. Editora Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid 1994. Pág. 91.

la definición, medición y conceptualización de las actitudes. Además ambos se ajustan y coinciden con los fines de esta investigación.

Los resultados obtenidos (ver anexos 11 y 12) no arrojaron diferencias significativas entre los grupos, de manera general revelaron que existen actitudes de rechazo encubierto o indiferencia ante la discapacidad y el retraso mental.

TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA.

Se compararon durante la triangulación, los resultados de métodos como el análisis de documentos, la encuesta, la entrevista y la observación.

Resultados de la **DIMENSION I.** por subdimensiones:

BIOLÓGICA:

- Los planos de análisis del primer indicador estaban investigados y eran conocidos y evaluados acertadamente; sin embargo, generalmente no se precisa lo relacionado con la lesión del SNC.
- El indicador respecto al nivel de desarrollo de las estructuras del SNC en un 84% de la muestra es bajo.
- El segundo plano de análisis, se reveló insuficientemente abordado.

PSICOLÓGICA:

- No se investiga lo relacionado con el indicador desarrollo actitudinal, mientras que la demanda y solicitud de la ayuda y desarrollo socio-afectivo se analizan parcialmente.
- Respecto al indicador *desarrollo cognitivo*, los planos revelaron que se trabaja profundamente con las herramientas y procedimientos establecidos; es

aquí donde más bajos niveles de desarrollo mostraron los escolares de la muestra.

- En cuanto a las relaciones con sus coetáneos, adultos allegados, las habilidades de autovalidismo y socio-comunicativas, el 60 % de la muestra logró un nivel medio y un 10% alto.

SOCIAL:

- No se encontró información respecto al contenido de los indicadores y sus planos de análisis, solo algunos elementos aislados y unidos a indicadores de otras subdimensiones, sin una clara intención de su valoración.

Resultados de la **DIMENSION II.**

Al realizar la triangulación de los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos se pudieron agrupar regularidades coincidentes en todos ellos para cada indicador de la dimensión II.

Por indicadores:

Dominio de la definición de retraso mental

Los especialistas conocen la definición, dos de los indicadores fueron evaluados de alto nivel, no así el de los criterios diagnósticos, que resultó bajo.

Dominio de la clasificación y terminología

Los especialistas reconocen solo la clasificación atendiendo a la profundidad del defecto. Asimismo, como única finalidad aceptan la elaboración de la estrategia educativa. Este indicador se evaluó en un nivel bajo de sus planos de análisis.

Dominio metodológico del proceso

Evaluados de alto excepto el plano respecto al nivel de dominio del sistema instrumental, evaluado como medio, lo que está ocasionado por desconocimiento o ausencia de instrumentos, que midan las habilidades sociales y prácticas, y por la agrupación y selección de las técnicas atendiendo a la impresión diagnóstica, que aún no es del todo acertada.

Desarrollo académico

Existe heterogeneidad en los especialistas, predominan los de nivel universitario con grado de licenciado, para un 90%, el 4% alcanzó el grado máster y el 6% de bachiller. En cuanto a grado científico, ningún especialista en proceso doctoral.

Habilidades metodológicas para el diagnóstico

Este indicador, en la mayoría de sus planos, resultó evaluado de un alto nivel. Excepto los indicadores de jerarquización de necesidades y elaboración de adaptaciones curriculares, medio el primero y bajo este último.

Habilidades en la confección del informe

Los planos que miden habilidades para: valorar el desarrollo de aprendizajes prácticos y sociales en los escolares, revelar la relación dificultades-necesidades-capacidades y proponer adaptaciones curriculares, fueron evaluados de un nivel medio, el resto resultó de alto nivel.

Actitud ante la influencia de elementos predisponentes y anticipatorios

Los especialistas apoyan la creencia de límites definidos para avizorar el desarrollo de los escolares y establecer el pronóstico. En general, este indicador se evalúa en un nivel medio.

En los indicadores actitud ante la discapacidad y ante el retraso mental.

Se encontraron actitudes inapropiadas según los instrumentos aplicados para medir los indicadores (Ver anexo 19).

Asimismo, las regularidades obtenidas en la dimensión II también pueden presentarse por *Subdimensiones*.

COGNITIVA:

- Los especialistas tienen dificultades respecto a los propósitos y uso de la definición de retraso mental para el diagnóstico.
- El nivel de dominio acerca de los criterios de diagnóstico en la mayoría del grupo de estudio es bajo, para un 20%. Es preponderante el dominio del criterio relacionado con el desarrollo cognitivo y su manifestación académica concreta. No se revela dominio del resto de los criterios.
- Existen carencias en cuanto a cómo indagar y explorar los aprendizajes prácticos, sociales y las habilidades correspondientes a los escolares con indicadores de retraso mental.

EJECUTIVA:

- Se revela un pobre desarrollo de las habilidades para evaluar las potencialidades y explorar la zona de desarrollo próximo.
- Se encontraron dificultades en la elaboración del informe, por ejemplo para realizar el diagnóstico explicativo y describir o explicar las potencialidades.
- En cuanto a las habilidades metodológicas están insuficientemente desarrolladas aquellas necesarias para hacer *corresponder las acciones*

educativas y/o de apoyos con las necesidades, jerarquizar adecuadamente las necesidades al diseñar acciones que la satisfagan y, finalmente, para diseñar y elaborar adaptaciones curriculares.

AFFECTIVO-MOTIVACIONAL:

- Existen actitudes inapropiadas ante las influencias de los mitos que enmarcan límites de desarrollo en los sujetos con retraso mental.
- Las actitudes ante la discapacidad y el retraso mental se revelan también como inapropiadas. No se encontraron diferencias entre los especialistas y docentes, ni entre los docentes de la educación primaria y los de la educación especial.

Conclusiones del capítulo

Las fortalezas y debilidades, que describen las dos dimensiones de la variable como resultado de la caracterización del estado actual del proceso de diagnóstico psicopedagógico son, en sí mismas, acicate para la elaboración y presentación de un **modelo de diagnóstico psicopedagógico integral para escolares con indicadores de retraso mental**, cuyos componentes sean los necesarios, no sólo para el mejoramiento del modelo actuante, sino en primera instancia, para *acercar más a la realidad de este grupo y sus familias la atención educativa integral que demandan sus necesidades.*

CAPITULO III MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL DE ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL EN EL CDO

3.1 Fundamentación del modelo para el diagnóstico psicopedagógico integral de escolares con indicadores de retraso mental en los CDO

Las últimas investigaciones en el campo de la psicología y la educación han dado como resultado nuevas maneras de aplicar desde sus fundamentos filosóficos y psicológicos, el enfoque bio-psico-social asumido en Cuba desde hace ya más de dos décadas. El ámbito educacional no exime de ello al diagnóstico psicopedagógico integral, por el contrario se impone revelar esta postura en las actuales prácticas de diagnóstico. Como consecuencia se asume necesariamente una etapa de transformaciones también en esta área.

En el caso del retraso mental, particularmente, resulta un tanto más difícil conseguir aplicar este modelo teórico al proceso de diagnóstico psicopedagógico integral por la heterogeneidad del grupo y la variabilidad en el funcionamiento que lo caracteriza. Además, la manera arraigada de entender al retraso mental como un problema predominantemente biológico, de lo cual es responsable el modelo anterior que sustentaba a las prácticas, todavía recientes, de diagnóstico. Pudiera ser también un elemento significativo las representaciones sociales y las actitudes ante la discapacidad, en general, y el retraso mental, en específico, fenómeno observable en todas las capas sociales, que no excluye a los propios especialistas: psicólogos, psicopedagogos y pedagogos especializados en Educación Especial, otrora defectólogos, entre otros.

Hoy día, no constituye una prioridad determinar diferencialmente el retraso mental de las dificultades de aprendizaje, solo para seleccionar la modalidad de atención, prejuiciar posibilidades de aprendizaje o desarrollo como hasta hace algún tiempo; continúa siendo importante esta diferenciación, pero para la obtención de todos los elementos personológicos y ambientales que en su interacción e influenciados contextualmente han determinado la actual expresión de los niveles de desarrollo humano: biológico, psicológico y social, lo que, sin lugar a dudas, permitirá un acertado proceso que conduzca a una adecuada atención educativa integral, que contenga los apoyos individuales y colectivos que cada caso demande.

Esta investigación pretende acercarse a la solución de esta problemática al *proponer un modelo para el diagnóstico psicopedagógico integral de escolares con indicadores de retraso mental*. Este modelo es fruto del análisis crítico del modelo actuante y de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos elegidos o diseñados para su exploración empírica.

En la investigación se asume la siguiente definición de modelo, ofrecida por Valle, A. (1987)²⁵ cuando plantea que “es la representación de aquellas características esenciales del objeto que se investiga, que cumple una función heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades de ese objeto de estudio con vistas a la transformación de la realidad”. Y añade que en él “revela una determinada unidad entre lo objetivo y lo subjetivo. Permite operar de

²⁵ Alberto D. Valle Lima. Citado por el propio autor en su libro “Metamodelos de la investigación pedagógica” Libro en formato digital. Pág. 9.

manera práctica o teórica con un objeto o fenómeno, no de manera directa, sino utilizando el modelo como sustituto siempre que se encuentra en determinada correspondencia con el propio objeto; en determinadas etapas del conocimiento el modelo permite sustituir al objeto y ofrece, en ausencia del objeto, información sobre el objeto”

Finalmente, el autor concluye proponiendo como “...componentes para los modelos en el marco de las ciencias pedagógicas los siguientes principios, fin y objetivos, estrategia o metodología, formas de implementación del modelo y formas de evaluación del modelo”. Esta distribución de los componentes se tuvo en cuenta para la conformación del modelo que se presenta.

3.2 Componentes del modelo de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental

Para la remodelación que condujo al modelo propuesto, se siguió el mismo orden lógico de los elementos a considerar para valorar un modelo de diagnóstico, numerados de igual manera.

I. ANÁLISIS TEÓRICO

Existe coincidencia con los fundamentos que se presentan en el modelo actuante; sin embargo, para el modelo propuesto se reorganizan, enriquece el sistema de principios al añadir otros a partir de su relación con las categorías fundamentales del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral.

II- ESTUDIO DE SISTEMAS DE INSTRUMENTOS

Para la valoración del modelo que se propone se utilizó el mismo sistema instrumental que para la construcción del actuante. Su aplicación y análisis fueron previstas en las etapas de implementación. Para su cumplimiento se elaboró y aplicó una guía de acciones por etapas, con vistas a la retroalimentación y evaluación de la factibilidad del modelo. (Ver anexo 22)

III- ELABORACIÓN DEL SISTEMA CONCEPTUAL

Tal como en el modelo actuante, el sistema conceptual comprende los elementos conceptuales relevantes relacionados con las consideraciones teóricas y metodológicas del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental a partir de los que se determina el fin, los principios y las categorías, que lo sustentan. Asimismo, incluye los objetivos, las precisiones metodológicas presentadas en el componente denominado la ejecución del proceso.

Los principios que sustentan el proceso se revelan en las relaciones internas de interdependencia, coordinación y subordinación, que se dan entre los principios y las cualidades del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral como su carácter dinámico, continuo, único, cíclico.

FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO PROPUESTO

Fundamentos Generales

En el modelo se contextualizan los fundamentos de la Pedagogía cubana en el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral en sus aspectos filosóficos, sociológicos, biológicos, psicológicos y pedagógicos.

El proceso de diagnóstico psicopedagógico integral se asume en esta tesis tomando como fundamento principal la *dialéctica materialista* y sus fundamentos. De ahí que este proceso se aborda en su dinamismo y movilidad, en tanto las condiciones personales de desarrollo del sujeto y los agentes ambientales o contextuales son dinámicos, se pueden modificar espontáneamente y/o de forma planificada o estratégica y, finalmente, esta variabilidad se revelará en el diagnóstico. Esta manera dialéctica de asumir el desarrollo humano caracteriza el proceso, dándole espacio a la flexibilidad ante estados aparentemente inamovibles relacionados con la condición de salud en sus elementos estructurales y funcionales, que si bien es cierto que son innegables, también lo es que la interacción con otros aspectos psicológicos o sociales varían el modo de manifestación de la discapacidad correspondiente a ese(os) estado (s). Esto sucede en arreglo a lo histórico y cultural, en lo general, o la influencia de los contextos, en lo particular.

La *Filosofía de la Educación* en su esencia responde a ¿qué es educar?, ¿para qué se educa?, ¿por qué se educa? Al realizar el estudio de los fundamentos que aporta esta ciencia al diagnóstico psicopedagógico integral se analiza la relación de esas interrogantes con aquellas que plantean: ¿qué es diagnosticar?, ¿para qué se

diagnostica?, ¿por qué se diagnostica?, fundamentos filosóficos que ayudan a precisar el fin y los objetivos mediatos del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral. Se asume que debe existir coherencia entre ambos grupos de respuestas al tratarse de un mismo proceso, el proceso educativo en el cual está inmerso el diagnóstico psicopedagógico integral.

Por otro lado, la *Sociología de la Educación* en su esencia permite dar respuesta a otra interrogante ¿en qué medio se educa?, la que conduce rotundamente a los contextos, a las condiciones, a la estructura social, que rodea al acto educativo y en equivalencia con el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral se tienen en cuenta las influencias que sobre los escolares ejercen los contextos en que se desarrollan y que se expresan en los niveles biológico, psicológico y social del desarrollo humano.

Los fundamentos *biológicos*, se corresponden con la determinación de las características que distinguen el estado de las estructuras y funciones del organismo, con énfasis en las relacionadas con el sistema nervioso central, en el que se ha demostrado particularidades para el grupo objeto de estudio, sin embargo la consideración del déficit asociado a los elementos biológicos se tienen en cuenta sólo para comprender el funcionamiento real y potencial de los escolares que se diagnostican en la interrelación con el resto de los niveles del desarrollo humano influenciada por los contextos.

Los fundamentos *psicológicos*, se corresponden con los de la escuela histórico-cultural, representada por L. S. Vigotsky.

Para él y sus seguidores el niño es un ser social, protagonista y producto de las interacciones sociales, implicando lo inter-psíquico con lo intrapsíquico, lo que magistralmente se explica en la ley genética fundamental del desarrollo, en la ley acerca de la dinámica del desarrollo o la llamada situación social del desarrollo, en lo relacionado con la zona de desarrollo próximo y el papel de los “otros” en el proceso de desarrollo (adultos y coetáneos), la forma en que se conforma la estructura de la conciencia en el proceso de formación, el papel de las vivencias, la actividad y la comunicación en el proceso formativo y el mecanismo de la asimilación y la acomodación. Postulados que ponderan el papel de la enseñanza y la educación, todos de incuestionable valor para el diagnóstico psicopedagógico integral.

La *Psicología de la Educación* responde a ¿Quién se educa?, ¿quién educa? Estas preguntas conducen a las estructuras psicológico-fisiológicas del alumno, del grupo escolar, del maestro, los especialistas y a sus interrelaciones. En sus fundamentos el modelo asume la respuesta a ¿Quién se diagnostica?, ¿quién diagnostica? Al prever un conocimiento profundo de los elementos psicológicos que distinguen a una persona con retraso mental, teniendo en cuenta los elementos psicológicos que por implicación personal de los especialistas que diagnostican pudieran permear el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral.

Los fundamentos *pedagógicos* se sustentan en la *Pedagogía*, como ciencia de la educación, quien utiliza el diagnóstico psicopedagógico integral para profundizar y transformar el estado educativo del escolar, en estrecho vínculo con los agentes sociales como potenciadores efectivos de desarrollo del escolar.

De esta forma se establece la relación entre la sociedad, la cultura y la educación como sistema, dirigida a lograr la integración del escolar como elemento activo y transformador. Se reconoce la relación entre la Pedagogía General y Especial, en su relación con otras ciencias de la educación como fundamentos pedagógicos como parte del propio enfoque psicopedagógico.

Fin

Se mantiene el mismo fin determinado para el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral, de la concepción teórica subyacente sistematizado, cuya finalidad que es ofrecer la *atención educativa integral* a los escolares con indicadores de retraso mental.

Además se incluye un *objetivo* más a los *objetivos generales* de la concepción, enunciado de la siguiente manera: *diseñar acciones o apoyos para el logro del nivel mínimo posible de expresión de discapacidad*; es decir, acciones que reduzcan al mínimo posible las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación social, al considerar la dinámica del desarrollo; todo lo que, en última instancia, coadyuva a reducir el nivel en que se expresa la discapacidad.

En el modelo actuante se abordaron los elementos teóricos y metodológicos del diagnóstico psicopedagógico integral, a los que se le confiere su innegable y estrecha relación dialéctica y de coordinación entre ellos; sin embargo, durante el proceso investigativo se encontraron elementos suficientes que revelaron la necesidad de su enriquecimiento, reflejados en la fundamentación del modelo propuesto.

Consideraciones teóricas y metodológicas

En este acápite se enmarcan tres grupos; dos teóricos: A- La concepción general multidimensional de retraso mental y B- La concepción del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral y uno metodológico: C- Las fases de ejecución.

A- Concepción de retraso mental/Discapacidad intelectual

La concepción general del retraso mental, que asume el modelo es el fruto de la tradición pedagógica enriquecida por la práctica educativa y las investigaciones que dentro de ella han tenido lugar, además se incorpora, a partir de la sistematización en Cuba de los cambios conceptuales a nivel internacional desde una postura dialéctico-materialista, histórico-cultural y electiva de la ciencia: la multidimensionalidad en que se expresa el desarrollo del grupo de personas con retraso mental. No se asumen literalmente las concepciones foráneas; sin embargo, de ellas se retoma este enfoque, en tanto existen particularidades que lo distinguen y que han de tenerse en cuenta para el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral.

Cada una de las dimensiones que se proponen tener en cuenta serán explicadas desde los supuestos histórico-culturales, lo que conllevó a su reorganización y nominación, de acuerdo con las tradiciones y experiencia acumuladas del diagnóstico psicopedagógico en la práctica educativa cubana. Para esta investigación se asumen las siguientes dimensiones: salud (biológica), esfera intelectual y esfera afectiva (psicológicas), Modos de Actuación Social y Participación Social (sociales).

Se ha renombrado la dimensión ‘conducta adaptativa’ como “modos de actuación social”, lo que difiere del modelo teórico aceptado a nivel internacional. Para evitar caer en el error de interpretación considerando que el individuo durante su desarrollo debe solo adaptarse a lo socioambiental, sin conceder la debida importancia a la dialéctica que se expresa en esta relación que tiene un carácter dinámico en su causalidad y variable en su expresión tal y como se abordó en el primer capítulo de este informe al nominar esta dimensión que caracteriza al retraso mental y a las posibilidades que estas personas tienen de logra, emplear los aprendizajes prácticos y sociales. Todo ello se sustenta en la concepción cubana que pondera el papel activo y transformador del sujeto en su desarrollo.

La dimensión participación e interacciones sociales, en el modelo propuesto engloba las características del modo personal en que el individuo participa, su nivel de aceptación individual, el nivel de correspondencia con sus propios intereses y motivaciones y, finalmente, los tipos concretos de actividades, micro, meso y macrosociales en las que se involucra.

Otras dos dimensiones del modelo internacional son: esfera intelectual y salud. Las cuales se asumen dentro del modelo propuesto, pero con énfasis en su relación y la influencia de los contextos, a partir de cuestiones de orden teórico que tienen una tradición histórica y siempre han sido valoradas durante el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral que se realiza por los Centros de Diagnóstico y Orientación. Este análisis devino en la consideración sobre la última dimensión según la AAIDD: Contextos, para esta investigación no debe ser circunscrita a las características que

distinguen al retraso mental, sino que es un componente relevante a considerar en el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral que hay que abordar desde dos aristas, la propia valoración del ambiente en sí con sus cualidades negativas o positivas, las interacciones que se han dado y se revelan en el desarrollo actual de cada caso en particular y las características que tiene la actividad del escolar en cada contexto. De modo que en el modelo propuesto el *contexto* no se acepta dentro del enfoque multidimensional de la entidad, sino que se engloba en la totalidad del proceso, con énfasis en la relación que tiene con los apoyos y los sujetos participantes.

Además de asumir la multidimensionalidad del retraso mental, se reconoce la necesidad de determinar los *criterios diagnósticos*, para ello se retoman del modelo actuante y se enriquecen con su correspondiente salida en el sistema instrumental tradicional y vigente.

Criterios diagnósticos para el retraso mental:

- 1) Insuficiencia general en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores.
- 2) Significativo compromiso en la actividad cognoscitiva causada por afectación importante en el sistema nervioso central por factores genéticos, biológicos o de infraestimulación socio-ambiental.
- 3) Compromiso funcional en dependencia de la afectación en el sistema nervioso central, la situación social del desarrollo y la oportuna estimulación.

4) *Presencia de limitaciones significativas en las manifestaciones y desarrollo de los modos de actuación social y la participación social.* (Añadido para el modelo propuesto)

Se propone considerar para el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral, los indicadores de posible retraso mental en la edad temprana y preescolar, elaborados por Travieso L. E. (2008)²⁶ Específicamente para la fase de pesquisaje, en la que aún no se han reunido los datos necesarios para comprobar y demostrar los criterios y arribar al diagnóstico gnoseológico. Su consideración servirá para que estos menores sean incluidos en el proceso, para la hipótesis diagnóstica inicial, la selección de los procedimientos, tareas, herramientas a utilizar y para la comprensión del desarrollo ontogenético, ya que en cada período continuarán manifestándose.

B- Concepción de diagnóstico psicopedagógico integral:

No se requiere de la elaboración ni fundamentación de una concepción, en tanto la existente se adecua a la postura de la autora y a los propósitos investigativos delimitados para esta tesis; por tanto, se asume la concepción sistematizada en el primer capítulo del informe y se reconoce que el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral se rige por una serie de principios que se abordaron en sus fundamentos; sin embargo, durante la profundización teórica y exploración empírica, se encontraron carencias de índole teóricas que condujeron la investigación hacia nuevos planteamientos en el orden de los principios que sustentan el diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental.

²⁶ Travieso L. E, 2008. El desempeño profesional y humano de los promotores del Programa –educa tu hijo...Tesis doctoral-

Se reformulan los principios; al entender que son: “las posiciones rectoras de partida, las normas, conceptos y criterios, en que se fundamentan, introducen, ordenan, disponen, establecen y garantizan las relaciones entre los conceptos teóricos y metodológicos, del funcionamiento de la concepción asumida”. A partir de ello se consideran principios del modelo los presentados en el primer capítulo a los que se consideró necesario:

Añadir los principios revelados en su tesis en opción al grado científico, por la Dr. C. Akudovich, S. (2004) Ellos son:

Principio de la unidad entre la actividad y comunicación en el proceso de diagnóstico de la zona de desarrollo próximo.

Este principio se refiere a la consideración de la comunicación, interacción entre el maestro y el alumno en el proceso de la actividad de diagnóstico como un elemento esencial en el cual se crea y se estudia la zona de desarrollo próximo del alumno. El tipo de comunicación, interacción y colaboración que se establece en esta actividad constituyen las fuentes principales del estudio de la zona de desarrollo próximo en el escolar.

Principio de promoción del desarrollo.

Este principio enfatiza el fin del proceso de diagnóstico en general y de la zona de desarrollo próximo, en particular, relacionado con la promoción del desarrollo de los alumnos sobre la base de sus potencialidades y constituye la premisa para elaboración de las estrategias que conllevan a la conformación de la atención educativa integral como fin.

La autora de la tesis considera pertinente añadir tres nuevos principios para fundamentar el diagnóstico psicopedagógico integral. Ellos son:

El principio del enfoque multidimensional del retraso mental

Para cada individuo que se estudia se deben tener en cuenta las características, logros y limitaciones en las cinco dimensiones que se le reconocen al retraso mental: (esfera intelectual, esfera afectiva, modos de actuación social, salud y participación social). Para ello, se requiere de un sistema instrumental que permita indagar cada una y revelar las relaciones entre ellas, así como las repercusiones contextuales.

El principio del carácter dinámico y variable de la expresión de discapacidad

La discapacidad se expresa de un modo variable y dinámico, en dependencia de las interacciones entre los elementos biológicos, psicológicos y sociales, bajo la influencia de factores contextuales. Ello determina que individuos con deficiencias similares en las estructuras o funciones del organismo revelen diferencias significativas en las características de su actividad y participación social. Asimismo éstas varían bajo el influjo de factores que incidan durante un tiempo, lo que conlleva a que el nivel de expresión de la discapacidad en una misma persona también cambie; ésta se puede generar, aumentar o reducir.

Principio de la vinculación de las familias y la comunidad con un carácter activo al proceso de diagnóstico psicopedagógico integral

Cuando se implica a la familia y otros agentes sociales en el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral, éstos se vinculan como parte activa del mismo, no como proveedores de información ni como testigos oculares, sino agentes activos que realizan tareas como: indagaciones, observaciones o provisión de apoyos a corto plazo con propósitos diagnósticos definidos, bajo la guía de los especialistas del CDO.

Este principio ha sido descrito y asumido por algunos pedagogos cubanos para la práctica educativa, pero su consideración para el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral, lo redimensiona. Además, favorece que se revele el carácter interventivo del proceso y ayuda al perfeccionamiento de sus mecanismos mediante la retroalimentación e interacción con la familia u otros agentes, al reconocer, mitigar o modificar elementos entorpecedores para el desarrollo de los escolares en estudio, de los cuales ellos pudieran ser responsables.

C- La ejecución del proceso

La aplicabilidad de todos los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral depende de los elementos metodológicos de la concepción, los que deben mostrar entre sí una coherencia dinámica y dialéctica con los teóricos; debe permitir que aquéllos se revelen en la práctica. Comprende dos elementos importantes: las *fases del proceso* y el *sistema instrumental*.

Fases del proceso:

Se retoma del modelo actuante el orden en que se desarrollan las tareas del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con retraso mental; sin embargo se reorganiza y renombran las fases, pues se considera importante que en ellas: se establezca la dinámica causal para explicar el desarrollo, se revele el carácter continuo, cíclico e inacabado del proceso, donde elementos tan importantes como la realización y uso de la caracterización psicopedagógica, el diseño y ejecución del proceso de Orientación y Seguimiento sean parte de él como proceso único.

La fase 1: *pesquisaje y evaluación inicial*.

Se basa en la utilización de instrumentos breves previamente preparados. Todo lo que se enmarca en la labor de *orientación y seguimiento* que se lleva a cabo en todos los centros educativos del país y que dirigen los especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación.

Su aplicación puede realizarse de forma individual o colectiva si las condiciones lo requieren; sirve como indicador primario del estado real de los escolares, tanto de la esfera cognitiva como de la esfera afectiva. Para ellos se toman en cuenta los indicadores de posible retraso mental para la edad temprana y preescolar.

Tiene un primer momento donde los docentes en el medio natural, bajo la guía de los equipos y sus especialistas pueden aplicar instrumentos simples. Será ocasión ideal para comenzar la evaluación contextual y para la implicación, como participantes, de los agentes socio-familiares como parte del proceso en sí, lo que conlleva no solo a que conozca que el escolar está siendo objeto de atención, sino también los propósitos, las tareas y herramientas que se utilizarán, su argumentación y aquellas que de manera activa el asumirá.

Los docentes deberán lograr en estas familias una disposición a la participación, su cooperación y provisión de todos los datos e información requeridos por los docentes. Para asumir tareas, primero serán observadores y luego aportarán los resultados de las indagaciones, o participarán introduciendo apoyos de efecto a corto plazo, con propósitos de diagnóstico. En este momento inicial de la fase, también puede la trabajadora social conformar la anamnesis y comenzar la historia social.

Para ello, es relevante el empleo de la caracterización psicopedagógica, que

coadyuva a la descripción y explicación de los aspectos personales y socio-familiares de los escolares, al especificar sus cualidades positivas y negativas.

Los docentes cubanos tienen tradición en esta tarea y existe actualmente un aumento en la calidad de su realización. En el caso de la educación preescolar se sustituye la caracterización con la valoración del desarrollo, proceso que también se ha venido perfeccionando en esta educación.

Para el segundo momento de esta primera fase, se continúa con mayor rigor la evaluación específica de los escolares. Los propios especialistas podrán aplicar algunas de las metodicas psicológicas y psicopedagógicas tradicionales o estandarizadas, así como, realizar o asesorar las visitas a los contextos naturales: escolar, familiar y comunitario.

El rol directivo y ejecutivo en este segundo momento tendrá mayor peso en los especialistas, aunque los docentes y familiares, bajo su guía, continuarán siendo parte del proceso. Ello requiere la selección acertada y uso adecuado de instrumentos, test o pruebas estandarizadas que se requieran de acuerdo con las hipótesis diagnósticas. Aquí puede utilizarse por cada uno de los especialistas el sistema de instrumentos determinados para cada especialidad en el libro que norma el trabajo de estos centros.

De manera general, las tareas diagnósticas de esta primera fase serán:

- Proceso de orientación y seguimiento
- Realización de indagaciones en los centros educacionales para detectar escolares con problemáticas en su desarrollo y/o aprendizaje que pudieran corresponderse con los indicadores de retraso mental

- Detección de las dificultades, traducción en necesidades y determinación de potencialidades
- Aplicación de pruebas pedagógicas y psicopedagógicas
- Conformación de documentación, la historia social
- Aplicación de test y pruebas estandarizadas que midan o evalúen los elementos intelectuales, prácticos y sociales de la actividad del sujeto
- Caracterización de las 5 dimensiones del retraso mental

La fase 2: *Dinámica explicativa*.

En esta fase el propósito es explicar las interacciones entre los tres niveles del desarrollo y los contextos y las consecuencias de estas respecto al aprendizaje y desarrollo actuales del escolar.

Lo más importante es que una vez obtenido los datos, estos sean comparados con los estándares y que serán sometidos a un análisis sobre su dinámica causal, lo que puede explicar cada hallazgo, concretarlo como dificultades, necesidades o potencialidades y revelarlo en la elección, diseño e implementación de los apoyos y en la toma de decisiones que corresponden a esta fase.

De manera general las tareas diagnósticas de esta segunda fase serán:

- Análisis de los datos obtenidos a partir de la comparación con estándares
- Interpretación y correlación para obtener la dinámica causal y arribar a la explicación del diagnóstico

Debe culminarse con una discusión diagnóstica del equipo que logre la interpretación integradora de la información obtenida en su relación dialéctica con las decisiones tomadas y las que se tomarán en este momento, el establecimiento de

una dinámica explicativa de las necesidades y potencialidades en su interacción con los contextos, para finalmente, confirmar o reformular la hipótesis diagnóstica inicial, con vistas a poder determinar y asignar la modalidad educativa u otra asignación de servicios, lo que constituye el propósito de la siguiente fase.

La fase 3: Determinación de la atención educativa integral

Es donde se determina la atención educativa integral, que se concreta en los sistemas de apoyo o estrategias de intervención, que se diseñan luego de la identificación de las necesidades educativas especiales. Además se toman decisiones acerca de las modalidades de atención, cómo y dónde iniciará el curso cada escolar objeto de diagnóstico.

En esta fase se conforma el informe diagnóstico y se determina de manera concreta la estrategia educativo-curricular, que luego se valida y rediseña si es necesario en la escuela por los docentes bajo el asesoramiento del CDO. Además se determina dentro del sistema de apoyos, aquellos no académicos, necesarios para lograr una vida adulta independiente y su correspondiente plan funcional, ya sea para una escuela especial o regular. En el último caso deben incluirse acciones dirigidas al asesoramiento del docente y del resto del claustro del plantel ordinario, de modo que se garantice la satisfacción de todas las necesidades educativas del escolar.

La fase 4: Seguimiento al diagnóstico

Su objetivo principal es evaluar la respuesta educativa resultante del proceso mejorar los resultados personales de aprendizaje y desarrollo del escolar; A partir del análisis y/o rediseño de la atención educativa integral que recibe el escolar como respuesta educativa resultante del proceso que requiere, continuo seguimiento y retroalimentación.

Esta última fase permite el seguimiento con el que se garantiza una continua retroalimentación del proceso en el contexto natural del escolar con retraso mental y se materializa su carácter continuo, inacabado y cíclico, ya que de ella se puede pasar a un nuevo ciclo de diagnóstico de acuerdo con las finalidades inmediatas que lo ameriten.

Sistema instrumental

El sistema instrumental puede estructurarse: por especialidades o por fases. A continuación se mostrarán los instrumentos que se recomiendan para cada fase.

Para la primera fase los instrumentos a utilizar son:

- Guías de observación a escolares, sus familias y a los contextos
- Guías de entrevistas al menor, su familia y agentes educativos inmediatos
- Caracterización psicopedagógica
- Pruebas y metódicas
- Guías de Observación y visitas
- Test de inteligencia que miden cociente intelectual (CI)
- Tests y pruebas estandarizadas por especialidades del CDO
- *Registro de evaluación de indicadores de la preparación para la vida cotidiana escolares con retraso mental*. Escala que mide habilidades de la vida diaria
- *BEDMAS*. Escala que mide los modos de actuación social

Para la segunda. fase los instrumentos a utilizar son:

- Instrumentos para la triangulación metodológica de las fuentes

- De análisis y establecimiento de relaciones cualitativas, cuantitativas y de causalidad
- Guía para la discusión diagnóstica

Para la tercera fase los instrumentos a utilizar son:

- Instrumentos para el diseño de estrategias, sistemas y programas de apoyos, para el escolar, sus docentes, familiares u otros agentes educativos

Para la cuarta fase los instrumentos a utilizar son:

- Guías de observación, entrevista o encuestas
- Guías para el análisis de documentos o del producto de la actividad
- Otros instrumentos para evaluar los resultados del proceso

Se han colocado dos instrumentos que se incluyen en el modelo propuesto, que engrosan y enriquecen el sistema instrumental, diseñados para evaluar los aprendizajes conceptuales, sociales y prácticos de la dimensión modos de actuación social. Se recomienda utilizar uno o los dos; ellos son: la “Batería de evaluación del desarrollo de los modos de actuación social: BEDMAS” (adaptación por la autora de la escala EDCHA de Oliva, L. (2004) y “el registro de evaluación de indicadores de la preparación para la vida cotidiana escolares con retraso mental” De la Peña, N. (2005).

Las características generales de estas baterías son las siguientes:

El instrumento “Registro de evaluación de indicadores de la preparación para la vida cotidiana escolares con retraso mental” Registra en cada ítem, la situación del alumno, según el desarrollo de la habilidad que mide el mismo en las siguientes categorías:

1. Acompañamiento:

Si al menos es capaz de ser útil acompañando al adulto y participar como acompañante presto a cooperar.

2. Con niveles de ayuda:

Si realiza la actividad necesitando niveles de ayuda distinguiendo cuándo y cómo en tres aspectos:

- Orientación
- Ejecución
- Transferencia (de la ayuda)

3. Independiente.

Cuando el alumno es capaz de realizar la actividad de forma independiente y posee la habilidad que se está evaluando.

Mide 9 áreas de preparación para la Vida adulta independiente.

ÁREA 1- Comunicación 6 ítems

ÁREA 2- Uso de la comunidad 36 ítems

ÁREA 3- Comportamiento social 20 ítems

ÁREA 4- Educación cívica 13 ítems

ÁREA 5- Vida en el hogar 15 ítems

ÁREA 6- Salud e higiene 13 ítems

ÁREA 7- Tiempo libre 9 ítems

ÁREA 8- Trabajo 15 ítems

ÁREA 9- Aprendizajes académicos 19 ítems

La batería de evaluación del desarrollo de los modos de actuación social: BEDMAS
(La autora realiza la adaptación de la escala EDCHA de Oliva, L. (2004.)

Se trata de una escala para medir las habilidades conceptuales, prácticas y sociales, pero agrupados por áreas. Consiste en un grupo de indicadores o ítems para cada área que serán evaluados en contextos reales o simulados por tres observadores, cuyas calificaciones se promedian en la calificación final, por áreas y global para lo cual se usará la siguiente escala acorde con el nivel de independencia para uno.

- | |
|---|
| 0 – Si no lo hace |
| 1 - Asistencia total. Demostración (cuarto nivel de ayuda) |
| 2 – Necesita alguna asistencia complementaria (segundo y tercer niveles de ayuda) |
| 3 – Motivación (primer nivel de ayuda) |
| 4 - Independiente |

23 ítems área 1- Comunicación	18 ítems área 6- Autodirección
36 ítems área 2- Auto cuidado	19 ítems área 7- Salud y seguridad
29 ítems área 3- Vida en el hogar	35 ítems área 8- Habilidades académicas
26 ítems área 4- Habilidades sociales	17 ítems área 9- Tiempo libre
26 ítems área 5- Uso de la comunidad	19 ítems área 10- Trabajo

Atención educativa integral

La Atención educativa integral es un elemento importante, en tanto se corresponde con la finalidad del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral, se ha colocado en el diagrama representando la meta y a su vez puede marcar el inicio de un nuevo ciclo; sin embargo, vale aclarar que ella se va conformando y aplicando desde la primera fase y en cada una de ellas, lo que revela el carácter interventivo

del diagnóstico psicopedagógico integral, *tal y como lo expresa Akudovich, S²⁷ y col. (2011), cuando plantea*. “el diagnóstico tiene un fin educativo, formativo, es decir, se hace el estudio integral de los niños adolescentes y jóvenes, no para arribar a conclusiones que los identifiquen indefinidamente, que los “etiqueten” o estigmaticen, no para clasificarlos o igualarlos a otros, sino para: elaborar la *estrategia de atención educativa*, enseñarlos, educarlos convenientemente, de manera diferenciada, como ellos demandan, para no excluir, segregar o discriminar, sino para asegurar igualdad de oportunidades y condiciones de éxito para el desarrollo de todos...”

Etapas para la implementación del modelo

Según lo planteado por Reyes, O. L²⁸. (2005) se pueden concretar tres etapas para cumplir con el propósito de implementar un modelo: **preparación, introducción y evaluación**. Para esta tesis se diseñó una guía de implementación, por etapas, que incluye las acciones a desarrollar en cada una (Ver anexo 22)

Para la etapa de *preparación* de la implementación se diseñó un curso dirigido a capacitar los especialistas de los CDO. Conviene aclarar que existe una relación estrecha entre las etapas de investigación y las de implementación del modelo. La etapa de preparación tiene su comienzo en la segunda etapa investigativa que se enmarca en la segunda tarea. Tal es así, que al concluir la sistematización teórica que permitió la determinación de la variable, dimensiones, indicadores y su parametrización, se determinaron las necesidades de los especialistas de los CDO a

²⁷ Akudovich, S²⁷ y col. (2011) El proceso de diagnóstico para la atención educativa. Bases metodológicas para la práctica. Curso 27. Sello editor Educación Cubana.

²⁸ Reyes, O. L²⁸. (2005). Un modelo para el diagnóstico de los trastornos emocionales y de la conducta. Tesis doctoral.

partir del diagnóstico aplicado con este fin a este grupo luego al determinar y desarrollar las actividades de capacitación, a la vez que se trabajó con ellos, se iban rediseñando los componentes del modelo hasta su total confección como cumplimiento de la tercera tarea.

Capacitar:

Según el diccionario Larousse ²⁹, el término se entiende como “acción de efecto de capacitar”

Según el diccionario Océano³⁰, se define como *“formar, preparar, hacer a uno apto para algo, considerándose implícitamente el desarrollo de capacidades para una determinada tarea. En esta misma dirección, el diccionario ilustrado Océano, plantea que “capacitar es hacer a uno apto, habilitable para alguna cosa o facultad o comisionar a una persona para hacer algo”* Para los fines de esta investigación se asume la de Calderón, H. (1995) ³¹ quien define la capacitación como *“la dirigida a los recursos laborales en su desempeño o la preparación para el mismo, con el propósito de habilitarlos para su desempeño particular”*, ya que la finalidad del curso era, justamente, habilitar los especialistas para la implementación del modelo que se propone y su incorporación al modo de actuación de su práctica laboral como coordinadores del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral.

²⁹ Larousse. Diccionario Básico de Lengua Española. Editorial Ultra. México, 1996, pagina 91.

³⁰ Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Edición del Milenio. Diccionario Océano de la Lengua Española.

³¹ Calderón Hugo, (1995): “Manual para la administración del proceso de capacitación de personal. Editorial Limisa, S.A, de CV Grupo Nogueira. Editores Balderás 95, México. D.F. CANIEM, número 21, página 18.

Asimismo se asume la definición de “programa de capacitación” dada por el Dr. C. Deler, G. (1995)³², quien expresa *“conjunto de actividades que intencionalmente dirigidas tienen como propósito el perfeccionamiento del desempeño profesional de los agentes educativos, sobre la base del conjunto de reglas y normas que guían su instrumentación y desarrollo”*

El programa del curso reconoce como forma de organización fundamental: el Taller Para ello se asume la definición de Calzado, D. (2004)³³, quien plantea: *“Es una de forma de organización para la reflexión grupal sobre los problemas profesionales, sus causas, consecuencias y alternativas de soluciones en correspondencia con los contextos en que se manifiestan. En él...se aprovechan las potencialidades del grupo para proyectar soluciones profesionales y/o científicas a los problemas presentados...”*

Finalmente, las etapas segunda y tercera de la implementación: *introducción y evaluación*, sirvieron con un alto nivel de confiabilidad para la demostración de la factibilidad del modelo propuesto, previsto en la cuarta tarea científica, ya que permitieron su abordaje con vistas a evaluarlo.

ESQUEMATIZACIÓN DEL MODELO

El proceso objeto de investigación de esta tesis, es altamente complejo, como lo ha sido su modelación; sin embargo se representa mediante dos gráficos:

³² Deler Ferrera G. “La propuesta de programas de capacitación y/o superación, las alternativas y los talleres como resultados científicos en la investigación pedagógica. 2007

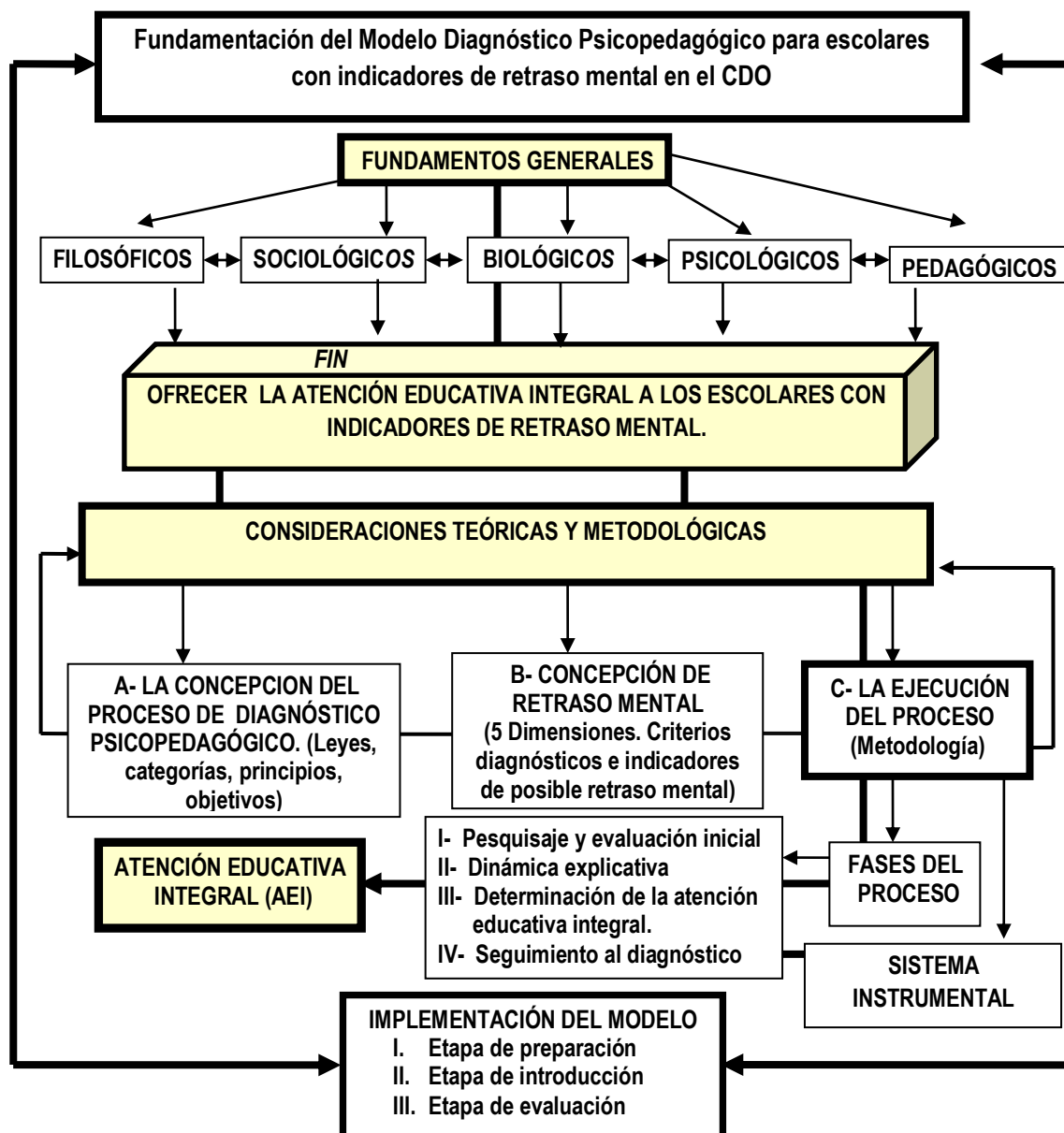
³³ Calzado L, D. (2004): “Un modelo de formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial del profesor”. Tesis Doctoral, ISPEJV, La Habana, página anexo 1

Un diagrama general o global que lo fundamenta y un esquema gráfico que representa el modelo sus componentes y relaciones.

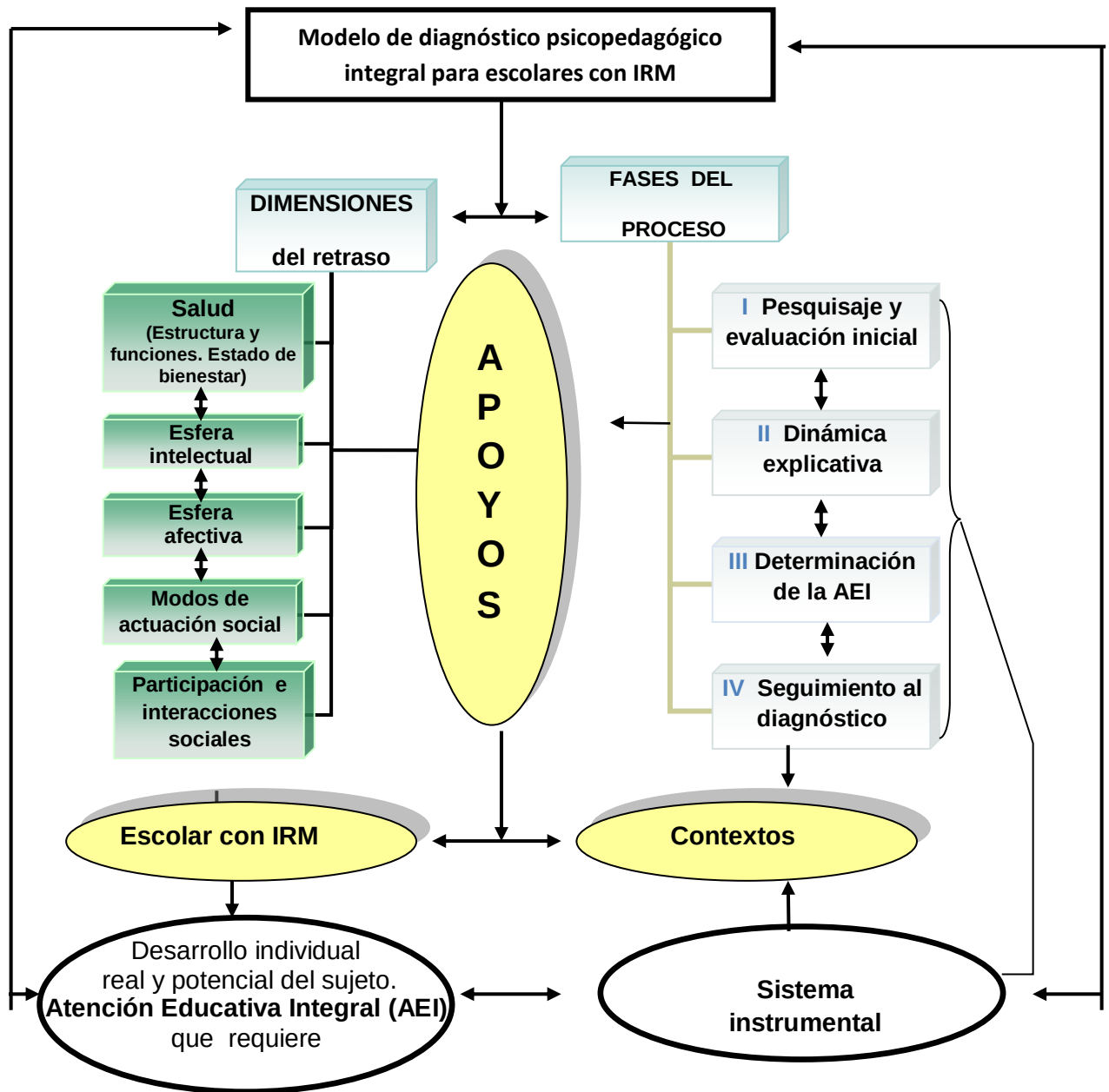
En el diagrama se ha representado los elementos importantes relacionados con la fundamentación del modelo para el diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental en el CDO. Obviamente los fundamentos generales son congruentes con el proceso, aun cuando no se esté circunscribiendo al grupo de escolares enmarcados; sin embargo la argumentación de los fundamentos se ha realizado teniendo en cuenta las particularidades del grupo con indicadores de retraso mental.

Además, en el diagrama se acentúa la relación entre los elementos teóricos y metodológicos con las consideraciones necesarias que acotan los rasgos distintivos que se reflejan en el modelo y que llevan en un flujo lineal, pero inacabado y cíclico a la determinación de la atención educativa integral que requieren los escolares objeto de diagnóstico. Es la atención educativa integral (AEI) fin y comienzo del proceso que será retomado, rediseñado y modificado tanto, como demanden las necesidades educativas del escolar o de los contextos.

DIAGRAMA:



ESQUEMA DEL MODELO PROPUESTO



COMPONENTES Y RELACIONES ESPECÍFICAS EN EL MODELO

En el *esquema* se intenta graficar el modelo de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental, que introduce cambios con respecto al modelo actuante, pues pone énfasis en la relación entre el modelo teórico multidimensional del retraso mental y las propias fases del proceso, entre las que median los apoyos.

Así puede verse que los componentes del modelo son *el escolar con indicadores de retraso mental*, relacionado con *las fases de ejecución del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral* en la que median *los apoyos* y se aplica *el sistema instrumental* previsto para cada fase en la que se valoran *las cinco dimensiones del modelo teórico del retraso mental* desde su enfoque multidimensional, relación que está influenciada además por los diferentes contextos. Todo ello para poder caracterizar *el desarrollo individual y la atención educativa integral que requiere* al tener en cuenta la influencia de los contextos.

La ejecución enmarcada en las fases que conforman el proceso y el sistema instrumental a emplear, tienen una relación entre sí de consecutividad y de coordinación son necesarias para definir, conformar, implementar y fundamentar el desarrollo real, potencial y la *atención educativa integral* que demanda cada escolar diagnosticado, no tiene carácter concluyente, sino dinámico y se continúa evaluando y modificando.

CUALIDADES DEL MODELO

Revela una concepción optimista porque ofrece a los especialistas herramientas y argumentos científicos para dirigir el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral para escolares con indicadores de retraso mental; que permite no sólo la obtención del estado actual, sino también la determinación de potencialidades, además rompe con el mito del techo o límite atribuido por décadas a este grupo. Por el contrario, realza la repercusión en su desarrollo, de las exigencias de la sociedad en la cual viven.

Es participativo porque en él se ofrecen espacios para que la familia y agentes educativos se impliquen, no como portadores de información, sino como coparticipantes de las indagaciones o de las estrategias o apoyos diseñadas e implementadas dentro del proceso con fines diagnósticos.

Es transformador, porque tiene como fin potenciar la formación y el desarrollo de los escolares objeto de estudio, quienes mediante la atención educativa integral, resultante del proceso, reciben los apoyos necesarios para su educación.

El modelo que se propone revela la relación entre todos sus componentes, unas de subordinación, otras de coordinación, pero al comprenderlas, se percibe mejor la lógica interna de un proceso tan complejo como el diagnóstico psicopedagógico integral, que se da en escenarios diversos y con numerosos participantes, pero que tiene bien definido como fin la conformación de la atención educativa integral para cada escolar. También explica la relación de los elementos teóricos y prácticos que se ven interrelacionados, como la que se establece entre el modelo del retraso

mental y las fases del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral (metodológico-práctico)

Finalmente, el modelo es comprensible y asequible para quienes serán sus usuarios, los especialistas de los Centros de Diagnóstico y Orientación, al mismo tiempo garantiza la capacitación para su uso, mediante el curso y manual que se proponen dirigidos a los especialistas de los CDO.

3.2 Análisis de los resultados obtenidos en la sistematización de experiencias en la práctica del modelo de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental

Para realizar la búsqueda de factibilidad del modelo propuesto se determinó emplear la consulta a especialistas y se concibió dentro del modelo etapas para su implementación.

La consulta a expertos. Se realizó de especialistas, con presumible experticidad, todos con más de 5 años de experiencia relacionada con el trabajo de los CDO; con vistas a someter a su consideración el modelo que se propone. Los resultados fueron analizados mediante el método Delphi para encontrar las categorías tipificadas para cada criterio; asimismo fueron tenidas en cuenta las sugerencias que coadyuvaron al enriquecimiento del modelo desde su versión inicial hasta la actual.

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del Delphi mostraron que todos los criterios fueron considerados como: Muy Adecuado. (Anexo 21)

Implementación en la práctica del modelo propuesto.

Desde su propia confección se establecieron 3 etapas para su implementación con vistas a la autoevaluación del mismo y por tanto, se consideraron los resultados obtenidos en cada una, elementos de importancia para valorar la factibilidad del mismo. Se realizó una sistematización de experiencias en la práctica que incluyó la aplicación del modelo en el municipio Artemisa de la provincia de igual nombre.

Sistematización de experiencias

Posibilitó la obtención de valoraciones empíricas de la factibilidad del modelo de diagnóstico psicopedagógico integral propuesto a partir de la interpretación de los resultados de las etapas de implementación previstas en el propio modelo, para lo que se elaboró y desarrolló una guía que contenía las acciones a realizar en cada una de ellas.(Anexo 22)

RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN.

ETAPA DE PREPARACIÓN

Respecto al curso de capacitación dirigido a los especialistas de los CDO, aunque no se aplicaron métodos cuantificables, gracias a la forma de evaluación sistemática y de cierre previstas, se valora como muy significativo el resultado obtenido en los cursistas; no solo en los elementos capacitados, sino también en cuanto al orden personal y humano, valoradas por ellos como positivo, por considerar la experiencia del curso como reconfortante, enriquecedora, de crecimiento y con deseos incontenibles de aplicación.

El diseño y uso del manual dirigido a los especialistas complementó los resultados del curso, que los propios especialistas del CDO durante los talleres de opinión crítica resaltaron como positivo.

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Aquí se diseñó y aplicó una *constatación práctica* con los especialistas del municipio Artemisa

Para la fase de diagnóstico se consideraron válidos los resultados obtenidos a la hora de caracterizar el modelo actuante durante el cumplimiento de la tarea 2 al que se sumaron talleres de opinión crítica. En la fase de implementación se diseñó e implementó una sistematización de experiencias en la práctica, mediante su introducción en el municipio Artemisa. Como constatación de modificaciones en los indicadores de las dimensiones estudiadas se repitieron algunos instrumentos de la etapa exploratoria, como el estudio de documentos y la guía de observación. El análisis de expedientes, el intercambio con los especialistas, así como las numerosas observaciones permitieron constatar algunos cambios en los indicadores de la investigación, definidos para cada dimensión de la variable.

ETAPA DE EVALUACIÓN

Para esta investigación se hizo coincidir la tercera etapa de implementación implícita en el modelo, con la última investigativa en la búsqueda de criterios de factibilidad del modelo. Se presentan a continuación de manera sintetizada, los resultados obtenidos en la aplicación de cada instrumento seleccionado para ello.

Análisis de los documentos

En el momento de cierre, la revisión de documentos aportó información alentadora que se resume en los siguientes elementos:

- Comienzan a emplearse técnicas y tareas con el propósito de valorar con mayor profundidad las dimensiones *social* y *psicológica* (esta última, respecto al área emocional, vivencial y actitudinal).
- Existen diferencias importantes en la expresión de desarrollo de los modos de actuación social y la participación y los roles sociales, entre el grupo de escolares a quienes se les confirma el retraso mental y aquellos que se descartan.
- La aplicación de la prueba BEDMAS para medir modos de actuación social permitió no solo obtener información respecto a esta dimensión del retraso mental, sino que enriquece la información de la dimensión participación y roles sociales. Asimismo, su aplicación permitió materializar la verdadera implicación al proceso de diagnóstico psicopedagógico integral, de la familia y de aquellos agentes comunitarios que se estimen pertinentes, ya que el instrumento toma a la familia como uno de los examinadores.

Observaciones: Se realizaron 40 observaciones, al igual que en la fase de exploración del estado inicial. Las regularidades encontradas hablan a favor de modificaciones cualitativamente superiores en los indicadores.

Por indicadores:

Funcionamiento general

Respecto al estado global de la actividad cognoscitiva y el estado emocional volitivo en los escolares objeto de estudio se recogen elementos comportamentales como los niveles de colaboración y estado emocional aparente.

Desarrollo cognoscitivo

Poseen habilidades intelectuales que por su estructura interna no están logradas pero tienen un desarrollo potencial, así como las habilidades comunicativas antes no indagadas.

Demanda y solicitud de la ayuda

Los escolares requieren la administración de niveles de ayuda y muestran dificultades para la transferencia de la ayuda.

Desarrollo socio-afectivo

Los elementos socio-afectivos como: la reacción ante la crítica, las normas y límites, se revelan con características que se alejan de los niveles de expresión de la media, a veces llegan a ser desajustados, eso acarrea un desarrollo en este plano un poco lento y demandante de apoyo y mediación externa..

Respecto al desarrollo actitudinal

Mediante técnicas sencillas de autovaloración y valoración, así como preguntas intencionalmente dirigidas a ellos en la entrevista, *se pudieron recoger datos que hablan a favor dificultades en el desarrollo de actitudes.*

En el resto de los indicadores, pertenecientes a la subdimensión social, no se pueden establecer comparaciones, pues antes de la implementación no se abordaban.

Luego de eso, se recogieron datos que se sintetizan a continuación:

Respecto al Desarrollo social y de la comunicación social

En estos indicadores a través de la observación y de entrevistas realizadas al propio escolar, así como mediante la utilización de la prueba BEDMAS se obtuvo información rigurosa y concluyente. Aquí resultó significativa la diferencia entre aquellos escolares a quienes se les confirmó el retraso mental y los que quedaron descartados. En este último grupo no se encontraron elementos significativos, mientras que en el primero se revelaron dificultades en los aprendizajes sociales, luego confirmadas por los familiares mediante la entrevista intencionada.

TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA:

Para la investigación que se realiza, se consideró oportuno utilizar la triangulación como el método que posibilita contrastar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de diferentes fuentes, importante para demostrar la factibilidad del modelo elaborado que se introdujo parcialmente en la práctica.

El análisis de los diferentes instrumentos permitió establecer relaciones de coincidencia en las manifestaciones que se encontraron para cada indicador y respecto a las subdimensiones de ambas dimensiones, lo que demuestra que los instrumentos revelan un acercamiento real al estado en que se encontraban cada uno de ellos, luego de la introducción en la práctica del modelo.

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN II

La valoración de la dimensión II se realizó mediante la observación directa, talleres de opinión crítica y reflexión, conjuntamente con el método de encuestas grupales, aplicados luego de la constatación práctica. Además se aplicaron nuevamente

cuestionarios y escalas para medir actitudes a los especialistas del grupo experimental. (Anexo 19)

- Resultados del taller de opinión crítica y colectiva para la validación del modelo.

El taller se realizó con 10 especialistas: 6 del municipio y 4 del equipo asesor provincial, 10 docentes, 2 directoras, 1 subdirectora, 4 jefas de ciclo y maestras de 1er y 2do. grados, con el objetivo de evaluar el modelo y el nivel de satisfacción de sus participantes mediante el debate reflexivo. (Anexo 16)

MOMENTOS DEL TALLER		
INTRODUCCIÓN	DESARROLLO	CONCLUSIONES
1. Exposición por el investigador de los objetivos del taller y un resumen de la implementación realizada.	2. Invitación al debate, conducido por el investigador, fomentando el intercambio para el análisis y valoración de lo realizado y presentación de los criterios valorativos. 3. Debate. 4. Resumen de los elementos expuestos por los participantes.	5. Aspectos que tendrá en cuenta para la continuidad del modelo y diseño de acciones. 6. Agradecimientos por la colaboración recibida.

Las opiniones vertidas por el 100% de los especialistas entrevistados al finalizar la puesta en práctica del modelo, expresan un alto nivel de satisfacción con el modelo y el sistema de acciones de la guía para su implementación. En este sentido, se enfatiza en la existencia de cambios observables en las tres dimensiones que se establecen para el análisis individual de los escolares, así como la repercusión

adecuada en la orientación y preparación de los especialistas del CDO, apreciado en el mejoramiento de los indicadores de las tres subdimensiones de esta dimensión, en su interés por superar los problemas del diagnóstico y en la posibilidad que ven con la implementación del modelo de disminuir el rango de error en aquellos casos difíciles de realizar el diagnóstico diferencial entre el retraso mental y entidades afines.

Resultados de las observaciones *Por indicadores:*

Funcionamiento general

Los especialistas observados al finalizar la sesión en su análisis acerca de los datos obtenidos, encuentran relaciones con el estado global de la actividad cognoscitiva y el estado emocional volitivo en los escolares objeto de estudio. Este último centrado en los elementos comportamentales como los niveles de colaboración y estado emocional aparente.

Desarrollo cognoscitivo

Aunque en este indicador se obtuvieron mejores resultados con respecto a los otros, en el momento de cierre se comenzó a indagar en aquellas habilidades que por su estructura interna no están logradas, pero que tienen un desarrollo potencial, en las habilidades comunicativas antes no indagadas.

Demanda y solicitud de la ayuda

Comienzan a emplearse los criterios evaluativos para evaluar la zona de desarrollo próximo que ya estaban en el modelo actuante pero para los cuales los especialistas no estaban totalmente preparados; aunque aún se observaron dificultades para el análisis del estado de la transferencia de la ayuda.

Desarrollo socio-afectivo

Se comienzan a utilizar técnicas y tareas con el objetivo de evaluar en los escolares elementos socio-afectivos como la reacción ante la crítica, las normas y límites, antes pasados por alto, al aprovechar las observaciones que le hacen en los contextos naturales.

Respecto al desarrollo actitudinal

Se comienzan a dar avances con el empleo por los especialistas durante el proceso, de técnicas sencillas de autovaloración y valoración, así como preguntas intencionalmente dirigidas a ellos en la entrevista. En el resto de los indicadores, pertenecientes a la subdimensión social, no se pueden establecer comparaciones, pues antes de la implementación no se abordaban. Luego, se recogieron datos que se sintetizan a continuación.

Respecto al desarrollo social y de la comunicación social

En estos indicadores a través de la observación realizada al propio escolar, se obtuvo información rigurosa y concluyente. Aquí resultó significativa la diferencia entre aquellos escolares a quienes se les confirmó el retraso mental y los que quedaron descartados. En este último grupo no se encontraron elementos significativos, mientras que en el primero se revelaron dificultades en los aprendizajes sociales, luego confirmadas por los familiares mediante la entrevista intencionada.

Las transformaciones reveladas luego de la introducción del modelo en la práctica, pueden enmarcarse para cada dimensión de la siguiente manera:

Sobre **DIMENSIÓN I:** *la evaluación de los escolares con indicadores de retraso mental.*

Subdimensión biológica

- Se constata que existe una lesión estática del sistema nervioso, que no siempre está comprobada *imagenológicamente* desde la clínica, pero que sí puede inferirse al relacionar los datos de la historia personal en la anamnesis, donde se relatan eventos o situaciones que pudieran ser la causa de la misma.

Subdimensión psicológica:

- En el grupo de escolares con indicadores de retraso mental objeto de estudio, se encontraron datos característicos en los indicadores de desarrollo socio-afectivo y actitudinal. En el primero se revelan dificultades en las relaciones interpersonales y en el acatamiento de normas y límites; en el segundo, actitudes inapropiadas ante sí mismos, ante el estudio y ante algunos contextos; todas ellas de rechazo o indiferencia.

Subdimensión social:

- Existen diferencias significativas entre aquellos escolares a quienes se le confirmó el retraso con respecto al grupo a quienes se les descartó, todo lo cual se obtuvo mediante el uso del instrumento para medir modos de actuación social: BEDMAS y de métodos como la observación, el estudio de documentos y aplicación de pruebas a los escolares objetos de estudio diagnóstico.

Sobre **DIMENSIÓN II**: los especialistas del CDO.

Subdimensión cognitiva:

- Hay consenso en continuar utilizando el término retraso mental aunque reconocen la necesidad de un cambio. Los especialistas logran un diagnóstico explicativo y una mayor concreción en la determinación de necesidades y

elección de los apoyos, consideran irrelevante explicitar en los informes los niveles de profundidad.

- El criterio de diagnóstico preponderante ya no es el de desarrollo cognitivo y su manifestación académica concreta, sino un análisis holístico y multidimensional que imbrica los tres niveles de desarrollo y el análisis de la influencia de los factores contextuales.

Subdimensión ejecutiva:

- Los especialistas han ampliado los instrumentos a utilizar, incorporando el BEDMAS, así como también manifiestan mayores habilidades en la elaboración de la estrategia diagnóstica y el trabajo multidisciplinario.
- Se utilizan tareas evaluativas o elaboran acciones interventivas dirigidas a elementos funcionales, no solo a académicos.
- Durante el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral aparecen acciones de asesoramiento a docentes con vistas a garantizar el éxito en la atención educativa integral como parte del propio proceso, lo que revela el cumplimiento del par proceso-resultado.

Subdimensión afectivo-motivacional:

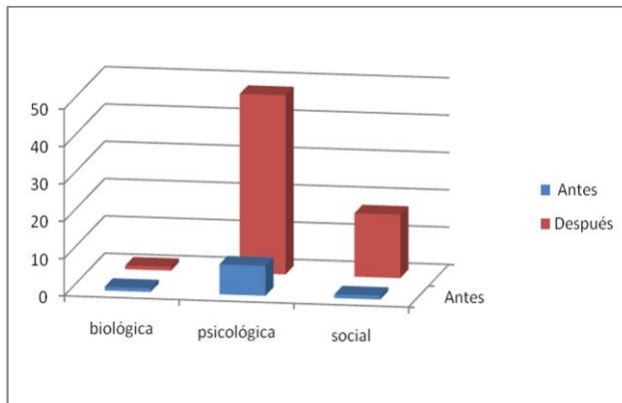
- Los especialistas participantes reconocen abiertamente que la teoría del “techo” respecto a individuos con retraso mental, en ellos se ha desmoronado.
- Admiten que siempre que se estimule o provea los medios y situaciones que generen desarrollo y estén acordes con las posibilidades reales y potenciales el individuo mejorará.

- Reconocen la importancia de que en el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral se deriven objetivos y acciones de carácter funcionales y no solo académicas.
- Las actitudes ante la discapacidad y ante el retraso mental se han reajustado, pueden considerarse adecuadas en la mayoría de los aspectos son positivas disminuyendo sustancialmente las negativas o indiferentes.

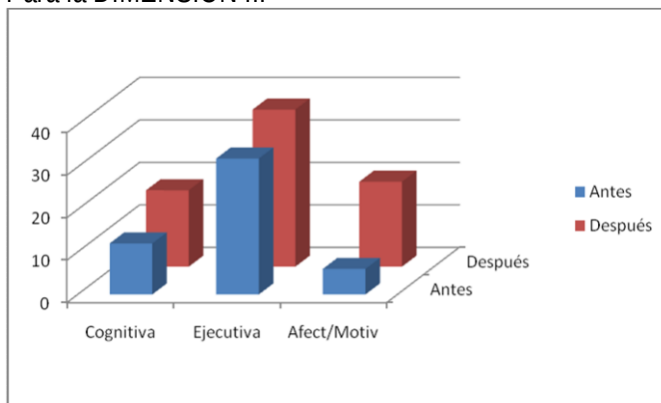
Para realizar un análisis estadístico que permitiera la comparación cuantitativa de los resultados expuestos anteriormente se cuantificó la categoría otorgada a los indicadores de la siguiente manera: al alto se le otorga 2 puntos; al medio, 1 punto y al bajo no se le otorga puntuación. De esta manera, la muestra puede ser comparada mediante la evolución o no de la media aritmética. En este sentido, las tablas comparativas por media y sus correspondientes gráficos muestran una favorable evolución en la mayoría de los indicadores. (Anexo 23)

La comparación anterior permite utilizar diferentes gráficos para clarificar la evolución por dimensiones, en aras de sintetizar las comparaciones, podría mostrarse:

Para la DIMENSIÓN I:



Para la DIMENSIÓN II:



Conclusiones del capítulo

1. Existen elementos que hablan a favor de manifestaciones cualitativamente superiores en las dos dimensiones, cada una de las cuales revela a su vez, saltos significativos y relativamente superiores en las tres subdimensiones de cada una.
2. Estadísticamente se demostró que ocurrieron transformaciones cualitativamente superiores en los indicadores medidos al compararlos antes y después de la implementación del modelo en la práctica, lo que demuestra la factibilidad de la propuesta.

CONCLUSIONES

- El estudio histórico lógico realizado posibilitó la sistematización de los referentes teóricos relacionados con el diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental, lo que permitió fundamentar este proceso desde el enfoque socio-histórico-cultural y revelar las carencias que existían respecto a elementos teóricos, lo que implicó enriquecerlos con algunos principios y la operacionalización del constructo diagnóstico *psicopedagógico integral*.
- La parametrización de la variable permitió el análisis de los resultados del estudio teórico, la exploración y valoración de los criterios emitidos por los docentes y especialistas, el estado de los documentos que caracterizan el diagnóstico psicopedagógico integral y las observaciones directas al propio proceso. Todo lo que coadyuvó a la identificación de las fortalezas y debilidades que se revelan en cada subdimensión y sus regularidades.
- La modelación científica permitió la determinación y relación de los componentes del modelo que se propone, donde se destaca la interrelación entre la multidimensionalidad del retraso mental y su expresión en las fases de ejecución del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral, con las cuales se pretende alcanzar una adecuada atención educativa integral. El modelo propuesto aporta elementos teóricos, metodológicos e instrumentales con los que se supera al actuante.
- Los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental, luego de la sistematización en la práctica del modelo propuesto, demostraron su factibilidad constatada cualitativa y cuantitativamente mediante los métodos seleccionados para ello.

RECOMENDACIONES

1. Continuar el estudio del diagnóstico psicopedagógico integral que dirigen los Centros de Diagnóstico y Orientación, en su aspecto general o delimitando elementos importantes del retraso mental u otra entidad diagnóstica.
2. Estudiar las posibilidades de generalización en otros municipios.
3. Divulgar los resultados de la tesis con vistas a su uso por los especialistas del CDO.

BIBLIOGRAFÍA

1. AAMR. (2004) Retraso mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Décima edición. Psicología Alianza Editorial.
2. ADDINE FERNÁNDEZ, F., GONZÁLEZ, A. M., RE CAREY, S. (2002) Principios para la dirección del proceso pedagógico. En Compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana, Pág. 84.
3. ABREU, E. (1990). Diagnóstico de las investigaciones del desarrollo psíquico. Editorial Pueblo y educación. La Habana.
4. AINSCOW, M. (2004) Salamanca 10 años después: ¿qué impacto ha tenido en el ámbito internacional? Universidad de Manchester.
5. _____. (1995). Necesidades Especiales el aula. Guía para la formación del profesorado Editorial. Narcea. Madrid. 113p.
6. AKUDOVICH, S. (2004). Fundamentos del proceso de diagnóstico de la Zona de Desarrollo Próximo de los alumnos con retraso mental leve en el contexto del diagnóstico escolar. Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias Pedagógicas .Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Universidad Hermanos Saíz.
7. ----- (1998). Zona de desarrollo próximo como vía para el diagnóstico del retraso mental. Ponencia presentada en el II Congreso Iberoamericano de Educación especial. Ciudad de la Habana.
8. _____. y otros. (2006) Zona de desarrollo próximo y su proceso de diagnóstico. Libro. Registro 1206-2005(MINED).Editorial Academia, La Habana.

9. _____ y col. (2011) El proceso de diagnóstico para la atención educativa. bases metodológicas para la práctica curso 27. Pedagogía'11. Sello editor Educación cubana
10. ÁLVAREZ, C.C. (1996). Evaluación y diagnóstico. Materiales de la asignatura de diagnóstico y evaluación. Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial. La Habana.
11. _____. (1998). Diagnóstico y Zona de Desarrollo Próximo. Alternativa en la validación de una metodología del cuarto excluido. Tesis presentada en opción al título científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana.
12. _____. (1999). El impacto de la Teoría de Vigotsky en la Educación Especial en Cuba. Pinar del Río: Material mimeografiado.
13. _____(2003). Diagnóstico y diversidad. Curso impartido en el Congreso Educación y diversidad. Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial. La Habana.
14. APA (1995) *DSM- IV. Manual de diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales*. Ed. Masson. Barcelona.
15. ARIAS; G. (1999). Educación, desarrollo, evaluación y diagnóstico desde el enfoque histórico- cultural. Facultad de Psicología, Universidad de la Habana. Soporte electrónico.
16. _____ (1999) El diagnóstico psicológico en la Educación. Folleto del Postgrado titulado El diagnóstico en la caracterización de los escolares. Facultad Psicología. UH.
17. _____. (2001) Evaluación y diagnóstico en la Educación y el desarrollo desde un enfoque Histórico- Cultural. Editorial Sao Paulo.

18. ARNAIZ P. Z. Integración, segregación, inclusión. Ponencia presentada en la XXII Reunión Científica de AEDES "10 años de integración en España: análisis de la realidad y perspectiva de futuro. Murcia.1995-10p
19. AZCOAGA, J. E.; Derman, B. e Iglesias, P.A. (1995) *Alteraciones del aprendizaje escolar. Diagnóstico, fisiopatología, tratamiento*. Ed. Paidós Ibérica, S. A. Barcelona.
20. BELL, R (1997). Educación especial. Razones visión actual y desafíos. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.
21. _____ (1996) Educación especial. Sublime profesión de amor. Editorial Pueblo y Educación.
22. _____(1996) Binomios de la educación especial. Impresión ligera. Centro de Referencia Latinoamericano de la Educación Especial. La Habana.
23. _____. (2003).Inclusión y escuela: expectativas y realidades. Conferencia. Material mimeografiado. MINED. Ciudad de la Habana.
24. _____. (2001) Pedagogía y diversidad Editorial Abril. La Habana.
25. _____ (2001) Convocados por la diversidad. Editorial Pueblo y educación. La Habana.
26. BLANCO P. A. (2004) "Introducción a la sociología de la educación" ED. Pueblo y educación Cuba.
27. BOZHOVICH, L. I. (1981) La personalidad y su formación en la edad infantil. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana.
28. BRITO F. H. Y col. (1987) "Psicología General para los Institutos Superiores Pedagógicos" Editorial Pueblo y Educación. La Habana
29. CALDERÓN H, (1995): "Manual para la administración del proceso de capacitación de personal. Editorial Limisa, S.A, de CV Grupo Nogueira. Editores Balderás 95, México. D.F. CANIEM, número 21, página 18.

30. CALZADO LAHERA D. (2004): "Un modelo de formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial del profesor" Tesis Doctoral, ISPEJV, La Habana.
31. CASTANEDO C., 2da Edición oct/98. *Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. Evaluación e intervención*. Ed. CCS. Madrid
32. CASTILLO, T Y VALCÁRCEL, N. (2005) "Las condicionantes en la superación de docentes." Revista Mendive. No. 14. Pinar del Río. Pág. 13.
33. CASTRO-LÓPEZ G. H. (1984) Clínica del retraso mental. La Habana: Editorial Pueblo y Educación;. p.2-9.
34. CASTRO A. P. L. (1996) Cómo cumple la Familia su función Educativa. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Pág. 21.
35. CEREZAL, J. et al. (2001). Los métodos teóricos en la investigación pedagógica. En Revista "Desafío escolar" Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana
36. COLECTIVO DE AUTORES. (2004) V seminario nacional para educadores.
37. _____(2003) El trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación. "Consideraciones básicas de actualidad" Ed. Pueblo y educación.
38. _____(2002). Compendio de Pedagogía. Editorial pueblo y Educación. La Habana.
39. _____. (1995) "Trabajo metodológico de los centros de diagnóstico y orientación". MINED.

40. _____(1994). “Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales” declaración de salamanca. ED. Cuaderno de integración educativa. España.
41. _____. (1992). Los alumnos con necesidades educativas especiales. M.E.C. España.
42. _____. (1975). Selección de lecturas de Materialismo Dialéctico. Materiales de estudio para alumnos. Unidad Tipográfica Neptuno.
43. CHÁVEZ J. (2003) Conferencias de Filosofía de la Educación. Doctorado curricular .ICCP.
44. _____ (2002). Filosofía de la educación. Fotocopia de material Mimeografiado Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana
45. DE LA PEÑA N. (2005) Una concepción para el logro de una vida adulta independiente en los escolares con retraso mental. Tesis doctoral. La Habana.
46. DELER F.G. (2007) “La propuesta de programas de capacitación y/o superación, las alternativas y los talleres como resultados científicos en la investigación pedagógica.
47. DOMÍNGUEZ, L. (1990) Cuestiones psicológicas del desarrollo de la personalidad Universidad de La Habana. Facultal de Psicología. La Habana.
48. ECHEITA G. (2004) La Declaración de Salamanca sobre necesidades educativas especiales 10 años después. Valoración y Prospectiva. INICO. Salamanca. España

49. ENCICLOPEDIA General de Educación. Tomo I y II. Editorial Océano. Barcelona. 1999; 841-948p
50. FARIÑAS, G. (2001) La Psicología Educativa en el ámbito escolar. Presente y futuro. Conferencia dictada en Posgrado de la Facultad de Psicología. UH.
51. FERNÁNDEZ D. C. A. "La interrelación de la escuela y la comunidad en la práctica educativa como expresión de relaciones individuo-sociedad. Folleto en formato digital.
52. GAYLE, A. (2005) Una concepción pedagógica para el tránsito de los alumnos con retardo en el desarrollo psíquico a la educación básica en determinadas condiciones educativas. Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ICCP.
53. _____. et al. (2001) El estilo de aprendizaje, un espacio para el ajuste de la respuesta pedagógica, la modificación y el crecimiento personal. Material mimeografiado taller para la validación de las líneas de desarrollo. La Habana.
54. _____ (1995). De la teoría a la práctica del trabajo correctivo – compensatorio con los escolares con deficiencias intelectuales. Material mimeografiado. Ministerio de Educación. La Habana.
55. _____ (2002). Relatoría de los talleres de validación en la especialidad de retraso mental. Ministerio de Educación. La Habana.
56. GINÉ G, Climent. (1998). La evaluación psicopedagógica: un modelo interactivo y centrado en el curriculum. Conferencia impartida en la VII Conferencia Científica Latinoamericana de Educación Especial. La Habana.

57. Gómez Gutiérrez, Luis I. (2001) El desarrollo de la educación en Cuba. Conferencia Especial Pedagogía. La Habana.
58. _____. (1999) La educación en Cuba. Conferencia Pedagogía 99. La Habana
59. _____. (1998) La atención en Cuba a las necesidades educativas especiales y a niños en edad preescolar. Conferencia. VII Conferencia Científica Latinoamericana de Educación Especial. La Habana.
60. _____. (1997). La Educación en Cuba y la atención a los niños con Necesidades Educativas Especiales. Conferencia especial II Congreso Ibero americano de Educación Especial. La Habana.
61. GONZÁLEZ L. M. (1998) "Metodología para el diagnóstico: una herramienta de apoyatura para la dirección del proceso pedagógico" En Con Luz Propia. no. 2 p.41 43. La Habana ene.abr.
62. GONZÁLEZ P. S. y otros "Consideración psicoterapéutica en la educación de personas discapacitadas". Folleto en formato digital Bélgica 1999.
63. GONZÁLEZ, R. F. (1985).Psicología de la personalidad. Ed. Pueblo y Educación.
64. GONZÁLEZ S. A. (2002) Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía. La Habana: Ed. Pueblo y Educación. p.75,
65. GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (GESOCYT, 1994.). Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología. La Habana: Editorial Félix Varela.

66. GUERRA I. S. y otros (2005) "Educación de alumnos con diagnóstico de retraso mental". .Edit. Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana ,
67. _____. (2005) Una concepción didáctica para potenciar un proceso de enseñanza –aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba en escolares con retraso mental. Tesis en opción al título de Doctora en Ciencias Pedagógicas. ICCP.
68. _____ y otros (2005) "Selección de lecturas sobre retraso mental" Folleto en formato digital Cuba.
69. _____. (2005) Retraso mental. Reflexiones necesarias para brindar una atención educativa integral a los escolares con retraso mental. Artículo Digital. Proyecto: Atención Educativa Integral a escolares con retraso mental.
70. GUIRADO. V. (2004).Modelo didáctico para la enseñanza – aprendizaje de la matemática en escolares con retardo mental. Tesis presentada en opción al título de Doctora en Ciencias Pedagógicas. Universidad Central de las Villas.
71. HERNÁNDEZ S. A (2004).. "Metodología de la investigación" en formato digital.
72. ILLÁN, N. (1992). Pasado-presente y futuro. Editorial Yerba. Murcia.
73. KONSTANTINOV F. (1998) Fundamentos de Filosofía Marxista-Leninista, parte 1. La Habana: Editorial Pueblo y Educación;
74. LAROUSSE. (1996) Diccionario Básico de Lengua Española. Editorial Ultra. México,
75. LEYVA M. (2005) El diagnóstico del retraso mental. En formato digital.
76. _____(2004) "Conceptualización Evolutiva del retraso mental". En formato digital.

77. _____. (2004) "Evaluación Vs Diagnóstico. En formato digital.
78. _____. (2004) "La conducta adaptativa". En formato digital.
79. LÓPEZ M.J.. (2000) La evaluación psicopedagógica. España
www.psicopedagogia.com (libro en Internet.)
80. LÓPEZ J y SIVERIO A. (1996) "El Diagnóstico: un instrumento de trabajo pedagógico, De Pueblo y Educación. La Habana,
81. LÓPEZ R. (2000). Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Fundamentos y actualidad. Editorial Pueblo y Educación. La Habana
82. _____(2000) "Educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Fundamentos y actualidad" Compendio de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico, Editorial Pueblo y Educación , Ciudad de la Habana,.
83. MARX C, ENGELS F. (1965.) La sagrada familia. La Habana: Editora política;
84. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1981). Documentos normativos para el perfeccionamiento del subsistema de Educación Especial. La Habana.
85. MOLINA S. (1995) *Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial*. Ed. Marfil, S.A. Alcoy España.
86. MORALES, L. et al (1992)) Selección de lecturas sobre Pedagogía Especial. Editorial Pueblo y Educación.
87. MORENO L.L (1987) Tesis "Un proyecto de acción de educación avanzada para la preparación de las familias en la educación de la sexualidad. C. Habana

88. NIEVES R. M.L. "Aproximaciones a los conceptos de necesidades educativas especiales". En Desafío escolar. no.7. p. 9-15, México ene.-feb. 1999.
89. _____. "El diagnostico como forma de evaluación educativa"
En soporte digital.
90. OLIVA V. L. (2004) Un estudio de la conducta adaptativa en escolares con retraso mental. Tesis en opción al grado académico Máster en Psicología Educativa. Facultad de Psicología. UH.
91. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (2001) *.Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud «CIF»*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría General de Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO);
92. OROSCO, M. (2003) Deficiencia mental: Retraso mental. Material mimeografiado. Asignatura retraso mental. Ciudad de la Habana: CELAEE.
93. PÁEZ S. V. (1998) "Contextualizar e individualizar el proceso de enseñanza aprendizaje, desde lo social y grupal en la escuela media: una propuesta teórica-metodológica". Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". Tesis de Maestría. La Habana.
94. PORTUONDO S. M. (2004) Evolución del concepto social de discapacidad intelectual. Revista cubana Salud Pública. V. 30 n.
95. REYES, O. L. (2005).Un modelo para el diagnóstico de los trastornos emocionales y de la conducta. Tesis doctoral.

96. RICO P. (2004). Algunas exigencias para el desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Save the Children Projects.
97. _____(2003). La Zona de Desarrollo Próximo. Procedimiento y tareas de aprendizaje. Editorial. Pueblo y Educación. . La Habana
98. _____ et al. (2000) Hacia el perfeccionamiento de la escuela primaria. Editorial Pueblo y educación.
99. _____(2000) Selección de temas psicopedagógicos. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
100. RIVERO M (2004) Caracterización ontogenética de los escolares con diagnóstico de retraso mental. Material mimeografiado. Instituto Superior Pedagógico Camagüey.
101. _____(2001) Influencia de la modelación en el desarrollo intelectual de escolares retrasados mentales leves. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
102. ROSENTAL M. LUDIN P. Diccionario filosófico. Editora política 1981.
103. PÉREZ L. (2004) "Proyecto esperanza para los niños discapacitados" En formato digital. Camagüey.
104. RUIZ A. (2009) Lo científico y lo popular; barrera epistémica en el quehacer científico investigativo cubano contemporáneo. Revista digital ICCP. No. 1.
105. _____ (2000) Sobre la cuestión de las leyes; principios y regularidades de la pedagogía. (Material mimeografiado). Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana.

106. _____ (1998) Metodología de la Investigación Educativa. Editorial UNOESC.
107. SHIF, ZH.I. (1980). Particularidades del desarrollo intelectual de los alumnos de la escuela auxiliar. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
108. SCHALOCK, R. L. Et. Al. (2007) Integrando los apoyos en la evaluación y planificación. Rev. Siglo Cero.
109. _____. (2004) *Hacia una nueva concepción de la discapacidad*. Conferencia Salamanca. Traducido por José María Arana.
110. _____. (2003) Manual de calidad de vida para profesionales de la Educación, Salud y Servicios Sociales. Ed. Alianza.
111. SILVA H. R. D. (2006) Modelo pedagógico para la formación ciudadana de los maestros primarios. Tesis doctoral. La Habana.
112. SILVESTRE M. (2003) El diagnóstico del proceso de enseñanza aprendizaje. ICCP.. Material en soporte magnético
113. TRAVIESO L. E, 2008. El desempeño profesional y humano de los promotores del programa EDUCA A TU HIJO..." Tesis doctoral. La Habana.
114. TORRES, M. (2000) "Conceptos" .Material mimeografiado. Ciudad de la Habana: Centro de Referencia Latinoamericano para la educación especial.
115. _____ "Hacia una comprensión histórico-cultural en el diagnóstico de las deficiencias intelectuales", 1998 artículo en soporte digital.
116. TRUJILLO L. y otros (1980) "Fundamentos de la Defectología" ED. Libros para la Educación.

117. UNESCO. (1994) Informe final. Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales. Acceso y calidad. Salamanca. España.1994;2-13p.
118. VALDEZ, H. (2000). Tecnología para la determinación de indicadores para evaluar la calidad de un sistema educativo .Material mimeografiado. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana.
119. VALLE L. A. (2007) Metamodelos de la investigación pedagógica. En soporte digital. Ciudad de la Habana. Pág. 6.
120. VERDUGO M. A. (1997) Jenaro C. Retraso mental, clasificación y sistemas de apoyos. Madrid: Alianza Editorial. p.14.
121. _____. (1994) El cambio de paradigma en la concepción del retraso mental: la nueva definición de la AARM. Revista Siglo Cero; 1994.
122. _____.(1994) *El papel de la psicología de la rehabilitación en la integración de personas con discapacidad y en el logro de calidad de vida*. Siglo Cero 256; 33-42.
123. _____. y otros (1994) "Actitudes sociales y profesionales hacia las personas con discapacidad. Estrategias de evolución e intervención. INSERSO. Madrid.
124. VIGOTSKI L. S. Obras completas. t. 5. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1995.
125. _____. (1982) Pensamiento y lenguaje. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
126. ZAMSKY, J. (1981). Historia de la Oligofrenopedagogía. Editorial de libros para la educación.

Págs. Webs: www.Psicopedagogia.com y <http://sid.usal.es>

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1: GUÍA PARA ENCUESTA A DOCENTES DE PRIMARIA.

ANEXO 2: GUÍA PARA ENCUESTA A DOCENTES DE ESCUELAS ESPECIALES.

ANEXO 3: GUÍA PARA ENCUESTA A ESPECIALISTAS DE LOS CDO.

ANEXO 4 GUÍA PARA OBSERVACIÓN A SESIONES DE EVALUACIÓN EN EL CDO.

ANEXO 5. ESCALA DE ACTITUD HACIA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

ANEXO 6. CUESTIONARIO SOBRE RETARDO MENTAL

ANEXO 7: RESULTADOS EN LA ENCUESTA A DOCENTES DE PRIMARIA.

ANEXO 8: RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES DE ESCUELAS ESPECIALES.

ANEXO 9. RESULTADOS OBTENIDOS ENCUESTA A ESPECIALISTAS ANEXO

10: RESULTADOS DE OBSERVACIONES DIAGNÓSTICO INICIAL ANEXO 11

RESPUESTAS POR ÍTEMS. ESCALA DE ACTITUD HACIA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

ANEXO 12. RESPUESTAS POR ÍTEMS (CUESTIONARIO SOBRE RETARDO MENTAL)

ANEXO 13: PARAMETRIZACIÓN

ANEXO 14 SÍNTESIS DEL PROGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN:

ANEXO 15 SÍNTESIS DEL MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO EDUCATIVO DE ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL.

ANEXO 16 REGISTRO DEL TALLER DE OPINIÓN CRÍTIC

ANEXO 17 RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA EXPLORACIÓN DEL MODELO ACTUANTE.

ANEXO 18 COMPARACION ENTRE MODELO ACTUANTE Y MODELO PROPUESTO.

ANEXO 19 RESULTADOS DE ENCUESTAS Y OBSERVACIONES LUEGO DE LA IMPLEMENTACION.

ANEXO 20 GUIA PARA LA ENCUESTA A EXPERTOS

ANEXO 21 APLICACIÓN DEL DELPHI A LA CONSULTA A EXPERTOS.

ANEXO 22 GUIA PARA LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

ANEXO 23. ANÁLISIS ESTADÍSTICO COMPARATIVO DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS PARA CADA DIMENSIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN EN LA PRÁCTICA..

ANEXO 24 INDICADORES DE POSIBLE RETRASO MENTAL

Anexo 1: Encuesta a docentes de primaria.

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre las características del proceso de diagnóstico a niños con indicadores de retraso mental que se desarrolla dirigido por el CDO, así como de las alternativas que se utilizan para el período denominado: Orientación y seguimiento. Agradecemos de antemano su colaboración y su sincera respuesta.

1. Marque las características que, a su criterio, corresponden a un educando con indicadores de retraso mental.

- Dificultades mantenidas en la esfera cognoscitiva _____
- Tara familiar _____
- Inadaptación escolar _____
- Abandono familiar _____
- Dificultades académicas: en la lectura, la ortografía, el cálculo, mala caligrafía _____
- No vencimiento de objetivos básicos del grado _____
- Inasistencia escolar _____
- Dificultades en el comportamiento _____
- Dificultades para lograr habilidades de la vida diaria (abotonado, acordonado, vestido y desvestido)
- Imposibilidad de usar equipos electrodomésticos u otros electromecánicos al servicio público _____
- Abandono pedagógico _____
- Desmotivación escolar _____
- Otras _____¿Cuáles? _____

2. ¿Cuál es el grado en que, con mayor frecuencia, se percibe por primera vez la posibilidad de que los niños tengan retraso mental?

1ro. ____ 2do. ____ 3ro. ____ 4to ____ 5to ____ 6to. ____

3. Si se analiza el proceso educativo que transcurre cotidianamente en la escuela, seleccione la forma principal en que se realizan las acciones de intervención con vistas a superar las dificultades en el aprendizaje y/o desarrollo. Justifique su selección.

Se consideran decisiones de ayuda, como cambio de método ____

Se realizan modificaciones en los procedimientos para vencer los objetivos y asimilar los contenidos. _____

Se determina una atención particular que consiste en repetir las actividades que no logró en clases en otro horario de manera individual, maestro-alumno. _____

Se toman decisiones organizativas, como cambio de puesto, piso, aula _____

Se espera a fin de curso para que vaya a la escuela especial porque allí es donde aprenderá. _____

Se realizan tutorías por los alumnos aventajados _____

Se envía al gabinete psicopedagógico. _____

4. ¿En su labor profesional usted ha utilizado alguna de estas alternativas para mejorar el proceso de desarrollo y aprendizaje de estos menores?

Sí _____ No _____ ¿cómo?

5. ¿Ha recibido entrenamiento o alguna preparación para utilizar alternativas de intervención, como las relacionadas en la pregunta 3?

Sí _____ No _____

a) Mencione en cuáles y qué tipo de preparación.

DATOS GENERALES

Cargo: _____

Grado que imparte: _____ Años de labor en el sector: _____

MUCHAS GRACIAS

Anexo 2: Encuesta a docentes de escuelas especiales.

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener una información preliminar sobre las características del proceso de diagnóstico que se desarrolla dirigido por el CDO a niños con presumible retraso mental, así como de las alternativas que se utilizan para el período denominado de orientación y seguimiento.

Agradecemos de antemano su colaboración y su sincera respuesta.

1. Marque las características que, a su criterio, corresponden a un educando con diagnóstico de retraso mental.

- Dificultades mantenidas en la esfera cognoscitiva _____
- Tara familiar _____
- Inadaptación escolar _____
- Abandono familiar _____
- Dificultades académicas: en la lectura, la ortografía, el cálculo, mala caligrafía _____
- No vencimiento de objetivos básicos del grado _____
- Inasistencia escolar _____
- Dificultades en el comportamiento _____
- Dificultades para lograr habilidades de la vida diaria (abotonado, acordonado, vestido y desvestido)
- Imposibilidad de usar equipos electrodomésticos u otros equipos electromecánicos al servicio público _____
- Abandono pedagógico _____
- Desmotivación escolar _____
- Otras _____¿Cuáles? _____

2. ¿Cuál es el grado del que con mayor frecuencia provienen los alumnos con retraso mental de nuevo ingreso?

1ro. _____ 2do. _____ 3ro. _____ 4to _____ 5to _____ 6to. _____

3. Si se analiza el proceso educativo que transcurre cotidianamente en la escuela, seleccione la forma principal en que se realizan las acciones de intervención con vistas a superar las dificultades en el aprendizaje y/o desarrollo. Justifique su selección.

Se consideran decisiones interventivas de ayuda, como cambio de método, introducción de procedimientos distintos para poder vencer los objetivos y asimilar los contenidos. _____

Se determina una atención particular que consiste en repetir las actividades que no logró en clases en otro horario de manera individual, maestro-alumno. _____

Se toman decisiones organizativas, como cambio de puesto, piso, aula _____

Se espera a fin de curso para que vaya a la escuela especial porque allí es donde aprenderá. _____

Se realizan tutorías por los alumnos aventajados _____

Se envía al gabinete psicopedagógico. _____

4. ¿Ha recibido entrenamiento o alguna preparación para participar en el proceso de diagnóstico?

Sí _____ No _____

- a) Mencione en cuáles y qué tipo de preparación.

5. Marque con una cruz las actividades que realiza para la constatación del diagnóstico

Observación_____	Comprobaciones de aprendizaje_____
Opinión externa (de psiquiatra o psicólogo)_____	Visita al hogar_____
Actividades extras con fines evaluativos_____	Trabajo de la CAD _____
Opiniones del consejo de dirección _____	Proceso de reevaluación _____
Aplicación de pruebas_____	la clase_____

6. ¿Puede distinguir entre un alumno con retraso mental leve y un alumno con dificultades específicas de aprendizaje agravadas?

Sí _____ no _____ a veces _____

Si su respuesta es no, diríjase a los datos generales y gracias por su colaboración. Si es sí, continúe hasta el final.

- a) seleccione y marque los que caracterizarían o determinarían la correspondencia con los criterios para diagnosticar retraso mental.

Edad de aparición _____
Dificultades académicas en los elementos esenciales del currículo _____
Ausencia, insuficiencias o ineficiencias en la formación de habilidades cotidianas _____
Dificultades en el comportamiento _____
Ausencia, insuficiencias o ineficiencias en la formación de habilidades personales _____
No vencimiento de objetivos básicos del grado _____
Ausencia, insuficiencias o ineficiencias en la formación de habilidades psicomotrices _____
Inmadurez o manifestaciones sistemáticas acordes con edades inferiores. _____
Dificultades académicas: en la lectura, la ortografía, el cálculo, mala caligrafía _____
Dependencia o demanda sistemática de los niveles de ayuda _____
Imposibilidad de usar equipos electrodomésticos u otros equipos electromecánicos al servicio público _____
Respuesta inusual o poco aprovechamiento de la ayuda en sus diferentes niveles _____
Abandono pedagógico _____
Frecuentes fracasos en el intento de transferir la ayuda asimilada a situaciones similares _____
Desmotivación escolar _____

7. Cuando aprecia que no existe correspondencia del diagnóstico de retraso mental y las características observables en algún(os) alumno(s) con ese diagnóstico usted puede:

Solicitar cambio de diagnóstico _____
Informar a personal facultado para ello _____
Informar a la CAD _____
Se lo comunica primero a su familia _____
Lo comenta con otros docentes _____
Lo informa al (la) director(a) _____

Eso es asunto exclusivo del CDO _____

8. En su opinión, puede decirse que la frecuencia de error o desacierto al diagnosticar el retraso mental en niños con otros problemas de aprendizaje o comportamiento es:

Muy frecuente _____ Frecuente _____ A veces _____ Casi nunca _____ Nunca _____

9. En su opinión, puede decirse que la frecuencia de error o desacierto al diagnosticar problemas de aprendizaje o comportamiento cuando en realidad se trata de retraso mental es:

Muy frecuente _____ Frecuente _____ A veces _____ Casi nunca _____ Nunca _____

10. Si lo desea puede expresar algún otro criterio positivo o negativo acerca del proceso de diagnóstico que dirige el CDO, específicamente en lo relacionado con el retraso mental.

DATOS GENERALES

Cargo: _____

Grado: _____

Años de labor en el sector: _____

MUCHAS GRACIAS

Anexo 3 Guía para encuesta a especialistas de los CDO (Adaptado de Encuesta AAIDD, 2010)

Enero 2008 Petición especial de Ms.C. Mirtha Leyva Fuentes
ISP Enrique José Varona. Ciudad de la Habana. Cuba

Querido y estimado colega:

Estudios relacionados con el diagnóstico del retraso mental y su perfeccionamiento incluyen una serie de actividades de corroboración y caracterización de este proceso en las actuales prácticas que se llevan a cabo en los equipos del CDO. Uno de estos esfuerzos es responder a la demanda de los propios equipos multidisciplinarios municipales comprendiendo mejor cómo en ellos:

- (a) se denomina a la condición (actualmente nombrada indistintamente como, discapacidad intelectual (DI) / retraso mental (RM) (u otros términos);
- (b) define, operacionaliza y emplea el término discapacidad /retraso mental etc.; y
- (c) utiliza de forma potencial un sistema de clasificación y diagnóstico.

Si UD. desea emplear cinco minutos en responder a las siguientes preguntas sobre a, b y c. Se ofrece este instrumento para la encuesta que puede completarse de forma muy breve y devolverse en formato impreso o electrónico. Los resultados de la encuesta se compartirán con todos los que respondan, y prevemos haber completado la encuesta y analizado las respuestas hacia el final del actual curso escolar.

Información de quien responde

Nombre:

Especialidad dentro del ETMM-CDO:

Municipio:

Provincia:

Dirección de e-mail:

Sección I: Terminología

1. Por favor marque (x) el término que más se utilice en su municipio:
Discapacidad intelectual ____ Minusvalía mental ____
Retraso mental ____ Retardo Mental ____
Subnormalidad mental ____ Discapacidad cognitiva ____
Deficiencia mental ____ Discapacidad del aprendizaje ____
Otra (por favor especifique) _____
2. Es este el mismo término utilizado por:
Organizaciones/empresas: ____ Sí ____ No ____
Direcciones de Trabajo y Seguridad Social ____ Sí ____ No ____
Trabajadores Sociales ____ Sí ____ No ____
Proveedores de servicios a adultos: ____ Sí ____ No ____
Escuelas: ____ Sí ____ No ____
Equipos de diagnóstico: ____ Sí ____ No ____
Investigadores : ____ Sí ____ No ____
3. Si hay diferencias en estos patrones de uso (es decir, en algunas sí y en otras no) por favor explique por qué:

Nivel de profundidad de la deficiencia _____
Conducta adaptativa _____
Etiología _____
Otras (por favor especifique):

11. Si respondió sí a la pregunta 9, ¿para qué propósitos son clasificados / agrupados?
(marque todas las que correspondan)
Financiación / reembolso de servicios _____
Investigación _____
Servicios _____
Comunicación sobre características seleccionadas _____
Otras (por favor especifique):

Sección V: Influencia organizacional

Hay tres organizaciones que generalmente se reconocen como autoridades potenciales en la definición en la materia: La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, anteriormente AAMR), la Asociación Americana de Psiquiatría (The American Psychiatric Association), y la Organización Mundial de la Salud (CIE-9, CIE-10, CIF). Por favor, puntúe el grado en que la terminología, definición y procesos de clasificación de su municipio están influidos por cada organización.

- 12- Por favor emplee la siguiente escala de tres puntos de respuesta para evaluar su influencia comparativa: 3=muy influido; 2=algo influido; 1=no influido.

____Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD; anteriormente la AAMR)

Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association): ____

____CIE-9

____CIE-10

____CIF

GRACIAS POR SU IMPORTANTE COLABORACIÓN que apreciamos.

Anexo 4 Guía de Observación a Sesiones de evaluación en el CDO.

Objetivo: Constatar los elementos que caracterizan las sesiones de diagnóstico en los CDO

Actividad: Sesión de evaluación.

Metodología: Se marcarán durante la sesión observada los elementos que aparecen descritos en este instrumento.

1. Correspondencia entre la estrategia de diagnóstico y el contenido de la sesión de evaluación. Existirá correspondencia si se utiliza lo previsto en la estrategia y si aquella existe.

Total ____ Parcial ____ No corresponde ____

2. Cumplimiento del objetivo de la evaluación

Total ____ Parcial ____ No corresponde ____

3. Utilización de recursos profesionales para el manejo de la dinámica del diagnóstico y las situaciones que se producen en el proceso.

Total ____ Parcial ____ Inconstante ____ No uso ____

4. Adecuación de las Técnicas a las características del caso.

Total ____ Parcial ____ No adecua ____

5. Habilidades comunicativas con los menores evaluados.

Adecuadas ____ Parcialmente adecuada ____ Inadecuadas ____

6. Habilidades comunicativas con los familiares de los menores evaluados.

Adecuadas ____ Parcialmente adecuada ____ Inadecuadas ____

7. Habilidad para lograr la participación

Adecuada ____ Parcialmente adecuada ____ Inadecuada ____

8. Nivel de motivación que logra.

Adecuada ____ Parcialmente adecuada ____ Inadecuada ____

9. Exploración de creatividad, potencialidades y experiencia de los menores evaluados

Adecuadas ____ Parcialmente adecuada ____ Inadecuadas ____

10. Flexibilidad para el manejo de las situaciones imprevistas

Adecuada(flexible) ____ Parcialmente adecuada (algo flexible) ____ Inadecuada ____

11. Presencia de tratamiento diferenciado

Adecuado ____ Parcialmente adecuado ____ Inadecuado ____

12. Soporte material para la evaluación

Adecuado ____ Parcialmente adecuado ____ Inadecuado ____

13. Acciones de anticipación al resultado (Ej. "Este ítems no podrá..." y detener)

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

14. Acciones que demuestren actitudes ante la discapacidad

Nunca ____ De rechazo ____ De aceptación ____ De indiferencia ____

15. Criterio para valoraciones de cierre parcial.

Integral y cualitativa ____ Cualitativa y fragmentada ____
Integral y cuantitativa ____ Cuantitativa y fragmentada ____

16. Momento de trabajo en equipo

Discusión multidisciplinaria ____ Discusión de algunos miembros ____
sin discusión ____

17. Criterio para valoraciones de cierre final.

Integral y cualitativa ____ Cualitativa y fragmentada ____
Integral y cuantitativa ____ Cuantitativa y fragmentada ____

18. Calidad general de la sesión

Adecuada ____ Parcialmente adecuada ____ Inadecuada ____

ANEXO 5. ESCALA DE ACTITUD HACIA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

Edad:

Sexo:

Tiene vínculo de algún tipo con personas con retraso Mental:

Si:

No:

Si responde Sí, ¿De qué tipo? Familiar____Laboral____Comunitario____

A cada afirmación de la izquierda Ud, deberá seleccionar una respuesta, reflejada en siglas cuyo significado son:

MA – Estoy Muy de Acuerdo

MD – Estoy Muy en Desacuerdo

BA – Estoy Bastante de Acuerdo
Desacuerdo

BD – Estoy Bastante en

PA – Estoy Parcialmente de Acuerdo
Desacuerdo

PD – Estoy Parcialmente en

Afirmaciones	Respuestas					
	MA	BA	PA	PD	BD	MD
1- De las personas con retraso mental no puede esperarse demasiado.						
2-Las personas con retraso mental son capaces de ajustarse a la vida fuera de una institución cerrada.						
3-En el trabajo las personas con retraso mental. entienden sin problemas con el resto de los trabajadores.						
4-Las personas con retraso mental pueden hacer muchas cosas también como cualquiera otra persona.						
5- Permitiría que mi hijo aceptara la invitación a un cumpleaños que le hiciera un niño con retraso mental.						
6-Las personas con retraso mental no requieren más benevolencia que cualquier otra persona.						
7-Las personas con retraso mental deberían tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra persona.						
8-Las personas con retraso mental funcionan en muchos aspectos como niños.						
9-La mayoría de las personas con retraso mental. están resentidas con las personas físicamente normales.						

10-Las personas con retraso mental tienen una personalidad poco equilibrada.						
11-Muchas personas con retraso mental pueden ser profesionales competentes						
12-Generalmente las personas con retraso mental son sociables						
13-Las personas con retraso mental pueden ser tan felices como las que no lo tienen.						
14-Las personas con retraso mental deberían ser confinadas en instituciones especiales.						
15-La mayoría de la gente se siente a disgusto cuando se juntan con las personas con retraso mental.						
16-La mayoría de las personas con retraso mental están satisfechas de si misma.						
17-La mayoría de las personas con retraso mental sienten que son tan valiosas como cualquiera.						
18-Las personas con retraso mental se alteran con la misma facilidad que las que no lo tienen						
19-Nunca adoptaría un niño con retraso mental.						
20-Evitaría acompañar a una persona con retraso mental a comer a un restaurante en el que me conocieran.						
21-La mayoría de las personas con retraso mental prefieren trabajar con otras personas que tengan su mismo problema.						
22-Las personas con retraso mental son incapaces de llevar una vida social normal.						
23-Me gusta estar cerca de personas que parecen diferentes y actúan de forma diferente.						

GRACIAS POR SU COLABORACION

ANEXO 6. CUESTIONARIO SOBRE RETARDO MENTAL

Instrucciones: Ponga una cruz en las columnas de respuestas sobre el número que mejor refleje su opinión sobre cada una de las afirmaciones que se hacen en la primera columna, considerando que:

1. Totalmente de acuerdo.
2. Bastante de acuerdo.
3. No estoy seguro.
4. Bastante en desacuerdo.
5. Totalmente en desacuerdo.

AFIRMACIONES	Respuesta				
	1	2	3	4	5
1. En general las personas con retraso mental llegan a tiempo a su trabajo.					
2. Las personas con retraso mental deberían disponer de asesoramiento especial para casarse y formar familia.					
3. El valor del ser humano no debería medirse por su inteligencia.					
4. Si una persona tiene retraso mental sus hijos serán retrasados.					
5. La mayoría de la gente evita hablar sobre personas con RM					
6. Existen diferentes tipos de retraso mental.					
7. Tienes miedo ante una persona con retraso mental.					
8. Las personas con retraso mental tienen derecho a votar					
9. Las personas con retraso mental están siempre felices y libres de preocupaciones.					
10. Las personas con retraso mental no necesitan que otras personas las ayuden a hacer todas las cosas					
11. Las personas con retraso mental deberían poder casarse si lo desean.					
12. La mayoría de las personas con retraso mental pueden encargarse de llevar a cabo tareas remuneradas.					
13. Las personas con retraso mental deberían poder divertirse con las demás personas.					
14. Las personas con retraso mental no pueden usar el transporte público.					
15. En el trabajo las personas con retraso mental se entienden sin problema con el resto de los trabajadores.					

16. Los conceptos de locura y retraso mental son diferentes.					
17. Las personas con retraso mental pueden manejar su propio dinero.					
18. No es posible decir si una persona tiene o no retraso mental basándose en su apariencia.					
19. Las personas con retraso mental saben que son retrasadas.					
20. Las personas con retraso mental no siempre necesitan que alguien a su alrededor piense por ellos.					
21. Las personas con retraso mental deberían disponer de expertos en leyes que se interesaran por sus problemáticas.					
22. Las personas con retraso mental no deberían estar en aulas especiales dentro de una escuela.					
23. Si una persona tiene retraso mental siempre será así.					
24. Las personas con retraso mental necesitan poder hablar con alguien sobre sus necesidades y problemas.					
25. A las personas con retraso mental se les debería poder dar un carné de conducción.					
26. Las personas con retraso mental son capaces de controlar sus sentimientos.					
27. Las personas con retraso mental deberían tener hijos si lo desean.					
28. En el trabajo una persona con retraso mental no es capaz de seguir instrucciones simples de sus superiores.					
29. Las personas con retraso mental no pueden vivir solas ni cuidar de si mismas.					
30. No me importaría que una persona con retraso mental viniera a vivir a mi comunidad.					
31. Las personas con retraso mental no tienen dificultad para decir lo que quieren.					
32. La mayoría de las personas con retraso mental no tienen porque estar en instituciones.					
33. Las personas con retraso mental pueden practicar deportes de la misma forma que las consideradas normales.					
34. A las personas con retraso mental se les debería prohibir pedir					

créditos o prestamos.					
35. Es bueno que los niños normales jueguen con niños con retraso mental.					
36. Las personas normales sienten lastima por las personas con retraso mental.					
37. La mayoría de las personas con retraso mental hacen las cosas más lentamente que las normales.					
38. Las personas con retraso mental no distinguen lo correcto de lo equivocado.					
39. Me gustaría tener como amigo una persona con retraso mental.					
40. La gente normalmente no se burla de las personas con retraso mental.					

Anexo 7: Resultados en la encuesta a docentes de primaria.

Los docentes encuestados reconocieron como las características que, corresponden a un educando con indicadores de retraso mental, las siguientes:

Dificultades mantenidas en la esfera cognoscitiva 100%

Tara familiar 66%

Inadaptación escolar 12%

Abandono familiar 30%

Dificultades académicas: en la lectura, la ortografía, el cálculo, mala caligrafía 0%

No vencimiento de objetivos básicos del grado 87%

Dificultades en el comportamiento 9 %

Dificultades para lograr habilidades de la vida diaria (abotonado, acordonado, vestido) 38%

Imposibilidad de usar equipos electrodomésticos u otros electromecánicos al servicio público 8%

Abandono pedagógico 43%

Desmotivación escolar 23%

Al preguntar el grado en que, con mayor frecuencia, se percibe por primera vez la posibilidad de que los niños tengan retraso mental las respuestas fueron: 1er grado por el . 89% y 2do grado por el 11%.

En cuanto a la forma principal en que se realizan las acciones de intervención con vistas a superar las dificultades la selección propuesta en la encuesta se comportó de la siguiente manera:

Modificación de procedimientos para vencer los objetivos y asimilar los contenidos. __12%

Se determina una atención particular que consiste en repetir las actividades que no logró en clases en otro horario de manera individual, maestro-alumno. __62%__

Se toman decisiones organizativas, como cambio de puesto, piso, aula __35%__

Se espera a fin de curso para que vaya a la escuela especial porque allí es donde aprenderá. __72%__

Se realizan tutorías por los alumnos aventajados __8%__

Se envía al gabinete psicopedagógico. __73%__

Respecto a la utilización alguna de estas alternativas para mejorar el proceso de desarrollo y aprendizaje de estos menores fueron frecuentes las respuestas positivas (100%) y señalan entre ellas: Aplicación de remediales, atención individual y modificaciones de procedimientos. Además plantean que en las preparaciones metodológicas han trabajado esos temas, pero que aún no se sienten bien preparados para acometer ese trabajo.

Anexo 8: Resultados de la encuesta a docentes de escuelas especiales.

Los docentes encuestados reconocieron como las características que, corresponden a un educando con indicadores de retraso mental, las siguientes:

Dificultades mantenidas en la esfera cognoscitiva 100%

Tara familiar 10%

Inadaptación escolar 100%

Abandono familiar 8%

Dificultades académicas: en la lectura, la ortografía, el cálculo, mala caligrafía 60%

No vencimiento de objetivos básicos del grado 98%

Inasistencia escolar 0 %

Dificultades en el comportamiento 46 %

Dificultades para lograr habilidades de la vida diaria (abotonado, acordonado, vestido) 55%

Imposibilidad de usar equipos electrodomésticos u otros electromecánicos al servicio público 0%

Abandono pedagógico 12 %

Desmotivación escolar 0 %

Al preguntar el grado en que, con mayor frecuencia, se percibe por primera vez la posibilidad de que los niños tengan retraso mental las respuestas fueron: 1er grado por el . 85% y 2do grado por el 15%.

En cuanto a la forma principal en que se realizan las acciones de intervención con vistas a superar las dificultades la selección propuesta en la encuesta se comportó de la siguiente manera:

Se consideran decisiones de ayuda, como cambio de método 0%

Modificación de procedimientos para vencer los objetivos y asimilar los contenidos. 12%

Se determina una atención particular que consiste en repetir las actividades que no logró en clases en otro horario de manera individual, maestro-alumno. 62%

Se toman decisiones organizativas, como cambio de puesto, piso, aula 35%

Se espera a fin de curso para que vaya a la escuela especial porque allí es donde aprenderá. 72%

Se realizan tutorías por los alumnos aventajados 8%

Se envía al gabinete psicopedagógico. 73%

Referente a si ha recibido entrenamiento o alguna preparación para participar en el proceso de diagnóstico el 100% dijo que no.

En lo concerniente a las actividades que realiza para la constatación del diagnóstico la frecuencia de respuestas se comportó como sigue

:

Observación 73%

Opinión externa (de psiquiatra o psicólogo) 75 %

Actividades extras con fines evaluativos 0%

Opiniones del consejo de dirección 0 %

Aplicación de pruebas 38%

Comprobaciones de aprendizaje 42 %

Visita al hogar 6%

Trabajo de la CAD 100%

Proceso de reevaluación 100%

la clase 6%

Al preguntarles si puede distinguir entre un alumno con retraso mental leve y un alumno con dificultades específicas de aprendizaje agravadas el 92% dijo que no y el 8% que a veces.

Ese 8% en el resto del instrumento seleccionó como criterios:

a) seleccione y marque los que caracterizarían o determinarían la correspondencia con los criterios para diagnosticar retraso mental.

Dificultades académicas en los elementos esenciales del currículo

Dificultades en el comportamiento

No vencimiento de objetivos básicos del grado

Inmadurez o manifestaciones sistemáticas acordes con edades inferiores

Dificultades académicas: en la lectura, la ortografía, el cálculo, mala caligrafía
Dependencia o demanda sistemática de los niveles de ayuda
Frecuentes fracasos en el intento de transferir la ayuda asimilada a situaciones similares
Expresaron en relación a qué hace cuando aprecia que no existe correspondencia del diagnóstico de retraso mental y las características observables en algún(os) alumno(s) con ese diagnóstico:

Solicitar cambio de diagnóstico 78%
Informar a personal facultado para ello 95%
Informar a la CAD 100%
Se lo comunica primero a su familia 12%
Lo comenta con otros docentes 25%
Lo informa al (la) director 0%
Eso es asunto exclusivo del CDO 30%

Opinan que la frecuencia de error o desacierto al diagnosticar el retraso mental en niños con otros problemas de aprendizaje o comportamiento es: Muy frecuente 11% Frecuente 70% A veces 18%

Anexo 9. Resultados obtenidos encuesta a especialistas

Sobre la sección I: Terminología

El 100% señaló como el término que más se utiliza en su municipio al retraso mental. Asimismo plantean que es el mismo término que utilizan el resto de las organizaciones o centros de la pregunta 2.

Sección II: Definición

Los especialistas señalaron como criterios de su definición todos excepto el que se refiere a la conducta adaptativa y a la edad de comienzo. La frecuencia de selección fue:

Afectaciones significativas en la actividad cognoscitiva 100%

Afectación en el Sistema Nervioso en períodos pre, peri y postnatal 100%

Presencia de factores hereditarios, genéticos, adquiridos e infraestimulación 60%

Al operacionalizar su definición en términos respecto al Funcionamiento intelectual: reconocen una Puntuación absoluta de CI: menor que 70 para el RM leve. Lo relacionado con las unidades de desviación estándar, solo fue contestado por el 40 % de los encuestados que lo enmarcaron entre 1 y 2.

Ningún especialista llenó lo referido a la Conducta adaptativa.- y en cuanto a la Edad de comienzo el 100% escogió Antes de 18.

Al solicitarle que escribiera la definición oficial de RM empleada en su municipio/provincia y referir su(s) autor(es). el 100% mencionó o citó la de M. Torres, "Una característica especial del desarrollo donde se presenta una insuficiencia en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores, comprometiendo de manera significativa la actividad cognoscitiva y provocado por una afectación importante del sistema nervioso central en los períodos pre, peri y postnatal, por factores genéticos, biológicos, adquiridos e infraestimulación socio-ambiental intensa en las primeras etapas evolutivas que se caracteriza por la variabilidad y diferencias en el grado de compromiso funcional".

En la sección III

Con relación al uso de la definición aceptan que se referencia en los trabajos, pero respecto a los propósitos el 100% eligió el relacionado con la elegibilidad de los servicios y sólo el 40% seleccionó además, la planificación de apoyos. Un 38% en otros propósitos añadieron "el diagnóstico"

Sección IV: Clasificación

El 100% plantea que sí se clasifica a los individuos con retraso mental y especificaron que atendiendo al nivel de profundidad. Asimismo respecto a los propósitos para clasificar el 100% señala solamente el investigativo.

Sección V: Influencia organizacional

Al evaluar la influencia las organizaciones, comparando los niveles de las tres más reconocidas a nivel mundial, a cada una de las cuales debían otorgar una de las tres opciones siguientes: 3=muy influido; 2=algo influido; 1=no influido. Los especialistas asignaron 2 a la AAMR y 1 a las (CIE-10 / CIE-9 y CIF)

Anexo 10: Resultados de observaciones diagnóstico inicial

En cuanto a la *correspondencia entre la estrategia de diagnóstico y el contenido de la sesión observada* en las observaciones realizadas a sesiones de evaluación en la sede del CDO fue total en el 100% de los casos, pero en aquellas sesiones que se acometen en las propias escuelas durante las primeras etapas, el 63% fue parcial y el 37% se valoró sin correspondencia.

El *cumplimiento del objetivo* de la evaluación en el 100% de las observaciones se dio totalmente.

En el 100% de las sesiones de evaluación se *manejaron adecuadamente las situaciones* surgidas mediante la utilización de recursos profesionales para su manejo, en situación de los contextos escolares no se revelaron esas cualidades en los especialistas ante situaciones como conductas inapropiadas de los menores evaluados, condiciones no favorables para la aplicación de metódicas o ante eventos inesperados que interrumpían la dinámica del diagnóstico.

En relación a la *adecuación de las técnicas a las características del caso*, en el 100% de los casos se observaron no se realizaron adecuaciones.

El 96% de los especialistas mostraron *habilidades comunicativas* adecuadas con los menores evaluados y con sus familias, así como para lograr la cooperación, disposición y participación de los escolares.

Al considerar si los especialistas alcanzan los *niveles de motivación en los niños*, se aprecian irregularidades, pues cada una de las tres maneras de manifestarse que recogía la guía obtuvo un treinta y tanto de por ciento. Se estima que las causas estén relacionadas con el mal manejo que se hace en las escuelas de la presencia de los especialistas del CDO, ya que a los niños se les suele amenazar con ello y con la consecuencia centrada en su envío a una escuela especial, lo que los coloca a ellos y a sus familias en una situación de alerta y hasta de rechazo.

En ninguna de las observaciones (0%) se realizaron acciones ni emplearon *técnicas o metódicas para explorar la creatividad, potencialidades y experiencia* de los menores evaluados. Tampoco se percibió un tratamiento diferenciado, en tanto cada especialista aplica la técnica con un algoritmo similar y poco variable, es decir, de la misma manera a todos.

El soporte material para la evaluación es deficiente, no siempre se cuenta con el material original. Se observaron copias e imitaciones muy creativas, pero que al menos resuelven la carencia material de los sets de pruebas, con los que no cuenta el país.

En un 42% se visualizaron acciones de anticipación al resultado como son detener la prueba (aún sin estar previsto en la metodología de aplicación), porque la próxima tarea o ítems “se ve que no podrá lograrlo”

Resultó muy interesante la recogida de acciones que demuestren actitudes ante la discapacidad, sobre todo, porque los especialistas que se sabían observados, no tenían concebido que este fuera un elemento y por el modo espontáneo e inconsciente en que este elemento se manifiesta. Ejemplo de ellos fueron comentarios como: “Este va directo para la escuela de retraso” “Este es mongó, en su familia hay cantidad de retrasados” “este seguro no va a aprender a leer” “Dicen que esta niña parece hija mía ¡Dios me libre!” “Yo conozco a su mamá ¡la pobre!” o de indiferencia como “Este caso está perdido pero nadie tiene la culpa” “Al final, el problema no es mío, sino de sus padres” “¡Allá los pobres maestros que le toque!”

En cuanto al criterio para valoraciones de cierre parcial, se comportó de la siguiente manera:

Integral y cualitativa 7.3 %

Cualitativa y fragmentada 53.2 %

Integral y cuantitativa 23%

Cuantitativa y fragmentada 26.5%

En lo referido a cuáles momentos eran implementados verdaderamente en equipo, sólo el cierre final, pero en el 37% no ocurrió con la totalidad de los miembros. En varias sesiones de seguimiento se escucharon frases como esta: “este caso nunca lo he visto, no sé nada de él, porque esta escuela (o consejo popular) es de la pedagoga”

La calidad general de la sesión observada en el 91% de los casos fue parcialmente adecuada y en un 9% adecuada.

Anexo 11 Respuestas por ítems. Escala de actitud hacia las personas discapacitadas

ESCALA *								
Grupos	No	Frecuencia de Categorías seleccionadas						
		1	BA	PA	PD	BD	MD	Total
Especialistas del CDO	29	0	131	248	226	62	0	667
Docentes de especial	33	33	249	218	155	96	8	759
Docentes de primaria	28	53	179	147	117	131	17	642
Total	90	86	559	613	496	291	25	2070

ESCALA						
Ítems	Frecuencia de Categorías seleccionadas					
	MA	BA	PA	PD	BD	MD
1.	0	19	54	17	0	0
2.	0	39	46	5	0	0
3.	0	57	33	0	0	0
4.	0	90	0	0	0	0
5.	0	68	14	8	0	0
6.	4	22	59	5	0	0
7.	0	9	51	30	0	0
8.	0	2	27	49	11	1
9.	0	19	63	6	0	2
10.	0	0	0	17	68	5
11.	0	5	17	50	15	3
12.	19	67	4	0	0	0
13.	9	69	12	0	0	0
14.	0	0	0	0	79	11
15.	0	3	34	43	10	0
16.	13	18	59	0	0	0
17.	32	29	29	0	0	0
18.	0	7	61	22	0	0
19.	0	26	5	45	14	0
20.	9	3	8	62	8	0
21.	0	0	28	54	8	0
22.	0	7	6	51	23	3
23.	0	0	3	32	55	0
Total	86	559	613	496	291	25

Para esta escala se agruparon los ítems de la siguiente manera (Respetando la distribución factorial del autor de la escala):

1. Valoración de limitaciones y capacidades: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 18.
2. Reconocimiento/negación de derechos: 4, 6, 9, 14, 22.
3. Implicación personal: 5, 15, 19, 20, 23.
4. Asunción de roles: 16 y 17
5. Calificación genérica: 10, 12, 21.

Explicación del contenido de los grupos

- 1- Su contenido se refiere esencialmente a la concepción que el encuestado tiene de las personas con retraso mental respecto a su capacidad de aprendizaje y desempeño y ejecución de tareas.
- 2- Se refiere al reconocimiento de derechos fundamentales de las personas con retraso mental.
- 3- Juicios referidos a comportamientos concretos de interacción que el encuestado llevaría a efecto frente a personas con retraso mental.
- 4- Atribuciones globales y calificaciones genéricas que el encuestado efectúa acerca de rasgos presuntamente definitorios de la personalidad o conducta de las personas con retraso mental.
- 5- Presunciones acerca de la concepción que de sí mismas tienen las personas con retraso mental.

En esta escala se obtuvieron respuestas más acertadas en el caso de los ítems en afirmaciones falsas. Excepto en los: 1, 7, y con marcado énfasis el 12. En el grupo de implicación personal se manifestaron respuestas desacertadas, que

evidencian rechazo o poca aceptación. En el grupo de la valoración de limitaciones y capacidades se concentran la mayor distribución de frecuencias medias, entre las categorías PA y PD, lo que evidencia desconocimiento. Además, se analizaron los criterios de los participantes sobre la calidad del proceso de diagnóstico específicamente ante casos con indicadores de retraso mental y se interpretaron otros datos obtenidos en la observación y la aplicación de instrumentos para medir actitudes.

ANEXO 12. Respuestas por ítems (CUESTIONARIO SOBRE RETARDO MENTAL*)

Ítems	Frecuencia de Categorías seleccionadas				
	1	2	3	4	5
1.	0	69	21	0	0
2.	0	20	13	37	10
3.	0	48	5	37	0
4.	0	3	49	32	6
5.	0	13	21	56	0
6.	12	44	34	0	0
7.	13	53	11	13	0
8.	0	5	40	45	0
9.	3	76	11	0	0
10.	0	55	13	13	9
11.	0	7	25	53	5
12.	3	25	27	25	10
13.	19	36	18	14	3
14.	5	22	29	34	0
15.	5	38	21	22	4
16.	10	60	12	8	0
17.	0	1	27	46	16
18.	8	23	5	54	0
19.	0	15	38	27	10
20.	2	17	20	41	10
21.	14	26	35	15	0
22.	0	53	8	29	0
23.	0	79	11	0	0
24.	7	12	50	21	0
25.	0	5	27	58	0
26.	6	23	33	28	0
27.	0	0	25	57	8
28.	0	0	12	64	14
29.	0	38	44	3	5
30.	0	54	19	14	3
31.	1	21	33	29	6
32.	0	63	22	5	0
33.	9	50	21	10	0
34.	0	20	56	14	0
35.	6	51	23	6	4
36.	0	53	18	19	0
37.	12	35	32	9	2
38.	7	50	19	14	0
39.	7	29	35	16	3
40.	0	0	29	54	7
Total	149	1292	992	1022	135

CUESTIONARIO SOBRE RETARDO MENTAL*							
Grupos	No	Frecuencia de Categorías seleccionadas					
		1	2	3	4	5	Total
Especialistas del CDO	29	0	485	432	243	0	1160
Docentes de especial	33	104	492	246	407	71	1320
Docentes de primaria	28	45	325	314	372	64	1120
Total	90	149	1292	992	1022	135	3600

El análisis del *Cuestionario Sobre Retardo Mental*, con estilo de *diferencial semántico*, debe hacerse con dominio pleno del mismo.

Resulta que en este instrumento, las respuestas acertadas no se corresponden con la selección de las categorías 1y 2 ni las desacertadas con las 4 y 5. Los diferentes ítems se presentan en el cuestionario en forma de afirmación. Ésta puede ser falsa, verdadera o neutral: es decir, las de implicación personal.

Para esta investigación se tomaron como falsos los ítems: 5, 22, 28, 40 (lo cual origina como respuesta acertadas estar en desacuerdo total) Asimismo como neutrales 4, 12, 14, 17, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38 y 39.

- Como falsos se reconocen para esta investigación: 1, 7, 8, 10, 12, 14, 22, 21.

Para el análisis además se agruparon los ítems de acuerdo con las siguientes generalizaciones:

- Vida adulta independiente: 12, 17, 29.
- Características de las personas con RM: 1, 9, 10, 20, 24, 26, 28, 31.
- Conocimiento del RM y sus causas: 5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 27, 32, 33, 37, 38.

- Derechos legales: 2, 8, 11, 14, 21, 22, 25, 34.
- Aceptación social: 3, 4, 13, 15, 22, 30, 35, 36, 39, 40.

En esta escala se obtuvieron respuestas más acertadas en el caso de los ítems en afirmaciones falsas. Excepto en los: 1, 7, y con marcado énfasis el 12. En el grupo de implicación personal se manifestaron respuestas desacertadas, que evidencian rechazo o poca aceptación.

ANEXO 13: Parametrización de la variable proceso de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental.

DIMENSIÓN I: EVALUACIÓN DE LOS ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL.

SUBDIMENSIONES	INDICADORES	PLANOS DE ANÁLISIS	MÉTODOS	INSTRUMENTOS
Biológica	Desarrollo estructural y funcional del organismo.	. Nivel de desarrollo de las estructuras del SNC (alto, medio bajo) . Nivel de desarrollo de otras estructuras corporales (alto, medio, bajo)	Análisis de documentos	
Psicológica	Funcionamiento general	. Estado de la actividad cognoscitiva (alto, superior, promedio, bajo e inferior) . Estado emocional (adecuado, inadecuado, ambiguo, inconstante) . Estado volitivo (Negativista, reticente, dispuesto, perseverante, inconstante) . Estado vivencial durante el diagnóstico (triste, angustioso, conflictivo, inseguro, feliz, inconstante)	Observación	Guía de observación
	Desarrollo cognoscitivo	Para los tres primeros:(alto, superior, promedio, bajo e inferior) . Nivel de inteligencia . Nivel de las Habilidades intelectuales. . Nivel de las Habilidades comunicativas . Grado de competencia curricular (aprobado, con objetivos no vencidos y desaprobado) . Estado de los estilos de aprendizaje (Tipo predominante)	Análisis de documentos Observación Pruebas psicológicas	Guía de análisis Guía de observación Pruebas establecidas
	Demanda y solicitud de la ayuda	. Frecuencia de solicitud (Alta, media o baja) . Nivel de ayuda que requiere (Alto, medio o bajo) . Nivel de transferencia en actividades verbales(alto, bajo) . Tipos de transferencia en tareas verbales (total, parcial) . Tipos de transferencia en acciones (total, parcial)	Análisis de documentos Observación	Guía de análisis Guía de observación
	Desarrollo socio-afectivo	Para todos los indicadores(Alto, medio o bajo) . Nivel de relaciones interpersonales con coetáneos. . Nivel de relaciones interpersonales con adultos allegados . Nivel de relaciones interpersonales con adultos ajenos . Nivel de reacción ante la crítica . Nivel de reacción ante las normas y límites . Nivel de las habilidades para el autovalidismo . Nivel de las potencialidades socio-comunicativas y culturales	Análisis de documentos Observación Encuesta	Guía de análisis Guía de observación Guía para la encuesta
Psicológica				

(cont)	Desarrollo actitudinal	Para todos los indicadores (positiva, indiferente, negativa) . Actitud ante sí mismo . Actitud ante los otros . Actitud ante el estudio . Actitud ante el trabajo . Actitud ante actividades político/culturales . Actitud ante actividades de ocio . Actitud en el contexto escolar . Actitud en el contexto familiar . Actitud en el contexto comunitario	Análisis de documentos Observación Encuesta	Guía de análisis Guía de observación Guía para la encuesta
Social	Desarrollo social	. Nivel de habilidades en el uso de los servicios y recursos . Nivel de habilidades de protección y defensa . Nivel de habilidades de autodeterminación . Nivel de independencia en el empleo del tiempo libre	Análisis de documentos Observación	Guía de análisis Guía de observación
	Desarrollo de la comunicación social	- Nivel de habilidades para la: . Comunicación oral . Comunicación escrita . Comunicación gestual . Comunicación alternativa	Encuesta	Guía para la encuesta
	Dominio de roles sociales a cumplir	- Nivel de habilidades para cumplir: . roles personales . roles escolares . roles familiares . roles comunitarios	Pruebas Psicológicas	BEDMAS Metódicas de autovaloración y valoración
	Desarrollo de la representación social	Para todos los indicadores (positiva, indiferente o negativa) . Estado de la representación de sí mismo . Estado de la representación de su familia . Estado de la representación de su comunidad		

DIMENSIÓN II: LOS ESPECIALISTAS DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN.

SUBDIMENSIONES	INDICADORES	PLANOS DE ANÁLISIS	MÉTODOS	INSTRUMENTOS
Cognoscitiva	Dominio de la definición de retraso mental.	Para todos los indicadores: (alto, medio o bajo) . Nivel de dominio de la definición de retraso mental . Nivel de dominio sobre los criterios diagnósticos . Nivel de dominio de los propósito diagnósticos	Análisis de documentos	Guía de análisis
	Dominio de la clasificación y terminología	Para todos los indicadores: (alto, medio o bajo) . Nivel de dominio de la clasificación . Nivel de dominio de la terminología	Observación	Guía de observación
	Dominio metodológico del proceso de diagnóstico.	Para todos los indicadores: (alto, medio o bajo) . Nivel de dominio del sistema instrumental . Nivel de dominio de las fases del proceso de diagnóstico . Nivel de dominio de los criterios diferenciales de diagnóstico	Encuesta	Guía de encuesta
	Desarrollo académico	. Grado de preparación académica (Bachiller, licenciado o máster) . Grado de correlación por especialidad de estudio (graduado de pedagogía, graduado afín, graduado no afín) . Grado de preparación científica (graduado como doctor en ciencias, en curso, no investiga)		
Ejecutiva	Habilidades metodológicas para el diagnóstico	Para todos los indicadores: (alto, medio o bajo) Nivel de habilidades para: - la selección y aplicación de los procedimientos y pruebas a emplear. - el trabajo en equipo con vistas a la implementación de las diferentes fases del diagnóstico. - acometer las tareas relativas a su especialidad. - acometer las tareas relativas al uso de los criterios diferenciales para el diagnóstico. - la detección de las necesidades - hacer corresponder las acciones educativas y/o de apoyos con las necesidades. - la jerarquización adecuada de necesidades y el diseño de acciones que la satisfagan. - diseñar y elaborar adaptaciones curriculares	Análisis de documentos Observación Encuesta	Guía de análisis Guía de observación Guía de encuesta
	Habilidades en la confección del informe.	Para todos los indicadores: (alto, medio o bajo) Nivel de habilidades para: - Describir las pruebas aplicadas. - Analizar los resultados de la evaluación de los contenidos curriculares. - Valorar el desarrollo de capacidades generales del sujeto. - Valorar el desarrollo de habilidades intelectuales - Valorar el desarrollo de habilidades prácticas - Valorar el desarrollo de habilidades sociales - revelar la relación dificultades – necesidades– capacidades/ habilidades.		

		- Analizar didáctica y funcionalmente las potencialidades y necesidades. - Describir los estilos de aprendizaje. - Proponer adaptaciones y decisiones curriculares. - Explicar el diagnóstico del alumno		
Afectivo-motivacional	Actitud ante la influencia de elementos pre-disponentes y anticipatorios	Para todos los indicadores (positiva, indiferente, negativa) - Estado de la actitud ante la creencia de límites de desarrollo en los sujetos con retraso mental. - Estado de la actitud ante la costumbre de priorización de los elementos académicos sobre los funcionales.	Observación Encuesta	Guía de observación Escala y encuesta estandarizadas para medir actitudes
	Actitud ante la discapacidad	Para todos los indicadores (apropiado/positivo-indiferente/neutral-inapropiado/negativo) - Nivel de adecuación respecto a las posibilidades que le atribuye para: a) Tenencia de capacidades b) Reconocimiento de sus derechos c) Asunción de roles - Nivel de adecuación respecto a su propia implicación personal - Nivel de adecuación respecto a cómo califica la discapacidad.		
	Actitud ante el retraso mental	Para todos los indicadores (apropiado/positivo-indiferente/neutral-inapropiado/negativo) - Nivel de dominio del retraso mental y sus causas - Nivel de adecuación respecto a las posibilidades que le atribuye para: a) Su vida adulta independiente b) El ejercicio de sus derechos legales c) El Cumplimiento de responsabilidades laborales d) El Cumplimiento de responsabilidades sociales e) Su aceptación social		

Para cada subdimensión y plano de análisis se hará corresponder uno de los siguientes parámetros: Bajo, Medio o Alto. El criterio que se tendrá en cuenta es el valor porcentual respecto a los indicadores de cada plano de análisis, considerando la correspondencia de la siguiente manera:

Para cerrar los Indicadores

Si del total de sus planos de análisis:

- el 25% es Alto o Medio y el 75% es Bajo. Corresponderá BAJO al plano.
- el 50% es Bajo y el resto Medio o Alto Corresponderá MEDIO al plano.
- el 25% es Medio y el 75% es Alto. Corresponderá ALTO al plano.

Para cerrar las subdimensiones

Si de todos sus planos:

- el 25% es Alto o Medio y el 75% es Bajo. Corresponderá BAJO a la subdimensión.
- el 50% es Bajo y el resto Medio o Alto Corresponderá MEDIO a la subdimensión.
- el 25% es Medio y el 75% es Alto. Corresponderá ALTO a la subdimensión.

Nota: Los indicadores valorados cualitativamente serán parametrizados de la siguiente manera:

Si es evaluado como:	Se aplicará el parámetro:
Inapropiado / negativo / bachiller	Bajo
Indiferente / neutral / licenciado	Medio
apropiado / positivo / máster o doctor	Alto

Anexo 14 SINTESIS DEL PROGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN:



1. TITULO: Una mirada en torno al Diagnóstico educativo, la discapacidad, las necesidades educativas especiales y la prevención.

2. Organismo: MINED. UCPEJV. Fac. Educación Infantil. Dpto. E. Especial

. **Coordinador:** M. Sc. Mirtha Leyva Fuentes. Instructor

. **Duración:** 48 horas presenciales. Tiempo indefinido para las no presenciales

. **MODALIDAD:** Semi presencial

3. FUNDAMENTACIÓN:

a) Necesidades que se satisfacen (económicas, sociales y/o culturales) con la aplicación del programa, incluyendo la estimación aproximada de la demanda solicitante.

En la actualidad se reconoce a nivel nacional una necesidad creciente de superación del personal docente que labora en los Centros de Diagnóstico y Orientación. CDO. Teniendo en consideración los avances experimentados por la Ciencia y la Técnica en general y en particular por la Pedagogía y Psicología Especiales se impone ante estos equipos que son considerados centro metodológico del trabajo preventivo y el diagnóstico, un enorme reto y compromiso profesional en cuanto a las respuestas educativas que como parte y finalidad del proceso de diagnóstico deben diseñar, proponer y/o implementar.

No obstante a los esfuerzos en cuanto a la superación de este personal, con el fin de ofrecer a los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales la respuesta educativa que los mismos demandan, por diversas razones no todos los especialistas se encuentran recibiendo las influencias que, a partir de diversas modalidades se ofertan. Es por ello que se incorporan a éstas los cursos de postgrado y/o superación que posibilitan la preparación de los mismos en diferentes temática.

b) Área de influencia del programa (nacional, regional y/o local).

Las necesidades de superación de los especialistas que laboran en los CDO constituyen una problemática nacional e internacional, por lo que el presente programa tendrá pertinencia, siempre

que se demande. Actualmente está dirigido a los Directores de los ETMM del CDO de la provincia Ciudad de la Habana.

c) Experiencia acumulada en pregrado y postgrado en la institución en general y en el área del conocimiento del programa.

La experiencia de más de 30 años acumulada por los profesionales en el proceso de evaluación, diagnóstico y orientación, la formación de pregrado y postgrado en el tratamiento de la temática a través de cursos, diplomados, talleres nacionales e internacionales. La ejecución de 10 ediciones de la Maestría en Educación Especial desarrollada en Cuba y en el extranjero por el CELAEE y el ISPEJV, donde se aborda la temática como asignatura y atraviesa como contenido todos los módulos, las aportaciones de la Maestría en Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, avalan y demuestran la competencia de la institución para la ejecución del programa de superación y/o postgrado en el tema de diagnóstico.

d) Experiencia y resultados de grupos y líneas de investigación consolidados en el área del conocimiento que avalen el programa.

Constituyen marco referencial importante las concepciones relativas al **diagnóstico educativo integral** como “un proceso de búsqueda para el conocimiento del fenómeno educativo, en general, o de cualquiera de sus partes, en específico. Requiere del uso de procedimientos evaluativos científicos, aplicados preferiblemente en el medio natural, con vistas a la toma de decisiones acerca de cómo prevenir y conformar la atención educativa integral. Tiene un carácter continuo, inacabado y de retroalimentación constante, su decurso es cíclico. Todo ello, a partir de un enfoque histórico cultural que parte de concebir al individuo a partir de sus elementos biológicos, psicológicos y sociales en interacción con los factores contextuales”. Los resultados de las principales investigaciones, las más de 200 tesis de diploma, maestría y doctorado; los proyectos de investigación junto a una diversidad de fuentes de información nacional y extranjera, la presentación de ponencias, cursos, talleres en eventos nacionales e internacionales, la producción científica sobre esta área del conocimiento, avalan el programa de la especialidad y respaldan el recurso bibliográfico recomendado para su ejecución.

e) Nivel de relaciones interinstitucionales que potencian la calidad del programa.

El programa de curso de capacitación en su concepción y diseño es el resultado de la colaboración científica, académica y asistencial de la obra y relaciones inter institucionales de la UCPEJV,

CELAEE, CELEP, IPLAC, DPE. MINSAP, Universidad de la Habana, la Clínica del adolescente, el MININT entre otras. Esta relación potencia la calidad científica del programa y permite un abordaje más integral e interdisciplinario.

f) **Necesidades científicas o de desarrollo del área del conocimiento.**

El subsistema cubano de educación especial exige de profesionales preparados capaces de dar respuesta a las expectativas sociales de todas las modalidades y centros de recurso y atención que abarca, llamadas a cumplir con la atención y provisión de recursos y ayudas dirigidos a los escolares con necesidades educativas especiales donde quiera que éstos se encuentren; lo que es posible si desde el proceso de diagnóstico ello se prevé.

Para el logro de este objetivo se impone la necesidad de preparar a los especialistas de los ETMM y el ETAP del CDO. en los temas relacionados con el diagnóstico, lo que les permitirá **dirigir eficientemente el proceso de diagnóstico sobre la base del reto que enmarca la atención a la diversidad.** Al tomar como punto de partida el conocimiento de los alumnos en su medio natural, la determinación de sus potencialidades y carencias, se estará en condiciones de **establecer estrategias de orientación, intervención y prevención que permitan determinar eficientemente la respuesta educativa con la cual poder corregir, compensar y potenciar el desarrollo de sus educandos.**

De manera que existen condiciones objetivas en la realidad educativa cubana actual, que reclaman de la presencia de este programa de superación y/ postgrado, que se pueden resumir en las siguientes:

- El perfeccionamiento del diagnóstico constituye una de las principales necesidades del sistema educativo cubano, en general y del subsistema de educación especial, en particular; para lo cual los especialistas del CDO requieren de mayor dominio y profundización teórica y práctica, como una necesidad social y educativa emergente.
- El reclamo de un profesional de la educación que esté en mejores condiciones de brindar una atención adecuada a la diversidad, de promover las acciones para el éxito de la integración educativa y convierta el proceso instructivo educativo en un espacio de prevención y promoción de desarrollo, que se completa con las influencias que el CDO ejerce en casi todas las educaciones, como expresión genuina de la justicia y equidad que caracteriza nuestro proyecto social.

4. ESTUDIANTES

- **Requisitos de ingreso de carácter académico y profesional necesarios para ser aceptados.**

Para la modalidad de postgrado se tendrán en cuenta los siguientes:

1. Ser graduado de la educación superior, condición que será avalada con la presentación del título que lo acredita como tal.
2. Ser especialista de un ETMM del CDO.
3. Ser director municipal de un ETMM del CDO o del ETAP.

Para la modalidad de curso de superación los requisitos serán:

1. Ser bachiller (12mo grado aprobado), avalado con la presentación del título que lo acredita.
2. Estar vinculado laboralmente a uno de los centros antes mencionados.
3. Tener al menos 1 año de experiencia en el sector.

- **Proceso para la selección de alumnos:**

El ETAP definirá quienes se incorporan, asimismo se encargará de informar a todos los implicados y sus administrativos del territorio.

5. OBJETIVO GENERAL: Elevar la competencia profesional de los especialistas de los ETMM del CDO de las provincias de Ciudad de la Habana y Artemisa, para perfeccionar el proceso de diagnóstico educativo en general, con énfasis en aquél dirigido a escolares con indicadores de retraso mental en el sistema educativo cubano actual.

Que les permita conocer y aplicar los fundamentos del diagnóstico educativo para elevar los niveles de desempeño profesional pedagógico, que permita se eleven los niveles de desarrollo alcanzados por los educandos a partir de mejores prácticas de diagnóstico, reveladas en mayor calidad de la atención educativa integral resultante.

6. ASEGURAMIENTOS:

El ETAP de Ciudad de la Habana quien es el promotor y demandante del curso previamente solicitado a la UCPEJV garantiza la citación y coordinación para cada encuentro. La UCPEJV nombra como coordinadora a la profesora instructora y Máster en Educación Especial Mirtha Leyva Fuentes, quien Laboró por más de seis cursos en un ETAP del CDO y es miembro permanente del Proyecto nacional, dirigido por la Dra. C. Caridad Zurita del CELAEE.

La UCPEJV cuenta con un amplio fondo bibliográfico y en soporte magnético que pondrá a disposición de este curso, se cuenta además con cassettes que abordan algunas de las temáticas que se tratan en el mismo, su uso favorecerá elevar el interés y la motivación de los cursistas.

7. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA

► Fundamentación teórica y metodológica del programa.

Desde una posición materialista dialéctica el programa del curso de capacitación se fundamenta en los principales aportes teóricos de la escuela histórico-cultural, donde se privilegia una concepción humanista y optimista del desarrollo, quedando dimensionadas como invariantes permanentes, en el enfoque del diagnóstico que se asume: la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, lo personal y lo contextual, lo interno y lo externo, lo actual y lo potencial.

- El desarrollo del programa contempla una participación interactiva, con un enfoque de continuas reflexiones y de debate científico, que permite articular coherentemente la práctica profesional con los elementos teóricos y metodológicos que sirven de soporte y que se van confirmando o renovando con el propio quehacer práctico y el modelo de diagnóstico educativo. Un espacio especial en cada contenido se le brinda a los componentes éticos y a las cualidades personales y profesionales que posibilitan el éxito del diagnóstico.
- En la evaluación tendrá un peso importante la valoración sistemática, permanente e integral de los cursistas. Culmina el curso con la defensa de un estudio de caso, trabajo que será orientado en el primer encuentro y confeccionado durante todo el desarrollo del mismo.

► Estructura del programa;

La duración del curso e superación y/o postgrado será de un encuentro mensual, 8 en total de 6h/c cada uno. Los cursistas se mantendrán vinculados laboralmente y asistirán al curso en el horario establecido (primer lunes del mes) La asistencia al mismo será un requisito importante de evaluación a medir.

Los cursistas recibirán un diploma que los acredite según la modalidad, postgrado o superación. El estudio independiente de los estudiantes es condición indispensable para el éxito del curso, teniendo en cuenta la importancia del tema, su complejidad y volumen así como la necesidad de una eficiente preparación de los mismos para su desempeño profesional.

EVALUACIÓN DEL CURSO:

De forma oral en los encuentros teóricos y en los encuentros prácticos se evalúa el resultado de la actividad.

CRONOGRAMA:

6h/c presenciales (Todos los primeros lunes del mes durante el actual curso escolar (A partir de Octubre-Mayo)

El resto del mes como no presencial, donde quedan orientados para trabajo independiente y profundización.

PLAN TEMÁTICO

1. Actualización en Diagnóstico
2. Diagnóstico Vs Evaluación
3. Discapacidad, nuevo concepto, nueva Clasificación. La CIF. Evolución histórica del concepto Retraso Mental. Décima edición AAMR (hoy AIDD)
4. Conceptualización y Determinación de las NEE
5. Metodología de Trabajo para el CDO. Etapas
6. Consideraciones teóricas y precisiones metodológicas para la realización de adaptaciones curriculares
7. El diagnóstico diferencial entre el retardo en el desarrollo psíquico (RDP) y el retraso mental (RM.). Conceptualización, Caracterización, Diagnóstico e Intervención
8. El informe psicopedagógico.

ANEXO 15 Síntesis de los contenidos del manual para el diagnóstico psicopedagógico integral de escolares con indicadores de retraso mental.

Está conformado por la siguiente **estructura**:

PRESENTACIÓN

El Perfeccionamiento de la Educación en general y de las distintas educaciones que conforman el sistema educativo cubano, en particular, condujo inevitable y coherentemente hacia un reordenamiento y reestructuración que no dejó ningún componente educativo sin su pertinente estrategia de perfeccionamiento. El trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO) de igual modo se ha visto durante la primera década del tercer milenio inmerso en un proceso de cambio que promueve la profundización y actualización del conocimiento, permite elevar la efectividad de la labor docente en los distintos centros. Y finalmente, brinda oportunidades extraordinarias para innovaciones orientadas al desarrollo de modalidades educativas de orientación y diagnóstico adecuadas, que conduzcan a decisiones acertadas acerca de la respuesta educativa y los apoyos que requieran cada uno de los niños que conforman el universo educativo. Todo ello, como parte de una concepción de educación integral que abarca la formación de la afectividad, la expresión artística, la interacción social y como meta un nivel aplicativo y creativo de aprendizaje expresado en un desarrollo integral de la personalidad. Para alcanzar tales propósitos, hay que entender al diagnóstico como parte del proceso educativo y asumir que éste es solo divisible para su comprensión y acercamiento cognitivo y nunca para implementarlo.

Las últimas investigaciones en la psicología y en la educación han dado como resultado, nuevas maneras de aplicar el enfoque bio-psico-social en el ámbito educativo desde sus fundamentos filosóficos y psicológicos, ello no exime al diagnóstico psicopedagógico.

Como consecuencia se asume necesariamente una etapa de transformaciones también en esta área. Así pues, ya no importa determinar diferencialmente el retraso mental de las dificultades de aprendizaje, sólo para determinar modalidad de atención, o prejuiciar posibilidades de aprendizaje o desarrollo como hasta hace algún tiempo, continúa siendo importante esta diferenciación pero para conseguir la obtención de todos los elementos personológicos y ambientales que en su interacción han determinado la actual expresión de los niveles de desarrollo en las tres dimensiones: biológica, psicológica y social; lo que, sin lugar a dudas, permitirá una adecuada y acertada decisión respecto a la respuesta educativa y apoyos individuales y colectivos que cada caso esté demandando.

En el caso del retraso mental, particularmente, resulta un tanto más difícil conseguir aplicar el modelo bio-psico-social al proceso de diagnóstico. Es posible que la causa esté relacionada con la manera arraigada de entender al retraso mental como un problema predominantemente clínico, de lo cual es responsable el modelo anterior que subyacía a las prácticas todavía recientes de diagnóstico. Pudiera ser también una causa significativa, la relacionada con las representaciones sociales y las actitudes ante la discapacidad y específicamente ante el retraso mental en todas las capas sociales, que no excluye a los propios

especialistas (psicólogos, psicopedagogos y pedagogos especializados en educación especial, otrora defectólogos)

En la primera parte de este manual se presenta, de manera general la evolución del modo en que se ha asumido y aplicado el diagnóstico del retraso mental en el mundo y en Cuba. En la segunda parte, se presenta el modelo que se propone, sus fundamentos y el modo de implementación.

En la tercera y última parte se proporciona el análisis de los instrumentos necesarios para identificar dificultades y potencialidades, interpretarlas y traducirlas en necesidades, para finalmente acopiar lo necesario para elaborar las respuestas educativas y seleccionar e implementar los apoyos. Se presentan y explican dos instrumentos para medir: Modos de actuación Social.

Estos elementos permitirán a los especialistas de los CDO fortalecer sus competencias profesionales para lograr aplicar el modelo bio-psico-social al diagnóstico psicopedagógico integral y se revele su carácter explicativo, socioeducativo e interventivo.

MARCO INSTITUCIONAL

A partir de la propuesta de la reconceptualización de la educación especial comenzada en la última década del siglo XX, ocurre en Cuba una reforma promovida en los subsistemas coordinados por el MINED se da un replanteamiento del enfoque psicopedagógico, el cual ha implicado la inserción del enfoque educativo basado en la aplicación (en este marco) de la concepción del ser humano en sus tres dimensiones: biológica, psicológica y social. De lo que se

derivan las actuales definiciones, investigaciones y prácticas educativas que justifican una redefinición de la educación especial como:

“Es la atención que se le brinda a una persona con necesidades educativas especiales con el fin de aproximarla a los objetivos socioeducativos propuestos por una sociedad que tiene la altísima responsabilidad de formar un hombre, reflejo de su época histórica.(...) El concepto de Educación Especial en la actualidad, más que un tipo de educación, implica toda una política educativa, una didáctica para personas con necesidades educativas especiales en cualquier contexto en que se encuentren...” (Orosco, 2008)

Los proyectos nacionales de investigación, auspiciados por el CELAEE y dirigido por las Dra.C. Sonia Guerra Iglesias y Caridad Zurita, consideraron necesario investigar acerca de cómo perfeccionar el proceso de diagnóstico del retraso mental a cargo en el ámbito educativo de los CDO. A partir de ahí la Ms.C.Mirtha Leyva Fuentes asume este compromiso como su proyecto de Tesis doctoral, del cual surge un modelo diseñado con tal finalidad.

Para poder implementarlo se utilizaron diferentes vías, una de ellas la creación de este material que provee de una visión general desde las teorías subyacentes y los modelos precedentes desarrollados en torno al tema, dado que lo consensuado y generalizado a nivel mundial acerca del modo de diagnóstico, la clasificación y la actualización conceptual del retraso mental como entidad es poco conocido todavía en Cuba. Se considera necesario tomar este conocimiento como punto de partida para adentrarse en la asimilación y comprensión del modelo que se propone. Este manual forma parte de la serie de documentos que

aunará y difundirá el CDO, desde el nivel central en su actual proceso fortalecimiento, junto a otros de igual valía

MARCO TEÓRICO. PRECISIONES CONCEPTUALES Y TERMINOLÓGICAS. RETRASO MENTAL. DIAGNÓSTICO EDUCATIVO INTEGRAL.

Se presenta un resumen de fundamentos teóricos que deben estar al alcance de los especialistas destinatarios del mismo. Los epígrafes que lo contienen son:

I. SINTESIS DE LA EVOLUCION DEL DIAGNOSTICO DE RETRASO MENTAL EN EL MUNDO Y EN CUBA

Evolución conceptual del retraso mental en el mundo.

Evolución conceptual del retraso mental en Cuba.

II. MODELO PARA EL DIAGNOSTICO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL DE ESCOLARES CON INDICADORES DE RETRASO MENTAL EN EL CDO.

Se presenta el modelo en su totalidad y se añaden precisiones metodológicas para su comprensión y aplicación por los especialistas de los Centros de Diagnóstico y Orientación

III. HERRAMIENTAS. ALGUNOS INSTRUMENTOS Y CUESTIONARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DEL RETRASO MENTAL

Se explica el sistema instrumental y se sugiere el uso de los dos instrumentos que lo enriquecen incluidos en el modelo propuesto. Para ello se presentan y explican.

CONCLUSIONES

- La modelación científica permitió la determinación y relación de los componentes del modelo que se propone, donde se destaca la interrelación entre la multidimensionalidad del retraso mental y su expresión en las fases de ejecución del proceso de diagnóstico psicopedagógico integral. con las cuales se pretende alcanzar una adecuada atención educativa integral. El modelo propuesto aporta elementos teóricos, metodológicos e instrumentales con los que se supera al actuante.
- Una adecuada comprensión y aplicación del modelo propuesto garantizará resultados superiores en el proceso de diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental, ya que este grupo de niños posee peculiaridades y regularidades que son necesarias identificar y que de ello depende la calidad de la atención educativa integral que requieren.

BIBLIOGRAFÍA

Contiene los documentos utilizados para su confección.

ANEXO 16 REGISTRO DEL TALLER DE OPINIÓN CRÍTICA

Criterios valorativos	Frases más significativas
Sobre la etapa de preparación (Curso y Manual)	“ El curso fue muy novedoso, Hacia mucha falta uno como este” “El nivel práctico del curso que nos permitía aplicar en situación real o hipotética, nos ayudó mucho” “El manual será mi biblia” “Es muy orientador el manual” “Con el manual bajo el brazo hay que llegar a las escuelas” “El manual ayuda a planificar la estrategia evaluativa” “Ayuda a conocer más sobre retraso mental” “también ayuda a los maestros a verlos con otros ojos”
Aplicabilidad	“Aún hay que mejorar el trabajo con la familia” “Faltó mayor tiempo de intercambio” “Hay que continuar capacitándose” El modelo puede aplicarse en cualquier parte” “Los factores comunitarios fue la principal debilidad” “A los padres les gustó participar como un evaluador más del BEDMAS” “Es más fácil cuando se aprovechan todas las etapas del trabajo del equipo, sobre todos las iniciales, mientras los niños están en sus escuelas y nosotros vamos allá y a sus hogares” “si se aprovecha cada espacio, en la etapa de cierre, queda poco por hacer y la discusión diagnóstica es más rica”
Logros y aprendizajes	“El niño participa dando información, opiniones y su visión y representación acerca de lo que le rodea” “Antes no intentábamos usarlo como agente proveedor de datos, a la vez que sujeto de evaluación” “La familia puede ser mejor aprovechada”

	“Las visitas a los centros escolares y casas de familia ahora tienen otro sentido “Las visitas del equipo asesor, también deben variar” “Aprendí que está prohibido <i>suponer</i> lo que no puede, hay que probar” “Aprendí que en el retraso mental, las dificultades para aprender se dan para aprender cualquier cosa, y esas otras cosas no docentes, no la explorábamos suficiente” “Hay que prepararse para el trabajo” “Quisiera saber más sobre cómo estar segura de que no nos estamos equivocando, este trabajo me acerca a eso” “Me mostraron cómo hacer la actividad diagnóstica más organizada”
Satisfacción personal	“Considero que puedo ser mejor especialista” “Me sentí satisfecha con el trabajo hecho durante este tiempo” “Mi trabajo ahora es mejor” “Me sentí satisfecha con el curso recibido” “Al principio no entendí para qué incluir docentes, ahora entiendo que eso puede ayudar a mejorar el diagnóstico y a que nos vean de otra forma”

Anexo 17 Resultados comparativos de la exploración del modelo actuante.

DIMENSIÓN I: Los escolares con indicadores de retraso mental

Indicadores	Total de planos	Parámetros	Cierre
<i>Para la subdimensión biológica</i>			
I. Desarrollo estructural y funcional del organismo	2	Si al cerrar: Los 2 B - BAJO 1 B y el otro M o A MEDIO 1 M y el otro A o los dos A - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
<i>Cierre de la subdimensión biológica</i>		<i>Ídem al parámetro del único plano de análisis</i>	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
<i>Para la subdimensión psicológica</i>			
I. Funcionamiento general	4	Si al cerrar: 1 B y 3 M O 2 B Y 2 M - MEDIO 3 M y 1 A o más de dos A. - ALTO	B <u> </u> M <u>X</u> A <u> </u>
II. Desarrollo cognoscitivo	5	Si al cerrar: 3 B y 2 M o A.- BAJO 2 B y 3 M o A.- MEDIO 3 M y 2 A o más de 3 A.- ALTO	B <u> </u> M <u>X</u> A <u> </u>
III. Zona de desarrollo próximo.	5	Si al cerrar: 3 B y 2 M o A.- BAJO 2 B y 3 M o A.- MEDIO 3 M y 2 A o más de 3 A.- ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
IV. Desarrollo socio-afectivo	7	Si al cerrar: 4 B y 3 M o A. - BAJO 3 B y 4 M o A - MEDIO 3 M y 4 A o más de 4 A. - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
V. Desarrollo Actitudinal	9	Si al cerrar: 5 B y 4 M o A.- BAJO 4 B y 5 M o A. - MEDIO 4 M y 5 A o más de 5 A. - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
<i>Cierre de la subdimensión psicológica</i>		Si los indicadores del I –V resultan: BAJO: 3 B y 2 M o A. MEDIO: Si 2 B y 3 M o .ALTO: Si 3 M y 2 A o más de 3 A.	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
<i>Para la subdimensión social</i>			
I. Desarrollo social	4	Si al cerrar: 3 B y 1 M o A. - BAJO 1 B y 3 M - MEDIO 3 M y 1 A o más de dos A. -ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
II. Desarrollo de la comunicación social	4	Si al cerrar: 3 B y 1 M o A.- BAJO 1 B y 3 M - MEDIO 3 M y 1 A o más de dos A. - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
III. Dominio de roles sociales a cumplir	4	Si al cerrar: 3 B y 1 M o A.- BAJO 1 B y 3 M MEDIO 3 M y 1 A o más de dos A. ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
IV. Desarrollo de la representación social	3	Si al cerrar: 2 B y 1 M o A. - BAJO 1 B y 2 M o A. - MEDIO 2 M y 1 A o más de dos A. - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
<i>Cierre de la subdimensión social</i>		Si los indicadores del I –IV resultan: 3 B y 1 M o A. - BAJO 2 B y 2 M o A. – MEDIO 2 M y 2 A o más de 3 A - .ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>

DIMENSIÓN II: Los especialistas de los CDO

Indicadores	Total de planos	Parámetros	Cierre
<i>Para la subdimensión Cognoscitiva</i>			
I. Dominio de la definición de retraso mental.	3	Si al cerrar: 2 B y 1 M o A. - BAJO 1 B y 2 M o A. - MEDIO 2 M y 1 A o más de dos A. - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
II. Dominio de la clasificación y terminología	2	Si al cerrar: Los 2 B - BAJO 1 B y el otro M o A MEDIO 1 M y el otro A o los dos A - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
III. Dominio metodológico del proceso de diagnóstico	3	Si al cerrar: 2 B y 1 M o A. - BAJO 1 B y 2 M o A. - MEDIO 2 M y 1 A o más de dos A. - ALTO	B <u> </u> M <u>X</u> A <u> </u>
IV. Desarrollo académico	3	Si al cerrar: 2 B y 1 M o A. - BAJO 1 B y 2 M o A. - MEDIO 2 M y 1 A o más de dos A. - ALTO	B <u> </u> M <u>X</u> A <u> </u>
<i>Cierre de la subdimensión Cognoscitiva.</i>		Si los indicadores del I–IV resultan: 3 B y 1 M o A. - BAJO 2 B y 2 M o A. – MEDIO 2 M y 2 A o más de 3 A - .ALTO	B <u> </u> M <u>X</u> A <u> </u>
<i>Para la subdimensión Ejecutiva</i>			
I. Habilidades metodológicas para el diagnóstico	8	Si al cerrar: 5 B y 3 M o A. - BAJO 5 B y 3 M o A - MEDIO 5 M y 3 A o más de 4 A.. - ALTO	B <u> </u> M <u> </u> A <u>X</u>
II. Habilidades en la confección del informe	11	Si al cerrar: 6 B y 5 M o A.- BAJO 6 B y 5 M o A. - MEDIO 6M y 5 A o más de 5 A. - ALTO	B <u> </u> M <u> </u> A <u>X</u>
<i>Cierre de la subdimensión Ejecutiva.</i>		Si los indicadores resultan: Los 2 B - BAJO 1 B y el otro M o A MEDIO 1 M y el otro A o los dos A - ALTO	B <u> </u> M <u> </u> A <u>X</u>
<i>Para la subdimensión afectivo-motivacional</i>			
I. Actitud ante la influencia de elementos predisponentes y anticipatorios	2	Si al cerrar: Los 2 B - BAJO 1 B y el otro M o A MEDIO 1 M y el otro A o los dos A - ALTO	B <u> </u> M <u>X</u> A <u> </u>
II. Actitud ante la discapacidad	5	Si al cerrar: 3 B y 2 M o A.- BAJO 2 B y 3 M o A.- MEDIO 3 M y 2 A o más de 3 A.- ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
III. Actitud ante el retraso mental	6	Si al cerrar: 4 B y 2 M o A. - BAJO 3 B y 3 M o A - MEDIO 3 M y 3 A o más de 4 A. - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>
<i>Cierre de la subdimensión afectivo-motivacional</i>		Si los indicadores del I–III resultan: 2 B y 1 M o A. - BAJO 1 B y 2 M o A. - MEDIO 2 M y 1 A o más de dos A. - ALTO	B <u>X</u> M <u> </u> A <u> </u>

DIMENSIÓN I: Evaluación de los escolares con indicadores de retraso mental. Resultado comparativo.

Indicadores	Cantidad de planos por categoría. Antes.			Cantidad de planos por categoría. Después		
	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
<i>Subdimensión biológica</i>						
I. Desarrollo estructural y funcional del organismo	1	1		1	1	
Cierre de la subdimensión biológica	1	1		1	1	
<i>Subdimensión psicológica</i>						
I. Funcionamiento general	2	2		1	3	
II. Desarrollo cognoscitivo	2	2	1		2	3
III. Zona de desarrollo próximo.	5				2	3
IV. Desarrollo socio-afectivo	5	2			5	2
V. Desarrollo Actitudinal	9				8	1
Cierre de la subdimensión psicológica	23	6	1	1	20	9
<i>Subdimensión social</i>						
I. Desarrollo social	4			2	2	
II. Desarrollo de la comunicación social	3	1			2	2
III. Dominio de roles sociales a cumplir	4				2	2
IV. Desarrollo de la representación social	3				3	
Cierre de la subdimensión social	14	1		2	9	4
Totales en la DIMENSIÓN	38	8	1	4	30	13

DIMENSIÓN II: Los especialistas de los CDO. Resultado comparativo.

Indicadores	Cantidad de planos por categoría. Antes.			Cantidad de planos por categoría. Después		
	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
<i>Para la subdimensión Cognoscitiva</i>						
I. Dominio de la definición de retraso mental.	1		2		1	2
II. Dominio de la clasificación y terminología	2					2
III. Dominio metodológico del proceso de diagnóstico		1	2			3
IV. Desarrollo académico	1	1	1	1	1	1
Cierre de la subdimensión Cognoscitiva.	4	2	5	1	2	8
<i>Para la subdimensión Ejecutiva</i>						
I. Habilidades metodológicas para el diagnóstico	1	1	6		1	7
II. Habilidades en la confección del informe		3	8			11
Cierre de la subdimensión Ejecutiva	1	4	14		1	18
<i>Para la subdimensión afectivo-motivacional</i>						
I. Actitud ante la influencia de elementos predisponentes y anticipatorios		2				2
II. Actitud ante la discapacidad	3	2			3	2
III. Actitud ante el retraso mental	4	2			3	3
Cierre de la subdimensión afectivo-motivacional	7	6			6	7
Totales en la DIMENSIÓN	12	12	19		9	33

Anexo18 Comparación entre el modelo actuante y el modelo propuesto

Modelo actuante	Modelo que se propone
<u>Postura epistemológica</u> Escuela Histórico-Cultural	<u>Postura epistemológica</u> Escuela Histórico-Cultural
<u>Concepto central</u> Proceso de diagnóstico y evaluación, que se da en tres dimensiones: 1) De las edades temprana y preescolar, 2) Escolar y 3) Especializado	<u>Concepto central</u> Diagnóstico psicopedagógico integral. Como proceso único.
<u>Escenario</u> Definidos para cada dimensión del concepto central	<u>Escenario</u> (Todos) Locales del CDO, Aulas y escuelas de la EGPL y media. Contextos(familiares y comunitarios)
<u>Fin.</u> Conformar la atención educativa integral para cada individuo, grupo o parte del proceso pedagógico, que sea objeto de estudio.	<u>Fin</u> Conformar la atención educativa integral para cada individuo, grupo o parte del proceso pedagógico, que sea objeto de estudio.
<u>Principios:</u> El carácter preventivo, retroalimentador y transformador. El enfoque dinámico, continuo y sistemático. El enfoque multi e interdisciplinario. El enfoque Individual y multilateral. El enfoque científico y objetivo.	<u>Principios:</u> Los mismos. Y adjunta 1) los de Akudovich, 2004, que son: El estudio de las potencialidades del desarrollo de los alumnos en el proceso de la actividad de diagnóstico. La unidad entre la actividad y comunicación en el proceso de diagnóstico de la zona de desarrollo próximo. 2) Otros tres que propone la autora El enfoque multidimensional del retraso mental El carácter dinámico y variable de la expresión de discapacidad. El principio de la vinculación de las familias y la comunidad y del carácter activo de su participación en el proceso de diagnóstico psicopedagógico.
<u>Pares categoriales</u> diagnóstico- estrategia de atención educativa Potencialidades-necesidades diagnóstico-evaluación <u>Otras categorías:</u> Prevención Caracterización psicopedagógica Estrategia de atención educativa	<u>Pares categoriales</u> Ídem.
<u>Elementos que se exploran</u> Relativas a los escolares objetos de estudio: <u>Relativas a los examinadores</u> <u>Relativas a las condiciones</u>	<u>Elementos que se exploran</u> Del modelo actuante se mantienen los elementos que en él se declaran y que se ajustan a las subdimensiones del modelo propuesto. Sin embargo relativas a los escolares, se añaden nuevos elementos como el actitudinal y se detalla como abordar habilidades sociales.

	Asimismo, respecto a los especialistas se adicionan elementos actitudinales. Las relativas a las condiciones se mantienen.
<u>Modelo teórico del retraso mental</u> Modelo Orientación Histórico-cultural. Que se basa en el criterio Psicopedagógico que tiene en cuenta la diferenciación y potenciación del desarrollo y el elemento funcional.	<u>Modelo teórico del retraso mental</u> Lo mantiene, particulariza sus 5 dimensiones desde una visión histórico cultural y una postura electiva de la ciencia.
<u>Sistema instrumental</u> Tradicional que está definido para cada especialidad en el libro El trabajo de los CDO Col autores del MINED	<u>Sistema instrumental</u> Mantiene el tradicional que está definido para cada especialidad en el libro El trabajo de los CDO Col autores del MINED e incorpora nuevos instrumento: Registro de evaluación de indicadores de la preparación para la vida cotidiana escolares con retraso mental de Nilda de la Peña y BEDMAS . Batería para medir los modos de actuación social y baterías estandarizadas para medir actitudes. Reconstruye el marco metodológico en 4 fases a las que precisa los propósitos, tareas, herramientas y decisiones a tomar.
<u>Criterios diagnósticos:</u> 1) Insuficiencia general en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores. 2) Significativo compromiso en la actividad cognoscitiva causada por afectación importante en el sistema nervioso central por factores genéticos, biológicos o de infraestimulación socio-ambiental. 3) Compromiso funcional en dependencia de la afectación en el sistema nervioso central, la situación social del desarrollo y la oportuna estimulación, y se añade:	<u>Criterios diagnósticos:</u> 1) Insuficiencia general en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores. 2) Significativo compromiso en la actividad cognoscitiva causada por afectación importante en el sistema nervioso central por factores genéticos, biológicos o de infraestimulación socio-ambiental. 3) Compromiso funcional en dependencia de la afectación en el sistema nervioso central, la situación social del desarrollo y la oportuna estimulación, y se añade: 4) Presencia de limitaciones significativas en las manifestaciones y desarrollo de los modos de actuación social.

Anexo 19 Resultados de las observaciones luego de la implementación.

Resultados de observaciones diagnóstico final

En cuanto a la *correspondencia entre la estrategia de diagnóstico y el contenido de la sesión observada* en las observaciones realizadas a sesiones de evaluación en la sede del CDO fue total en el 100% de los casos, tanto para las realizadas en el local sede como para las observadas en los contextos naturales.

El *cumplimiento del objetivo* de la evaluación en el 100% de las observaciones se dio totalmente.

En el 100% de las sesiones de evaluación se *manejaron adecuadamente las situaciones* surgidas mediante la utilización de recursos profesionales para su manejo.

En relación a la *adecuación de las técnicas a las características del caso*, en el 75% de los casos se pudo observar que luego del registro de la evaluación de la tarea, sub test o ítem como lo indica la metodología estándar de la prueba, se introducía una demostración y se repetía para valorar posibilidad de aprendizaje, y zona potencial, que luego reflejaban en el análisis cualitativo y consideraban en la discusión diagnóstica.

El 100% de los especialistas mostraron *habilidades comunicativas* adecuadas con los menores evaluados y con sus familias, así como para lograr la cooperación, disposición y participación de los escolares, sus familias u otros agentes educativos.

Al considerar si los especialistas alcanzan los *niveles de motivación en los niños*, se aprecian que el cien por ciento. Se repartió en un 75% de motivación en la categoría Adecuada y el 25% en Parcialmente adecuada. Se estima que las causas estén relacionadas con el trabajo de asesoramiento a docentes que se hizo en las escuelas acerca de la presencia de los especialistas del CDO, a quienes reciben con beneplácito y hasta les solicitan ayuda.

Además se hicieron acciones con vistas a que se eliminaran actitudes como amenazar con el CDO o con tener que ir a la escuela especial.

Se comienzan a ver en algunas de las observaciones (30%) que se realizaron acciones, emplearon *técnicas o metódicas para explorar la creatividad, potencialidades y experiencia* de los menores evaluados. (Pedir que se expresen mediante el dibujo libre u otras manualidades; pedir que conteste a las preguntas un títere en lugar del propio niño etc.

El soporte material para la evaluación es deficiente, no siempre se cuenta con el material original. Se observaron copias e imitaciones muy creativas, pero que al menos resuelven la carencia material de los sets de pruebas, con los que no cuenta el país.

Ya no se pudo observar 0% acciones de anticipación al resultado por parte de los especialistas, como detener la prueba. Aún cuando estuviera previsto en la metodología de aplicación, se cerró en el registro pero se insistió con la introducción de niveles de ayuda, lo que enriqueció el análisis cualitativo.

Aunque las acciones que demuestran actitudes ante la discapacidad no pierden el carácter espontáneo e inconsciente, como resultado del crecimiento personal se manifestaron poquísimas reacciones típicas de indiferencia o rechazo ante la discapacidad; así como se eliminaron frases como “Este va directo para la escuela de retraso” “Este es mongó, en su familia hay cantidad de retrasados” “este seguro no va a aprender a leer” “Dicen que esta niña parece hija mía ¡Dios me libre!” “Yo conozco a su mamá ¡la pobre!” o de indiferencia como “Este caso está perdido pero nadie tiene la culpa” “Al final, el problema no es mío, sino de sus padres” “¡Allá los pobres maestros que le toque!” Sorprendieron el uso de otras como: “Esta niña necesita más ayuda”, “Vamos a cambiarla con la maestra X y verás como al menos sale de esta fase estancada” “La culpa es de su maestra que equivocadamente se sentó a esperar por la escuela especial y el siguiente curso” “Aunque vaya para la escuela especial, en este curso tiene que evolucionar con respecto al inicio”

En cuanto al criterio para valoraciones de cierre parcial, se comportó de la siguiente manera:

Integral y cualitativa 0 %	Cualitativa y fragmentada 5%
Integral y cuantitativa 95%	Cuantitativa y fragmentada 0%

En lo referido a cuáles momentos eran implementados verdaderamente en equipo, se mantuvo que sólo el cierre final, pero en el 100% ocurrió con la totalidad de los miembros.

La calidad general de la sesión observada en el 10 % de los casos fue parcialmente adecuada y en un 90 % adecuada. Los casos parciales corresponden con especialistas noveles o no docentes (trabajadores sociales o psicometristas)

Toda esta información se analizó no solo a partir del instrumento de evaluación, sino que se encontraron regularidades por *planos de análisis*:

Funcionamiento general: Los especialistas observados al finalizar la sesión en su generalizan acerca de los datos obtenidos, lo relacionado con el estado global de la actividad cognoscitiva y el estado emocional volitivo en los escolares objeto de estudio. Este último centrado en los elementos comportamentales como los niveles de colaboración y estado emocional aparente.

Desarrollo cognoscitivo: Aunque en este plano de análisis se obtuvieron mejores resultados con respecto a los otros, en el momento de cierre se comenzó a indagar en aquellas habilidades que por su estructura interna no están logradas pero tienen un desarrollo potencial, también las habilidades comunicativas antes no indagadas.

Zona de desarrollo próximo: Comienzan a emplearse los criterios evaluativos para evaluar la zona de desarrollo próximo que ya estaban en el modelo actuante pero para los cuales los especialistas no estaban totalmente preparados; aunque aún se observaron dificultades para el análisis del estado de la transferencia de la ayuda.

Desarrollo socio-afectivo: Se comienzan a utilizar técnicas y tareas con el objetivo de evaluar en los escolares elementos socio-afectivos como: la reacción ante la crítica, ante las normas y límites, antes pasados por alto, aprovechando las observaciones que le hacen en los contextos naturales.

Respecto al *Desarrollo Actitudinal:* Se comienzan a dar avances con el empleo por los especialistas durante el proceso, de técnicas sencillas de

autovaloración y valoración, así como preguntas intencionalmente dirigidas a ellos en la entrevista. En el resto de los planos de análisis, pertenecientes a la subdimensión social, no se pueden establecer comparaciones, pues antes de la implementación no se abordaban. Luego, de eso se recogieron datos que se sintetizan a continuación:

Respecto al *Desarrollo social y de la comunicación social*: En estos planos a través de la observación y de entrevistas realizadas al propio escolar, así como mediante la utilización de la prueba BEDMAS se obtuvo información rigurosa y concluyente. Aquí resultó significativa la diferencia entre aquellos escolares a quienes se les confirmó el retraso mental y los que quedaron descartados. En este último grupo no se encontraron elementos significativos, mientras que en el primero se revelaron dificultades en los aprendizajes sociales, luego confirmadas por los familiares mediante la entrevista intencionada.

Anexo 20 Guía para la encuesta a expertos

Estimado Colega:

Valorando su alto nivel de desarrollo, vasta experiencia, la compatibilidad que con el tema ofrece el desempeño de sus funciones actuales y su competencia profesional, concedemos suma importancia a su criterio, siendo usted seleccionado como experto en la temática que aborda la Tesis: “Un modelo para el diagnóstico psicopedagógico integral a escolares con indicadores de retraso mental en el CDO”, Tesis en opción al grado de doctor en ciencias pedagógicas de la Ms.C. Mirtha Leyva Fuentes.

La aspirante pretende aprovechar sus criterios en pos de validar de forma preliminar el modelo de diagnóstico psicopedagógico que se propone. Somete a su valoración el Manual diseñado para socializar el modelo propuesto con los usuarios del mismo, es decir: los especialistas de los Centros de diagnóstico y Orientación durante la etapa de implementación práctica del mismo. En él se ofrecen algunos supuestos teóricos y las orientaciones metodológicas encaminadas a perfeccionar el diagnóstico como proceso.

Rogamos que lea detenidamente el manual y la encuesta que a continuación le presentamos. La misma contiene formulados los criterios en forma de interrogantes o argumentos y, en casos necesarios, se expresan de forma explícita los indicadores a tener en cuenta. Al final aparece una tabla que muestra en las columnas los criterios a valorar y en las filas las categorías en las que usted debe situar cada criterio según su sabio parecer.

La aspirante

Los criterios a tener en cuenta son los siguientes:

1. **Actualidad:** La educación como ciencia, en las últimas décadas, y dentro de ella, la educación especial y la práctica de diagnóstico psicopedagógico, han sufrido vertiginosos cambios. ¿Considera que el modelo que explica y presenta el manual se corresponde con los supuestos teóricos y las prácticas: educativa y de diagnóstico actuales?
2. **Organización y coherencia:** Valore la estructura del modelo propuesto atendiendo a la lógica entre sus componentes y a cómo se relacionan unos con otros, Considere si hay coherencia, tanto en el análisis del diagrama y del esquema gráfico que lo concretan, como en las explicaciones que se ofrecen, y tenga en cuenta además, el nivel de científicidad, interdisciplinariedad y el uso del vocabulario técnico.
3. **Accesibilidad:** Valore el nivel de accesibilidad que permite el manual a sus usuarios a partir del análisis del lenguaje utilizado y el grado de comprensión de lo expuesto.
4. **Flexibilidad:** Valore el nivel de flexibilidad que contiene el manual. Entendiendo como flexible: (1) Que las aseveraciones se acompañen de las diferentes vertientes y argumentaciones inherentes y de un análisis crítico y (2) Que las orientaciones o recomendaciones posibiliten al especialista ajustar sus criterios, sin privarlos de la posibilidad de elección y creatividad.
5. **Alcance:** ¿Logra el modelo abarcar la variedad de cuestiones inherentes al proceso de diagnóstico psicopedagógico que dirigen los especialistas de los CDO? Valore aquí que toda situación posible que pudiera darse en este proceso ha sido prevista y tratada metodológicamente para su dominio adecuado por los usuarios.

6. **Correspondencia:** ¿Considera que el modelo está en correspondencia con el sistema educativo cubano, el proceso de perfeccionamiento del trabajo de los CDO a nivel nacional y con las necesidades concretas que presentan los escolares con indicadores de retraso mental y sus familias? Valore si se tiene en cuenta la estructura del sistema educativo, y si permite aprovechar las posibilidades que brinda el sistema de trabajo.
7. **Funcionalidad:** Valore la funcionalidad-aplicabilidad que propicia el modelo. Aquí debe centrar su atención en las posibilidades que éste ofrece para su aplicación, que justifique en sí mismo su existencia.

Criterios valorativos	Categorías ordinales			
	Ca-1	Ca-2	Ca-3	Ca-4
	Muy adecuado	Adecuado	Poco adecuado	No adecuado
C-1 Actualidad				
C-2 Coherencia				
C-3 Accesibilidad				
C-4 Flexibilidad				
C-5 Alcance				
C-6 Correspondencia				
C-7 Funcionalidad				

Anexo 21. Aplicación del delphi a la consulta a expertos.

Modelo para el diagnóstico psicopedagógico integral de escolares con indicadores de retraso mental en el CDO.

Tabla de frecuencias registradas a 31 expertos:

Pasos para la Metodología	Ca1 Muy adecuado	C2 Adecuado	C3 Poco adecuado	C4 No adecuado	TOTAL
C-1	26	5	-	-	31
C-2	28	3	-	-	31
C-3	23	8	-	-	31
C-4	19	12	-	-	31
C-5	21	10	-	-	31
C-6	20	11	-	-	31
C-7	30	1	-	-	31

Tabla de frecuencias acumuladas:

	Ca-1	Ca-2	Ca-3	Ca-4
C-1	26	31	31	31
C-2	28	31	31	31
C-3	23	31	31	31
C-4	19	31	31	31
C-5	21	31	31	31
C-6	20	31	31	31
C-7	30	31	31	31

Tabla de frecuencias relativas acumulativas.

	C-1	C-2	C-3
C-1	0.8387	1	1
C-2	0.9032	1	1
C-3	0.7419	1	1
C-4	0.6129	1	1
C-5	0.6774	1	1
C-6	0.6451	1	1
C-7	0.9677	1	1

Imágenes de la inversa de la curva normal de cada uno de los valores de las celdas de la tabla de frecuencias acumuladas relativas:

	C-1	C-2	Suma	Promedio	N-P
C-1	0,99	3,09	4,08	2,04	- 0,07
C-2	1,30	3,09	4,39	2,18	- 0,21
C-3	0,65	3,09	3,74	1,87	+ 0,10
C-4	0,29	3,09	3,38	1,69	+ 0,28
C-5	0,46	3,09	3,55	1,77	+ 0,20
C-6	0,37	3,09	3,46	1,73	+ 0,24
C-7	1,85	3,09	4,94	2,47	- 0,50
Suma	5,91	21,63	27,54	N = 1,97	
Puntos de corte	0,84	3,09			

Cálculo de N:

$$N = 27,54 / 7 \times 2 = 1,97$$

De donde los rangos tipificados quedan:

MUY ADECUADO	0,84	ADECUADO	3,09	POCO ADECUADO
--------------	------	----------	------	---------------

De acuerdo con la escala anterior, los aspectos consultados a los expertos por el investigador, tienen las siguientes categorías tipificadas.

CRITERIOS	CATEGORÍAS
1	MUY ADECUADO
2	MUY ADECUADO
3	MUY ADECUADO
4	MUY ADECUADO
5	MUY ADECUADO
6	MUY ADECUADO
7	MUY ADECUADO

Anexo 22. Guía para las etapas de implementación del modelo.

A continuación se declaran las *acciones* que se deben ejecutar para cada una de las etapas.

ETAPA DE PREPARACIÓN:

- Diagnóstico de los conocimientos que tienen los especialistas los CDO acerca de los fundamentos del proceso de diagnóstico educativo en general y de los casos con indicadores de posible retraso mental en particular.
- Determinación y desarrollo de las actividades de capacitación necesarias para que adquieran el nivel teórico–metodológico requerido para acometer esta tarea. Para ello la autora elaboró e impartió un curso dirigido a ellos con el fin de ajustar en el orden teórico el respaldo o plataforma que la implementación requiere. Además se confeccionó un manual dirigido a los especialistas en donde se presenta y explica detalladamente el modelo.
- Discusión con los especialistas acerca del modelo elaborado, propiciando un debate enriquecedor de la propuesta a partir de la reflexión colectiva. Talleres de de reflexión y de opinión crítica.
- Planificación y organización del proceso de introducción del modelo propuesto, para implementarlo en la labor que se realiza en los CDO relacionada con el diagnóstico educativo integral de los casos con indicadores de posible retraso mental.

ETAPA DE INTRODUCCIÓN:

- Ejecución del proceso de diagnóstico educativo integral de los casos con indicadores de posible retraso mental.
- Creación de un clima propicio para el trabajo colectivo que permita la asimilación, la difusión y la generalización de las nuevas experiencias que se adquieran en el proceso, mediante reuniones mensuales de los equipos del grupo estudio.
- Solución de las nuevas contradicciones que se deriven de la aplicación del modelo a partir de la discusión colectiva de las mismas.
- Debate de las diferentes propuestas que se diseñen para su valoración colectiva, con el objetivo de perfeccionarlas y adaptarlas a las condiciones específicas de cada equipo.
- Sistematización de las incidencias que puedan resultar de interés, para el perfeccionamiento continuo del modelo propuesto.

ETAPA DE EVALUACIÓN:

- Valoración crítica de la utilidad de cada uno de los componentes del modelo y de sus relaciones para el diagnóstico educativo integral de los casos con indicadores de posible retraso mental.
- Realización de los ajustes necesarios al modelo a partir de los resultados de su utilización práctica.
- Socialización del modelo perfeccionado en su etapa de evaluación.

Conviene aclarar que existe una relación estrecha entre las etapas de investigación y las de implementación del modelo. La etapa de preparación tiene su comienzo en la segunda etapa investigativa que se enmarca en la segunda tarea. Tal es así, que al concluir la sistematización teórica que permitió la determinación de la variable, dimensiones, indicadores y su parametrización se determinaron las necesidades de los especialistas de los CDO a partir del diagnóstico aplicado con este fin a este grupo, lo que se corresponde con la primera tarea, luego al determinar y desarrollar las actividades de capacitación, a la vez que se trabajó con ellos, se iban rediseñando los componentes del modelo hasta su total confección como cumplimiento de la tercera tarea. Finalmente, las etapas segunda y tercera de la implementación sirvieron con un alto nivel de confiabilidad para la valoración de la factibilidad del modelo propuesto previsto en la cuarta tarea científica.

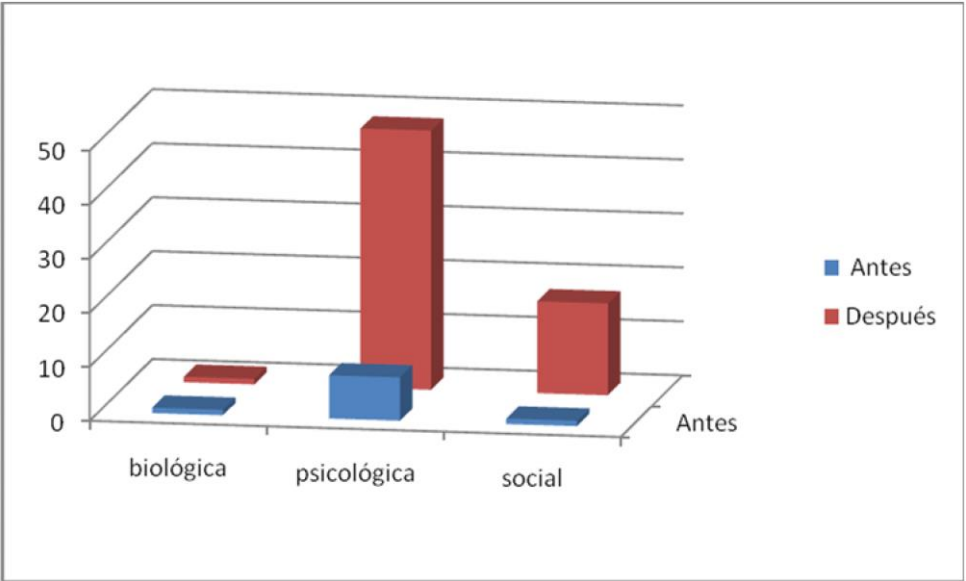
Anexo 23. Análisis estadístico comparativo de los parámetros medidos para cada dimensión antes y después de la sistematización en la práctica.

Para realizar un análisis estadístico que permitiera la comparación cuantitativa de los resultados expuestos anteriormente se cuantificó la categoría otorgada a los indicadores de la siguiente manera: al alto se le otorga 2 puntos; al medio, 1 punto y al bajo no se le otorga puntuación. De esta manera, la muestra puede ser comparada mediante la evolución o no de la media aritmética. En este sentido, las tablas comparativas por media pueden mostrarse así:

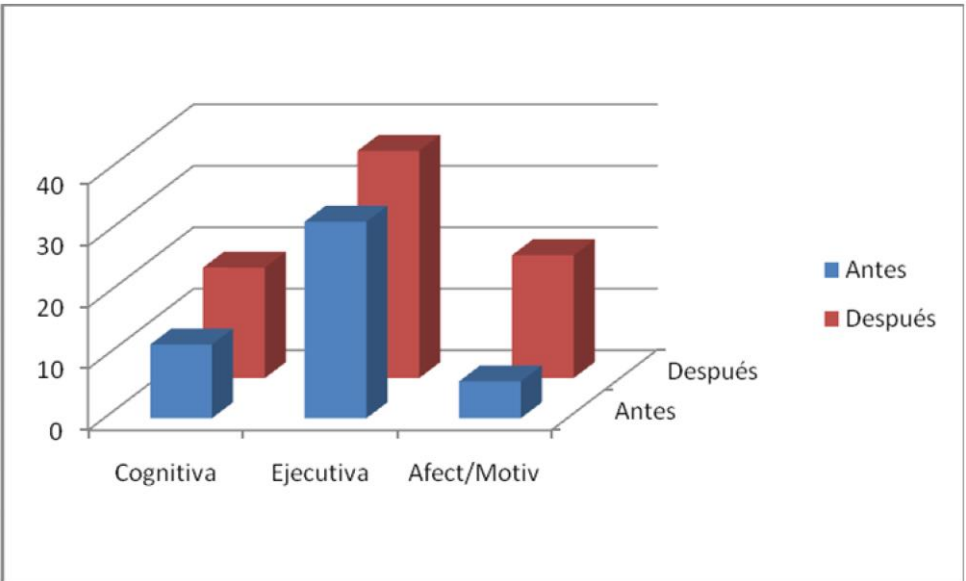
DIMENSIÓN I Indicadores	Antes	Después	Evolución
Subdimensión biológica			
I. Desarrollo estructural y funcional del organismo	1	1	0
Cierre de la subdimensión biológica	1	1	0
Subdimensión psicológica			
I. Funcionamiento general	2	3	1
II. Desarrollo cognoscitivo	4	8	4
III. Zona de desarrollo próximo.	0	8	8
IV. Desarrollo socio-afectivo	2	9	7
V. Desarrollo Actitudinal	0	10	10
Cierre de la subdimensión psicológica	8	48	40
Subdimensión social			
I. Desarrollo social	0	2	2
II. Desarrollo de la comunicación social	1	6	5
III. Dominio de roles sociales a cumplir	0	6	6
IV. Desarrollo de la representación social	0	3	3
Cierre de la subdimensión social	1	17	16
Totales en la DIMENSIÓN I	10	66	56

DIMENSIÓN II Indicadores	Antes	Después	Evolución
<i>Para la subdimensión Cognoscitiva</i>			
I. Dominio de la definición de retraso mental.	4	5	1
II. Dominio de la clasificación y terminología	0	4	4
III. Dominio metodológico del proceso de diagnóstico	5	6	1
IV. Desarrollo académico	3	3	0
Cierre de la subdimensión Cognoscitiva.	12	18	6
<i>Para la subdimensión Ejecutiva</i>			
I. Habilidades metodológicas para el diagnóstico	13	15	2
II. Habilidades en la confección del informe	19	22	3
Cierre de la subdimensión Ejecutiva	32	37	5
<i>Para la subdimensión afectivo-motivacional</i>			
I. Actitud ante la influencia de elementos predisponentes y anticipatorios	2	4	2
II. Actitud ante la discapacidad	2	7	5
III. Actitud ante el retraso mental	2	9	7
Cierre de la subdimensión afectivo-motivacional	6	20	14
Totales en la DIMENSIÓN II	60	75	15

La comparación anterior permite utilizar diferentes gráficos para clarificar la evolución
Por dimensiones, en aras de sintetizar las comparaciones, podría mostrarse:
Para la DIMENSIÓN I:



Para la DIMENSIÓN II:



**Anexo 24 Indicadores de posible retraso mental. IPRM. Tesis doctoral.
Travieso Leal E. 2008.**

Para el 1er año de vida:

Área sensorio – motriz: Débil reflejo de orientación hacia el lugar de donde proviene algún estímulo llamativo, ya sea sonoro o visual y ausencia de actitud selectiva. **Área motriz:** Cierta grado de hipotonía. Lentitud, debilidad, falta de coordinación e inestabilidad en los movimientos. Inestabilidad en el equilibrio. Retardo significativo (de uno a dos años) del desarrollo de habilidades motrices finas como por ejemplo, la pinza digital. Retardo significativo (de uno a dos o tres años) en la adquisición de la marcha independiente. El desarrollo psicomotor, irregular e inarmónico. **Área cognoscitiva:** Desinterés o interés breve e inestable por las personas y por los objetos que lo rodean. **Área comunicación y lenguaje:** Dificultades para interpretar señales comunicativas. Emisión de sonidos sin referirse a objetos o situaciones concretas. Vocalización pobre, gutural, de tono agudo y débil. Reacción inconstante ante palabras familiares. **Área afectivo – volitivo – emocional:** Generalmente se retarda la formación del complejo de animación.

2do Y 3er años:

Área motriz: Lentitud, debilidad, falta de coordinación e inestabilidad en los movimientos. Marcha independiente torpe e insegura. Inestabilidad en el equilibrio. **Área cognoscitiva:** Mantienen desinterés o un interés breve e inestable por las personas y por los objetos que lo rodean. Escasa manipulación de objetos. **Área de la sociabilidad:** Paulatinamente comienzan a relacionarse con otros adultos y con los coetáneos más cercanos. Muchos de

ellos logran establecer relaciones con personas desconocidas. **Área afectivo – volitivo – emocional:** Sensibilidad para captar los estados emocionales de las personas que lo rodean. Muy limitada comprensión de las funciones de los objetos. Acciones estereotipadas no dirigidas a un fin determinado. **Área del lenguaje:** Alteraciones en la percepción fonemática. Pronuncia algunas palabras y frases sencillas.

4to Y 5to años:

Área motriz: Marcha independiente más segura que en la etapa anterior. Corre y puede saltar con los dos pies al mismo tiempo. **Área cognoscitiva:** Interés breve e inestable por los objetos, análisis pobre de ellos. Dificultades en la comprensión de las propiedades y funciones de los objetos, lo cual logran solamente con ayuda y de forma limitada. Dificultades para determinar y diferenciar los patrones sensoriales (forma, tamaño y color) de los objetos, lográndolo, como máximo, entre dos elementos bien distintos. No identifica las posiciones derecha e izquierda, arriba y abajo, dentro y fuera, dificultándosele la orientación y relaciones espaciales. Inseguridad para construir torres con dos o tres piezas sin que se caigan. Repetición de acciones, no dirigidas a un fin determinado. Ausencia de generalizaciones elementales. **Área del lenguaje:** Dificultades para expresar lo que quiere. Dificultades en la comprensión del lenguaje, limitándose esta a situaciones concreta dentro del marco del lenguaje cotidiano. Pobreza del vocabulario pasivo y activo, es decir, conoce y articula pocas palabras. Inconsistencia en respuestas a preguntas simples. **Área afectivo – volitivo – emocional:** Susceptibilidad ante las frustraciones. Actitudes afectivas o agresivas. **Área de la sociabilidad: En el juego:** Interés precario y eventual por los juguetes. Manipulación inespecífica del juguete.

Dificultades para asumir roles en el juego. Dificultades para establecer relaciones con otros niños en el juego. **En la conducta social:** Dificultades para establecer relaciones con los adultos. Actúan motivados por las orientaciones de los adultos más que por considerarlo necesario, reflejando dependencia del adulto.

6to año:

Área motriz: Camina y corre con seguridad y puede saltar con los dos pies al mismo tiempo o con uno primero y otro después. **Área cognoscitiva:** Serias dificultades en la comprensión de las orientaciones espaciales. Incapacidad para la realización de acciones por etapas. Inconsistencia en el nivel de ejecución de las actividades. Dificultades en el desarrollo de operaciones con conjuntos, tales como reconocimiento, identificación, comparación, unión y descomposición de conjuntos. Solución efectiva de tareas fundamentalmente en el plano de las acciones. Dificultades para asumir la representación de un personaje en el juego de roles. Asimilación en ocasiones de la ayuda para solucionar un problema, pero se le dificulta transferirla a situaciones nuevas. Dificultades para comprender y por tanto ejecutar órdenes sujetas a reglas. Comprensión de órdenes sencillas y prohibiciones. Expresión de frases cortas de una o dos palabras en situaciones concretas. Empleo de frases sin sentido, que muchas veces no tienen relación con lo que realiza. Déficit articulatorio. Dificultades para captar mensajes emitidos por el adulto mediante miradas, gestos, tonos de voz, órdenes verbales. **Área afectivo – volitivo – emocional:** Perseverancia y voluntariedad. **Área de la sociabilidad: En el juego:** Interés precario y eventual por los juguetes. Manipulación no específica del juguete.

Dificultades para asumir roles en el juego. Dificultades para establecer relaciones con otros niños durante el juego.

El comportamiento social: Dificultades para establecer relaciones con los adultos. Actúan motivados por las orientaciones de los adultos más que por considerarlo necesario, reflejan dependencia del adulto.